

**[<g>] PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔ TẢ- PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG [</g>]**

Các loại thiết kế nghiên cứu dịch tễ học mô tả gồm:

- A. Mô tả một trường hợp bệnh đơn lẻ hiếm gặp, mô tả một chùm bệnh
- B. Mô tả tương quan
- C. Điều tra ngang
- D. Tất cả các thiết kế trên

[
]

Nghiên cứu dịch tễ học mô tả có những nhược điểm sau, TRỪ:

- A. Không thể xác định trật tự liên quan giữa phơi nhiễm và bệnh
- B. Không kiểm định được giả thiết
- C. Không chứng minh được giả thiết
- D. Không thiết lập được giả thiết

[
]

Nghiên cứu mô tả là nghiên cứu các vấn đề sau, TRỪ:

- A. Sự phân bố bệnh tật hay 1 vấn đề sức khỏe
- B. Các yếu tố liên quan tới quy định sự phân bố 1 vấn đề sức khỏe
- C. Mức độ, phạm vi của một vấn đề sức khỏe
- D. Kiểm định 1 giả thiết nhất định

[
]

Nghiên cứu dịch tễ học mô tả được sử dụng với mục đích sau, TRỪ:

- A. Đánh giá chiều hướng của sức khỏe cộng đồng
- B. Lập kế hoạch và đánh giá các dịch vụ y tế dựa trên cơ sở kết quả thu được
- C. Xác định vấn đề cần nghiên cứu, hình thành giả thiết
- D. Xác định yếu tố nguy cơ

[
]

Nghiên cứu mô tả gồm các loại dưới đây, TRỪ:

- A. Nghiên cứu 1 trường hợp bệnh đơn lẻ hiếm gặp
- B. Nghiên cứu hiệu quả điều trị
- C. Nghiên cứu 1 chùm bệnh
- D. Nghiên cứu tương quan

[
]

Nghiên cứu dịch tễ học mô tả nhằm:

- A. Xác định mối liên quan giữa phơi nhiễm và bệnh
- B. Kiểm định giả thiết
- C. Chứng minh giả thiết
- D. Hình thành giả thiết

[
]

Nghiên cứu tương quan có những ưu điểm sau, TRỪ:

- A. Nhanh
- B. Dựa vào số liệu có sẵn
- C. Kiểm soát được ảnh hưởng của các yếu tố gây nhiễu
- D. Mô tả mức phơi nhiễm trung bình của quần thể

[
]

Mô tả một trường hợp bệnh hoặc một chùm bệnh có ưu điểm sau, TRỪ:

- A. Đơn giản, nhanh, dễ làm
- B. Cơ sở ban đầu cho hình thành giả thiết
- C. Xác định căn nguyên trong thời gian ngắn
- D. Cơ sở ban đầu cho việc xác định sự xuất hiện 1 vấn đề sức khỏe

[
]

Điều tra ngang không gắn liền với:

- A. Tỷ lệ hiện mắc
- B. Tỷ suất mới mắc
- C. Tỷ suất hiện mắc điểm
- D. Tỷ suất hiện mắc kỳ

[
]

Điều tra ngang được tiến hành với cách chọn mẫu sau, TRỪ:

- A. Mẫu ngẫu nhiên đơn hoặc hệ thống
- B. Mẫu tầng hoặc chùm
- C. Mẫu ghép cặp
- D. Mẫu 30 cụm ngẫu nhiên

[
]

Điều tra ngang có những ưu điểm sau:

- A. liên được yếu tố phơi nhiễm và bệnh
- B. Có thể làm trong thời gian ngắn, thu được kết quả nhanh hơn
- C. Không mắc sai số ngẫu nhiên
- D. Không mắc sai số hệ thống

[
]

Mô tả trường hợp bệnh hoặc chùm bệnh khi:

- A. Bệnh trạng xuất hiện bất thường
- B. Bệnh xuất hiện phổ biến với tỷ lệ mắc cao
- C. Căn nguyên nghi vấn
- D. Bệnh lạ xuất hiện với tỷ lệ mắc cao

[
]

Nghiên cứu cắt ngang có thể dùng trong các trường hợp sau, TRỪ:

- A. Tìm tỷ lệ người hút thuốc lá
- B. Tìm tỷ lệ bướu cổ trong dân số
- C. Đánh giá hiệu quả của chương trình thanh toán bệnh bại liệt
- D. Tìm tỷ suất chết/mắc của bệnh thương hàn

[
]

Để có thể hình thành giả thiết dịch tễ học về mối quan hệ nhân quả phải tiến hành nghiên cứu:

- A. Mô tả
- B. Phân tích
- C. Thực nghiệm
- D. Tương lai

[
]

Công việc nào sau đây KHÔNG nằm trong các bước của nghiên cứu mô tả:

- A. Phân bố ngẫu nhiên các quần thể vào mẫu nghiên cứu

- B. Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống
- C. Tính cỡ mẫu
- D. Đo lường biến số

[
]

Ba đặc trưng cần mô tả trong dịch tễ học mô tả, TRỪ:

- A. Con người
- B. Không gian
- C. Thời gian
- D. Vật chất

[
]

Các đặc trưng về Dân số học cần mô tả, TRỪ:

- A. Giới
- B. Tuổi đời, nơi sinh
- C. Chủng tộc, dân tộc
- D. Số người trong gia đình

[
]

Một trong các đặc trưng về Dân số học cần mô tả là:

- A. Số người trong gia đình
- B. Tôn giáo
- C. Tình trạng hôn nhân
- D. Tuổi của cha mẹ

[
]

Một trong các đặc trưng về Dân số học cần mô tả là:

- A. Số người trong gia đình
- B. Mức kinh tế xã hội
- C. Tình trạng hôn nhân
- D. Tuổi của cha mẹ

[
]

Một trong các đặc trưng về Gia đình cần mô tả là:

- A. Tình trạng hôn nhân
- B. Mức kinh tế xã hội
- C. Tôn giáo
- D. Dân tộc

[
]

Các đặc trưng về Gia đình cần mô tả, TRỪ:

- A. Tuổi của cha mẹ
- B. Số người trong gia đình, thứ tự sinh
- C. Các điều kiện khi còn là bào thai
- D. Người mắc các bệnh mạn tính

[
]

Các đặc tính nội sinh, di truyền cần mô tả là:

- A. Cấu trúc cơ thể, tình trạng dinh dưỡng
- B. Sức chịu đựng của cá thể, các bệnh tương hỗ
- C. Hai đặc tính A&B
- D. Tuổi của người nghiên cứu

[
]

Nguyên nhân về xu hướng tăng giảm của bệnh có thể là:

- A. Sự xuất hiện hoặc biến mất của các yếu tố căn nguyên của bệnh
- B. Mật độ dân cư và nhà ở
- C. Sự tập trung trong các tập thể ít hoặc nhiều (trường học, cư xá, nhà máy,...)
- D. Xử lý các chất thải bỏ

[
]

Nguyên nhân của xu thế tăng giảm của bệnh có thể là:

- A. Mật độ dân cư và nhà ở
- B. Có phương pháp chẩn đoán chính xác hơn
- C. Sự tập trung trong các tập thể ít hoặc nhiều (trường học, cư xá, nhà máy,...)
- D. Xử lý các chất thải bỏ

[
]

Nguyên nhân của xu thế tăng giảm của bệnh có thể là:

- A. Mật độ dân cư và nhà ở
- B. Sự tập trung trong các tập thể ít hoặc nhiều (trường học, cư xá, nhà máy,...)
- C. Số người được chẩn đoán tăng lên vì chăm sóc sức khỏe tốt hơn
- D. Xử lý các chất thải bỏ

[
]

Nghiên cứu sự tương quan giữa hút thuốc lá và nhồi máu cơ tim, một trong những yếu tố được gọi là yếu tố gây nhiều là:

- A. Cao huyết áp
- B. Hút thuốc lá
- C. Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim
- D. Tai biến mạch máu não

[
]

Trong nghiên cứu mô tả cần phải quan tâm những đặc trưng về con người vì:

- A. Để tìm nhóm nguy cơ cao trong cộng đồng
- B. Những yếu tố về con người đã quyết định đến tỉ lệ mắc bệnh
- C. Tỉ lệ mắc bệnh đều liên quan đến 1 hay nhiều đặc điểm của con người
- D. Để tìm yếu tố nguy cơ của bệnh

[
]

(Case study - trả lời câu hỏi {<1>}) Có 1 đề tài nghiên cứu về tỉ lệ ung thư cổ tử cung của phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long bằng test Papanicolaou và tìm những yếu tố nguy cơ của tình trạng này

(<1>) Tác giả đề tài đã làm là:

- A. Công tác dự phòng cấp 2
- B. Chẩn đoán cộng đồng để thực hiện 3 mức dự phòng
- C. Công tác dự phòng cấp 1
- D. Chẩn đoán cộng đồng để đưa ra chiến lược phòng ngừa

[
]

Phần trăm nguy cơ quy thuộc quần thể là tỷ lệ:

- A. Tỉ lệ bệnh trong dân số nếu toàn bộ dân số không còn tiếp xúc với yếu tố nguy cơ
- B. Tỉ lệ dân số có nguy cơ mắc bệnh

C. Tỷ lệ giảm bớt bệnh trong dân số nếu toàn bộ dân số không còn tiếp xúc với yếu tố nguy cơ

D. Nguy cơ của dân số nếu toàn bộ dân số không còn tiếp xúc với yếu tố nguy cơ

[
]

Người có sức khỏe là người:

A. Không có bệnh gì nặng trong năm

B. Làm ra nhiều sản phẩm cho xã hội

C. Thoải mái hoàn toàn cả thể chất, tinh thần và xã hội

D. Hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của bác sĩ

[
]

Hình ảnh “Tảng băng trôi” trong cộng đồng nói lên là:

A. Chỉ 1 số ít cá thể của bệnh được phát hiện trong cộng đồng

B. Là bệnh phổ biến trong cộng đồng

C. Là hình ảnh nổi bật cần quan tâm trong cộng đồng

D. Là bệnh dễ phát hiện trong cộng đồng

[
]

Chẩn đoán cộng đồng là:

A. Tìm những yếu tố nguy cơ gây bệnh trong cộng đồng hoặc đang chịu ảnh hưởng của những yếu tố nguy cơ gây bệnh

B. Tìm tỷ lệ hiện mắc của bệnh trong cộng đồng để có kế hoạch can thiệp

C. Phát hiện trong cộng đồng những bệnh trạng còn ở trong giai đoạn tiền lâm sàng

D. Khám để tìm những bệnh nhân trong cộng đồng để điều trị

[
]

Để chẩn đoán cộng đồng người ta dùng những phương pháp là:

A. Thăm khám lâm sàng phát hiện những hội chứng bệnh

B. Các cuộc điều tra và kỹ thuật sàng tuyển

C. Những kỹ thuật khám lâm sàng và những xét nghiệm cận lâm sàng

D. Chỉ dùng 1 trong những kỹ thuật xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị nhất trong chẩn đoán

[
]

(Case study - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<2>}) Một nghiên cứu viên đã tìm hiểu tình hình sức khỏe tại một huyện miền núi, đã cho rằng bướu cổ, sốt rét và suy dinh dưỡng là những vấn đề nghiêm trọng tại khu vực này. Nhà nghiên cứu đã thực hiện một nghiên cứu để có được tỷ lệ hiện mắc của các bệnh này ở các lứa tuổi khác nhau, với các nghề nghiệp khác nhau, trình độ học vấn khác nhau và mức thu nhập khác nhau. Qua đó, nhà nghiên cứu có thể xác định được yếu tố chính ảnh hưởng đến các vấn đề sức khỏe đối với quần thể này.

(<1>) Anh chị cho biết, loại thiết kế phù hợp với nghiên cứu này là thiết kế nghiên cứu:

A. Ngang phân tích

B. Ngang mô tả

C. Thuận tập hồi cứu

D. Bệnh chứng

(<2>) Biến số theo anh/chị là biến độc lập trong nghiên cứu này TRỪ:

A. Tuổi của đối tượng nghiên cứu (tính theo năm)

B. Tỷ lệ mắc bệnh sốt rét, bấu cổ (%)

C. Mức thu nhập (tính theo đồng Việt nam)

D. Trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu (theo cấp học)

[
]

(Case study - trả lời câu hỏi {<1>}) Trong nghiên cứu bệnh chứng nhằm chứng minh ăn nhiều chất béo và k vú trên phụ nữ TP.HCM (Nhóm chứng là mẫu đại diện cho phụ nữ thành phố)

(<1>) Nên tìm những trường hợp k vú ở:

A. Tất cả những bệnh nhân điều trị k vú ở TP.HCM nhưng loại bỏ những phụ nữ từ các tỉnh khác tới

B. Bệnh nhân ở bệnh viện ung bướu TP.HCM

C. Tất cả các bệnh nhân điều trị k vú ở TP.HCM

D. Bệnh nhân ở bệnh viện Chợ Rẫy (Tuyển TW phụ trách phía Nam)

[
]

(Case study - trả lời câu hỏi {<1>}) Người ta tiến hành 1 nghiên cứu về mối liên quan giữa thói quen hút thuốc của bà mẹ khi mang thai và cân nặng thấp của trẻ sơ sinh. Người ta tiến hành phỏng vấn tiền sử hút thuốc lá của 340 bà mẹ đẻ con cân nặng thấp và cũng tiến hành phỏng vấn 366 bà mẹ đẻ con có cân nặng bình thường, phát hiện có 16 bà mẹ hút thuốc khi mang thai.

(<1>) Đây là ví dụ về nghiên cứu:

A. Ngang

B. Thuần tập tương lai

C. Bệnh chứng

D. Thử nghiệm

[
]

(Case study - trả lời câu hỏi {<1>}) Một nhà nghiên cứu quan tâm đến bệnh căn của vàng da sơ sinh. Để nghiên cứu vấn đề này ông đã chọn 100 đứa trẻ đã được chuẩn đoán bị vàng da sơ sinh và 100 trẻ em sinh ra cùng một thời gian, trong cùng một bệnh viện mà không bị vàng da. Sau đó ông đã xem xét lại tất cả các hồ sơ sản khoa và lúc đẻ của các bà mẹ đẻ xác định phơi nhiễm trước hay trong lúc đẻ.

(<1>) Đây là ví dụ về:

A. Nghiên cứu ngang

B. Nghiên cứu bệnh chứng

C. Nghiên cứu thuần tập tương lai

D. Thử nghiệm lâm sàng

[
]

(Case study - trả lời câu hỏi {<1>}) Trong thử nghiệm chứng minh hiệu quả của AZT trên bệnh nhân AIDS, 1 nhóm bệnh nhân được dùng Placebo

(<1>) Nhóm này gọi là nhóm:

A. Bệnh

B. Bệnh nhẹ

- C. Tiếp xúc
 - D. Đối chứng
- [
]

Để đánh giá mức độ kết hợp giữa một phơi nhiễm và một bệnh, chỉ số dịch tễ học có ích lợi nhất là

- A. Tỷ suất mới mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm
 - B. Nguy cơ quy thuộc
 - C. Tỷ suất hiện mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm
 - D. Nguy cơ tương đối của bệnh
- [
]

(Case study - trả lời câu hỏi {<1>}) Trong cuộc nghiên cứu ngang về loét dạ dày trong 1 cộng đồng, tỉ lệ những người có đủ triệu chứng để chẩn đoán loét dạ dày là 80/100000 đàn ông ở lứa tuổi 35-49 và 90/100000 phụ nữ ở lứa tuổi 35-49, người ta có thể kết luận rằng ở nhóm tuổi này phụ nữ có nguy cơ cao bị loét dạ dày.

(<1>) Kết luận này là:

- A. Không đúng vì không thể phân biệt được tỉ lệ mới mắc hay tỉ lệ hiện mắc
 - B. Đúng tỉ lệ có đủ triệu chứng để chẩn đoán ở phụ nữ cao hơn đàn ông
 - C. Không đúng vì không nhận biết được ảnh hưởng của thuần tập
 - D. Không đúng vì không có nhóm so sánh hay đối chứng
- [
]

Nhược điểm cơ bản của các nghiên cứu bệnh chứng về vai trò của yếu tố bệnh căn nghi ngờ khi so sánh với nghiên cứu thuần tập tương lai là:

- A. Tồn kém hơn và kéo dài hơn vì cần có thời gian theo dõi sự xuất hiện bệnh
 - B. Có thể sai số hệ thống trong việc xác định sự có mặt hay không có mặt các yếu tố nguy cơ
 - C. Có thể sai số hệ thống trong việc xác định sự có mặt hay không có mặt của hậu quả bệnh
 - D. Khó chọn kiểm chứng có đặc điểm tương đồng với nhóm bệnh
- [
]

Loại nghiên cứu nào sau đây là nghiên cứu bệnh chứng?

- A. Nghiên cứu tỷ lệ tử vong hay mắc bệnh trước đây từ đó ước lượng tỷ lệ mắc bệnh trong tương lai
 - B. Phân tích các nghiên cứu trước đây ở những nơi khác nhau trong năm, hoàn cảnh khác nhau nhằm đưa ra một giả thiết về tất cả các yếu tố nguy cơ đã biết sẽ dẫn đến bệnh mà người ta nghiên cứu
 - C. So sánh mức độ phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ ở nhóm bệnh nhân và nhóm người khỏe mạnh
 - D. So sánh hiệu quả của phương pháp điều trị mới so với một phương pháp điều trị cũ
- [
]

Kỹ thuật ghép cặp được áp dụng trong nghiên cứu bệnh chứng để

- A. Kiểm soát các biến số đã được biết là có ảnh hưởng đến sự phân bố của bệnh mà ta nghiên cứu ở cả 2 nhóm bệnh và nhóm chứng:
- B. Có thể nghiên cứu được ảnh hưởng của các biến số được ghép

- C. Kết quả được quy cho ảnh hưởng của các biến số được ghép
D. Kết quả nghiên cứu có thể bao gồm những kết luận về ảnh hưởng của việc ghép các biến số trước khi lựa chọn

[
]

Nhóm chứng cần thiết trong nghiên cứu bệnh chứng bởi vì:

- A. Nhóm chứng được ghép với nhóm bệnh về các yếu tố bệnh cần nghi ngờ
B. Nhóm chứng được theo dõi để xác định liệu có phát triển bệnh mà ta nghiên cứu hay không
C. Làm tăng cỡ mẫu để có thể đạt được ý nghĩa thống kê
D. Cho phép đánh giá sự khác biệt về mức độ phơi nhiễm giữa nhóm bệnh và nhóm chứng

[
]

Một nghiên cứu bệnh chứng có các đặc điểm sau TRỪ:

- A. Không quá tốn kém
B. Có thể ước lượng được nguy cơ tương đối
C. Có thể được ước lượng tỷ suất mới mắc
D. Có thể chọn nhóm chứng từ những bệnh khác

[
]

Nhận xét nào dưới đây là ưu điểm của một nghiên cứu bệnh chứng:

- A. Không có hay có ít sai lệch trong việc đánh giá phơi nhiễm với một yếu tố nguy cơ
B. Có thể nghiên cứu ảnh hưởng của một phơi nhiễm đối với nhiều bệnh
C. Loại TRỪ được sự phụ thuộc vào việc nhớ lại của các đối tượng nghiên cứu
D. Thường được sử dụng để nghiên cứu bệnh căn các bệnh hiếm gặp

[
]

Thông tin về bệnh thường gặp sai số nhất từ nguồn nào:

- A. Giấy chứng nhận tử vong, thông qua mô tử thi, hồ sơ bệnh án ở bệnh viện hay hỏi họ hàng, người thân của bệnh nhân
B. Hồ sơ bệnh án hay sổ khám bệnh
C. Hỏi trực tiếp đối tượng nghiên cứu hoặc người thân bằng bộ câu hỏi
D. Khám sức khỏe định kỳ, sử dụng tiêu chuẩn chuẩn đoán đối với tất cả các đối tượng nghiên cứu

[
]

Kết hợp nhân quả có thể được phân giải qua các số đo sau, TRỪ:

- A. Nguy cơ tương đối (ước lượng điểm)
B. Nguy cơ tuyệt đối (ước lượng khoảng)
C. Nguy cơ quy thuộc (ước lượng điểm và ước lượng khoảng)
D. Tỷ suất chênh (ước lượng điểm và ước lượng khoảng)

[
]

Biện pháp nào sau đây không phải biện pháp khống chế nhiễu trong nghiên cứu bệnh – chứng:

- A. Chọn ngẫu nhiên
B. Thu hẹp phạm vi nghiên cứu
C. Ghép cặp

D. Làm mù

[
]

Mức độ kết hợp giữa một yếu tố nguy cơ và bệnh được đo lường tốt nhất bằng:

A. Tỷ suất mới mắc của bệnh trong toàn bộ dân chúng

B. Sự phổ biến của yếu tố nguy cơ

C. Nguy cơ quy thuộc

D. Nguy cơ tương đối

[
]

(Case study - trả lời câu hỏi {<1>}) Trong một nghiên cứu 500 bệnh nhân và 500 người đối chứng, người ta đã tìm ra một yếu tố bệnh căn nghi ngờ ở 400 bệnh nhân và 100 người đối chứng.

(<1>) Nguy cơ tuyệt đối tỷ suất mới mắc ở những người có yếu tố này là:

A. 80%

B. 40%

C. 16%

D. Không thể tính được từ số liệu đã cho

[
]

(Case study - trả lời câu hỏi {<1>}) Ở một cuộc điều tra cơ bản, 17 người trong số 1000 người đã có dấu hiệu của bệnh mạch vành tim.

(<1>) Chỉ số đo lường bệnh xảy ra là tỷ suất:

A. Hiện mắc

B. Mới mắc

C. Mới mắc tích lũy

D. Mật độ mới mắc

[
]

Nhược điểm cơ bản của các nghiên cứu bệnh chứng về vai trò của yếu tố bệnh căn nghi ngờ khi so sánh và nghiên cứu thuần tập là:

A. Chúng tốn kém hơn và kéo dài hơn

B. Có thể có sai số hệ thống trong việc xác định sự có mặt hay không có mặt của yếu tố nguy cơ.

C. Có thể có sai số hệ thống trong việc xác định sự có mặt hay không có mặt của hậu quả bệnh.

D. Gặp khó khăn hơn trong việc đảm bảo khả năng so sánh giữa nhóm bệnh và nhóm chứng.

[
]

Loại nghiên cứu sau đây là nghiên cứu bệnh chứng:

A. Nghiên cứu tỷ lệ tử vong hay mắc bệnh trước đây cho phép ước lượng tỷ lệ bệnh trong tương lai

B. Phân tích các nghiên cứu trước đây ở những nơi khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau cho phép đưa ra một giả thuyết dựa trên hiểu biết về tất cả các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh mà ta nghiên cứu

C. Thu thập tiền sử và những thông tin khác từ một nhóm bệnh nhân đã biết và từ một nhóm so sánh không mắc bệnh đó để xác định tần số tương đối của các đặc trưng nghiên cứu ở những nhóm người đó.

D. Nghiên cứu nguy cơ tương đối của ung thư ở những người đàn ông đã bỏ thuốc lá và những người vẫn đang hút thuốc lá.

[
]

Kỹ thuật ghép cặp được áp dụng trong nghiên cứu bệnh chứng để:

A. Kiểm soát các biến số đã được biết là có ảnh hưởng đến sự phân bố của bệnh mà ta nghiên cứu ở cả hai nhóm bệnh và nhóm chứng

B. Có thể nghiên cứu được ảnh hưởng của các biến số được ghép cặp

C. Kết quả không được quy cho ảnh hưởng của các biến số được ghép cặp.

D. Kết quả nghiên cứu có thể bao gồm những kết luận về ảnh hưởng của việc ghép cặp đến các biến số trước khi được lựa chọn

[
]

Nhóm chứng cần thiết trong nghiên cứu bệnh chứng vì:

A. Chúng được so sánh với nhóm bệnh về các yếu tố bệnh cần nghi ngờ

B. Chúng được theo dõi để xác định liệu có phát triển bệnh mà ta nghiên cứu hay không?

C. Chúng làm tăng cỡ mẫu để có thể đạt được ý nghĩa thống kê.

D. Chúng cho phép đánh giá liệu tần số của một đặc trưng hay phơi nhiễm trong quá khứ ở những bệnh nhân có khác so với ở những người ở nhóm so sánh mà không bị bệnh hay không?

[
]

Để đánh giá mức độ kết hợp giữa một phơi nhiễm và một bệnh, những chỉ số thống kê sức khỏe có ích lợi nhất là:

A. Tỷ lệ mới mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm

B. Nguy cơ quy thuộc

C. Tỷ lệ hiện mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm

D. Nguy cơ tương đối của bệnh

[
]

(Case study - trả lời câu hỏi {<1>}) Năm 1975, người ta đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ bệnh án của một bệnh viện sản khoa nhằm xác định những phụ nữ đã sinh ra những trẻ em gái trong thời gian từ 1950-1959. Từ những hồ sơ bệnh án này, người ta cũng đã xác định những phụ nữ đã dùng diethylstilbestrol (DES) trong thời kỳ có thai và những phụ nữ khác không dùng DES trong thời kỳ có thai. Sau đó, người ta đã tiến hành phỏng vấn con gái của những bà mẹ đó và khám sản phụ khoa nhằm phát hiện ung thư âm đạo. Người ta cũng tiến hành nghiên cứu giấy chứng nhận tử vong hay hồ sơ bệnh án của những cô gái đã chết nhằm xác định nguyên nhân tử vong.

(<1>) Những thuật ngữ sau đây mô tả đúng nghiên cứu này là:

A. Quan sát

B. Thục nghiệm

C. Thuần tập

D. Bệnh chứng

[
]

Một nghiên cứu bệnh chứng có các đặc trưng sau, TRỪ:

A. Nó tương đối không tốn kém

B. Nguy cơ tương đối có thể ước lượng được từ kết quả

C. Tỷ lệ mới mắc có thể tính được

D. Người ta có thể chọn nhóm chúng không bị bệnh

[
]

Mức độ kết hợp giữa một yếu tố nguy cơ và bệnh được đo lường tốt nhất bằng:

A. Tỷ lệ mới mắc của bệnh trong toàn bộ dân chúng

B. Sự phổ biến của yếu tố nguy cơ

C. Nguy cơ quy thuộc

D. Nguy cơ tương đối.

[
]

Những nhận xét đúng có liên quan với nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thuần tập là:

A. Nghiên cứu thuần tập ít nhạy cảm với các sai số hệ thống.

B. Nghiên cứu thuần tập cho phép tính toán trực tiếp tỷ lệ mới mắc

C. Nghiên cứu bệnh chứng có ưu điểm là sẵn có các số liệu cho việc phân tích nhóm.

D. Tất cả nhận xét trên

[
]

Điểm giống nhau cơ bản giữa nghiên cứu mô tả và nghiên cứu phân tích là:

A. Cùng là nghiên cứu quan sát

B. Cùng có nhóm so sánh

C. Cùng kiểm tra một giả thuyết giữa một yếu tố nguy cơ và bệnh

D. Các đối tượng nghiên cứu được chọn từ quần thể dân chúng nói chung

[
]

Việc lựa chọn loại thiết kế nghiên cứu phù hợp chủ yếu dựa vào:

A. Mục tiêu nghiên cứu, kinh phí nghiên cứu

B. Quần thể nghiên cứu

C. Thời gian nghiên cứu

D. Kinh nghiệm của người nghiên cứu

[
]

(Case study - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<2>}) Một nghiên cứu viên đã tìm hiểu tình hình sức khỏe tại một huyện miền núi, đã cho rằng bướu cổ, sốt rét và suy dinh dưỡng là những vấn đề nghiêm trọng tại khu vực này. Nhà nghiên cứu đã thực hiện một nghiên cứu để có được tỷ lệ hiện mắc của các bệnh này ở các lứa tuổi khác nhau, với các nghề nghiệp khác nhau, trình độ học vấn khác nhau và mức thu nhập khác nhau. Qua đó, nhà nghiên cứu có thể xác định được yếu tố chính ảnh hưởng đến các vấn đề sức khỏe đối với quần thể này.

(<1>) Theo Anh/chị loại thiết kế dưới đây phù hợp với nghiên cứu này là thiết kế nghiên cứu:

A. Ngang phân tích

B. Ngang mô tả

C. Thuần tập hồi cứu

D. Bệnh chứng

[
]

(<2>) Theo Anh/chị các biến số là biến độc lập trong nghiên cứu này TRỪ:

- A. Tuổi của đối tượng nghiên cứu (tính theo năm)
- B. Tỷ lệ mắc bệnh sốt rét, bọ rầy cổ (%)
- C. Mức thu nhập (tính theo đồng Việt nam)
- D. Trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu (theo cấp học)

[
]

(Case study - trả lời câu hỏi {<1>}) Trong một nghiên cứu 500 bệnh nhân và 500 đối chứng, người ta đã tìm ra một yếu tố bệnh căn nghi ngờ ở 400 bệnh nhân và 100 người đối chứng.

(<1>) Nguy cơ tuyệt đối tỷ suất mới mắc ở những người có yếu tố này là:

- A. 80%
- B. 40%
- C. 20%
- D. Không thể tính được

[
]

Trong các tiêu chuẩn dưới đây, các tiêu chuẩn nào là của một yếu tố được gọi là nhiễu:

- A. Phải có liên quan đến yếu tố phơi nhiễm và phụ thuộc vào yếu tố phơi nhiễm.
- B. Không phải là yếu tố trung gian giữa phơi nhiễm và bệnh và yếu tố này có thể đổi chỗ cho yếu tố phơi nhiễm tùy theo mục đích của người nghiên cứu.
- C. Phải là một yếu tố hậu quả của bệnh.
- D. Yếu tố này có thể tác động hoặc không tác động lên mối tương quan giữa phơi nhiễm và bệnh.

[
]

Các nghiên cứu dịch tễ học về vai trò của một yếu tố nghi ngờ về bệnh căn có thể là nghiên cứu quan sát hay thực nghiệm. Sự khác nhau cơ bản giữa các nghiên cứu thực nghiệm và quan sát là trong các nghiên cứu thực nghiệm thì:

- A. Nhóm nghiên cứu và nhóm chứng giống nhau về cỡ mẫu
- B. Nghiên cứu là nghiên cứu tương lai, nhóm chứng và nhóm nghiên cứu luôn so sánh được với nhau
- C. Nhà nghiên cứu quyết định ai sẽ phơi nhiễm với yếu tố nghi ngờ và ai không
- D. Nhóm chứng được sử dụng

[
]

[<g>] Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp [</g>]

Bệnh mà tác nhân gây bệnh không phải là virus là:

- A. Bệnh sởi
- B. Bệnh ho gà
- C. Bệnh thủy đậu

D. Bệnh quai bị

[
]

Virut sởi có những đặc tính sau:

- A. Có thể hiện diện trong nhót cổ họng, trong máu bệnh nhân
- B. Lây lan chủ yếu bằng đường hô hấp
- C. Chỉ gây bệnh ở người và khỉ
- D. Tất cả các câu trên đều đúng

[
]

Cúm là một trong những bệnh gây nên đại dịch lớn vì:

- A. Sự thay đổi kháng nguyên của virut
- B. Sự lây truyền qua nước
- C. Thời kỳ ủ bệnh lâu dài
- D. Không có vắc xin đặc hiệu

[
]

Nguồn truyền nhiễm của nhóm bệnh lây truyền theo đường hô hấp là:

- A. Người bệnh thể điển hình
- B. Người bệnh thể không điển hình
- C. Người mang mầm bệnh
- D. Tất cả các loại kể trên

[
]

Điều phù hợp với bệnh cúm là:

- A. Tác nhân gây bệnh là 5 loại virut Influenza A, B, C, D, E.
- B. Virut cúm B và C hay gây các trận dịch lớn cho cộng đồng.
- C. Người bệnh và người lành mang trùng là nguồn bệnh duy nhất
- D. Bệnh cúm bắt đầu lây khi bệnh nhân khởi sự sốt cao

[
]

Cơn ho điển hình của bệnh ho gà gồm những triệu chứng sau:

- A. Ho một cơn khoảng 15-20 cái rồi chấm dứt.
- B. Ho nhiều cơn, giữa các cơn ho nghe có tiếng “ót”.
- C. Ho từng tiếng một có nhiều đờm trắng đục

D. Ho từng tiếng một, không có đờm, thỉnh thoảng khạc ra máu.

[
]

Bệnh sởi có những đặc tính sau:

A. Có miễn dịch không bền, do đó cần phải tiêm chủng.

B. Mức độ lây lan thấp.

C. Luôn luôn diễn biến qua các giai đoạn viêm long, phát ban, hồi phục

D. Rất khó chẩn đoán vì khó phân lập được tác nhân gây bệnh.

[
]

Cơ chế gây bệnh của bệnh truyền nhiễm theo đường hô hấp là:

A. Giọt nước bọt.

B. Thức ăn.

C. Bọ chét

D. Muỗi.

[
]

Đối với những bệnh truyền nhiễm đường hô hấp có hiện tượng tăng bằng biện pháp phòng chống quan trọng là:

A. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân.

B. Phát hiện sớm và điều trị triệt để cho bệnh nhân.

C. Tăng cường giáo dục sức khỏe và các biện pháp dự phòng cấp 1.

D. Chẩn đoán và cách ly sớm.

[
]

Hiện nay bệnh ho gà có khuynh hướng gia tăng ở các nước đã phát triển vì:

A. Thuốc tiêm chủng không còn hiệu quả

B. Thuốc tiêm chủng không có khả năng tạo miễn dịch vĩnh viễn

C. Việc di dân từ những nước đang có dịch ho gà

D. Việc tiêm chủng bị lơ là.

[
]

Gamma globulin phòng bệnh có hiệu quả cho những người đã tiếp xúc với bệnh nhân trong bệnh:

A. Bệnh sởi.

B. Bệnh quai bị.

- C. Bệnh thương hàn.
- D. Bệnh ly trực khuẩn.

[
]

Đa số bệnh lây qua đường hô hấp có miễn dịch bền vững, TRỪ bệnh:

- A. Sởi
- B. Đậu mùa
- C. Ho gà
- D. Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính

[
]

Tiêm chủng ho gà chống chỉ định ở người:

- A. Trên 3 tuổi.
- B. Trên 6 tuổi.
- C. Trên 10 tuổi.
- D. Trên 13 tuổi.

[
]

Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh sởi là:

- A. Phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân.
- B. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân.
- C. Tiêm vaccin sởi cho trẻ em từ 9-11 tháng tuổi.
- D. Giáo dục sức khỏe và vệ sinh cá nhân.

[
]

Biện pháp xử trí có ích lợi nhất cho một bệnh nhân bị cúm là:

- A. Nghỉ ngơi trong giai đoạn sốt
- B. Dùng thuốc hạ nhiệt, giảm đau suốt thời gian bệnh
- C. Dùng Vitamin C liều cao và tiêm tĩnh mạch
- D. Truyền dịch để cân bằng nước điện giải, thăng bằng kiềm toan tích cực.

[
]

Đối với các bệnh lây qua đường hô hấp muốn phòng dịch tốt quan trọng nhất là:

- A. Cách ly người bệnh
- B. Uống thuốc dự phòng

- C. Gây miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu
 - D. Vệ sinh môi trường
- [
]

[<g>] Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá [</g>]

Biện pháp tác động vào nguồn truyền nhiễm để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa là:

- A. Kiểm tra vệ sinh các nguồn nước
 - B. Xử lý phân đúng quy cách
 - C. Phát hiện sớm người mắc bệnh, cách ly và điều trị triệt để
 - D. Diệt ruồi
- [
]

Biện pháp tác động vào khối cảm thụ để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa là:

- A. Uống thuốc phòng
 - B. Giáo dục vệ sinh cho nhân dân
 - C. Xây dựng tiện nghi vệ sinh ở các khu dân cư
 - D. Giám sát, phát hiện người lành mang trùng
- [
]

Những người có thể mắc các bệnh lây qua đường tiêu hóa là:

- A. Trẻ em
 - B. Phụ nữ
 - C. Người suy giảm miễn dịch
 - D. Tất cả mọi người
- [
]

Bệnh lây qua đường tiêu hóa có thể giải phóng tác nhân gây bệnh ra môi trường bên ngoài qua nước tiểu là:

- A. Tả
 - B. Thương hàn
 - C. Bại liệt
 - D. Uốn ván
- [
]

Nguồn lây có ý nghĩa quan trọng trong phát sinh dịch đối với bệnh tả là:

- A. Người bệnh
 - B. Người mang trùng
 - C. Người mang trùng mạn tính
 - D. Người tiếp xúc với người bệnh
- [
]

Về mặt lâm sàng nguồn lây nguy hiểm nhất của bệnh tả, ly, thương hàn là:

- A. Người bệnh
 - B. Người mang trùng
 - C. Nguồn nước bị nhiễm vi khuẩn tả
 - D. Vector trung gian truyền bệnh
- [
]

Biện pháp tác động của đường truyền nhiễm để phòng chống bệnh lây qua đường tiêu hóa là:

- A. Theo dõi người tiếp xúc
- B. Giáo dục vệ sinh phòng bệnh cho nhân dân
- C. Điều trị cho người mang trùng mạn tính
- D. Xử lý nguồn nước bị ô nhiễm

[
]

Biện pháp có hiệu quả nhất để hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn là:

- A. Dùng vắc xin
- B. Chẩn đoán sớm người mắc bệnh, cách ly và điều trị
- C. Vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, xử lý phân an toàn
- D. Diệt ruồi

[
]

Về lâu dài biện pháp tốt nhất để phòng chống các bệnh lây qua đường tiêu hóa là:

- A. Quản lý tốt nguồn truyền nhiễm
- B. Quản lý tốt người mang trùng mạn tính
- C. Giám sát định kỳ các ổ dịch cũ để phát hiện sớm các trường hợp bệnh
- D. Đảm bảo cung cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường

[
]

Biện pháp chống dịch tốt nhất khi có dịch tả, lỵ, thương hàn xảy ra là:

- A. Dùng kháng sinh cho mọi người trong vùng dịch
- B. Dự phòng bằng vắc xin
- C. Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân
- D. Phát hiện sớm, cách ly, điều trị bệnh nhân, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân

[
]

Biện pháp dự phòng cấp 1 để phòng chống các bệnh lây qua đường tiêu hóa là:

- A. Tiêm vắc xin
- B. Xử lý phân an toàn
- C. Phát hiện sớm người mắc bệnh
- D. Điều trị triệt để người mắc bệnh

[
]

Tham gia trong việc làm lan truyền một số bệnh đường ruột tăng lên theo mùa là do:

- A. Thức ăn
- B. Ruồi
- C. Tay bẩn của người mang vi khuẩn mạn tính
- D. Động vật mắc bệnh

[
]

Yếu tố đóng vai trò quan trọng trong lan truyền bệnh tả, lỵ, thương hàn là:

- A. Vật dụng bị nhiễm phân
- B. Nguồn nước bị ô nhiễm

- C. Thức ăn không được nấu chín
- D. Hố xí không hợp vệ sinh

[
]

Biện pháp dự phòng cấp 2 để phòng chống các bệnh lây qua đường tiêu hóa là:

- A. Giám sát, phát hiện người mang trùng
- B. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
- C. Phát hiện sớm người mắc bệnh để điều trị
- D. Điều trị triệt để người mang trùng mạn tính

[
]

Bệnh phải được cách ly bắt buộc trong những phòng riêng của khoa truyền nhiễm là:

- A. Bệnh tả
- B. Bệnh lỵ
- C. Tiêu chảy do E.Coli
- D. Sốt xuất huyết

[
]

Các biện pháp sau đây được thực hiện để phòng chống bệnh tả khi có dịch xảy ra, TRỪ:

- A. Phát hiện sớm người mắc bệnh để cách ly, điều trị
- B. Giám sát các trường hợp ỉa chảy nghi ngờ
- C. Dự phòng kháng sinh cho người nhà ăn ở chung với người bệnh
- D. Dự phòng kháng sinh cho mọi người trong vùng có dịch

[
]

Bệnh sau đây có tình trạng người mang trùng mạn tính sau khi khỏi bệnh là:

- A. Bệnh tả
- B. Bệnh thương hàn
- C. Viêm gan A
- D. Tiêu chảy

[
]

Dấu hiệu Typhos: bệnh nhân nằm bất động, vẻ mặt thờ ơ, mắt đờ đẫn, là triệu chứng của bệnh:

- A. Tả
- B. Lỵ trực trùng
- C. Thương hàn
- D. Leptospirose

[
]

Đối với các bệnh lây qua đường tiêu hóa thì nguồn lây nguy hiểm nhất là:

- A. Người bệnh ở giai đoạn ủ bệnh
- B. Người bệnh ở giai đoạn phát bệnh
- C. Người bệnh ở giai đoạn hồi phục
- D. Người mang trùng mạn tính

[
]

Để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa cho cộng đồng cần giám sát phát hiện và điều trị người mang trùng cho:

- A. Nhân viên y tế
- B. Nhân viên tiếp thị, Học sinh, sinh viên
- C. Nhân viên chế biến và phân phối thực phẩm
- D. Người chăn nuôi gia súc

[
]

Tác nhân gây bệnh thương hàn là:

- A. Salmonella.
- B. Campylobacter.
- C. Staphylococcus aureus.
- D. Vibrio cholerae O1.

[
]

Điều không phù hợp cho vi khuẩn Shigella là:

- A. Thuộc gia đình Enterobacter.
- B. Có thể tiết ra nội độc tố lipopolisaccharide gây sốc
- C. Dòng Shigella týp huyết thanh 01 gây bệnh cảnh nặng nhất
- D. Gây tổn thương chủ yếu là các ổ loét hoại tử ở niêm mạc ruột non.

[
]

Rotavirus là nguyên nhân của 50% các trường hợp tiêu chảy trẻ em ở lứa tuổi:

- A. 0 đến 6 tháng tuổi
- B. 6 đến 24 tháng tuổi
- C. 24 đến 36 tháng tuổi
- D. Từ 3 tuổi đến 6 tuổi

[
]

Nguồn truyền nhiễm của nhóm bệnh lây truyền theo đường tiêu hoá là:

- A. Người bệnh thể điển hình
- B. Người bệnh thể không điển hình
- C. Người mang mầm bệnh
- D. Tất cả các loại kể trên

[
]

Người lành mang mầm bệnh là nguồn lây truyền bệnh:

- A. Bệnh sởi
- B. Thương hàn
- C. Ho gà

D. Đậu mùa

[
]

Các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá lây truyền qua :

A. Giọt nước bọt

B. Bụi

C. Thực phẩm

D. Muối

[
]

Những người mang mầm bệnh thương hàn mãn tính phải:

A. Cách ly

B. Cắt bỏ túi mật

C. Đăng ký và theo dõi ở trung tâm y tế dự phòng nơi họ ở

D. Cách ly tại trung tâm y tế dự phòng và theo dõi 21 ngày.

[
]

Những bệnh lây truyền chủ yếu qua phân bao gồm:

A. Bệnh sốt phát ban.

B. Bệnh sốt rét.

C. Bệnh thương hàn.

D. Bệnh lao.

[
]

Số trường hợp mới mắc sốt bại liệt hàng năm ở Việt Nam từ năm 1992 – 1996 có khuynh hướng:

A. Giảm

B. Tăng

C. Không thay đổi

D. Tăng giảm thất thường

[
]

Trong sốt bại liệt, thể lâm sàng thường gặp nhất là:

A. Liệt mềm.

B. Liệt không đồng đều, không đối xứng

C. Không rối loạn cảm giác khách quan

D. Teo cơ nhanh nhiều và sớm

[
]

Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh bại liệt là:

A. Phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân.

B. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân.

C. Giáo dục sức khoẻ và vệ sinh cá nhân.

D. Uống vacxin Sabin.

[
]

Tỷ lệ chết/ mắc bệnh tả hiện nay ít hơn 1%. yếu tố chủ yếu làm cho tỷ lệ này thấp là:

A. Điều trị bằng tetracycline hoặc các kháng sinh khác.

B. Gây miễn dịch cho dân trong vùng có dịch.

C. Khử trùng nguồn nước bằng cloramin trong vùng có dịch.

D. Cách ly người bệnh ở bệnh viện.

[
]

Các biện pháp chủ yếu để phòng chống các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá là:

A. Các biện pháp đối với nguồn truyền nhiễm.

B. Các biện pháp đối với đường truyền nhiễm.

C. Các biện pháp tăng cường sức đề kháng cho nhân dân.

D. Tất cả các biện pháp trên.

[
]

Đối với những bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá có hiện tượng tăng bằng biện pháp phòng chống quan trọng là:

A. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân.

B. Phát hiện sớm và điều trị triệt để cho bệnh nhân.

C. Tăng cường giáo dục sức khoẻ và các biện pháp dự phòng cấp 1.

D. Diệt côn trùng truyền bệnh.

[
]

(Case study - trả lời câu hỏi {<1>}) Một người mẹ mang cháu gái 11 tháng bị ỉa chảy tới trạm y tế. Người mẹ đang cho con bú. Bà nói rằng nhà bà ở xa trạm y tế nên không thể trở lại trạm trong một vài ngày, ngay cả khi tình trạng cháu xấu đi. Người mẹ nói rằng bà thường cho cháu bé uống nước chè loãng khi cháu bị ỉa chảy, nhưng nghe nói ở trạm y tế có loại dịch tốt hơn nên bà đưa cháu tới trạm. Cán bộ y tế khám cháu bé nhưng không tìm thấy dấu hiệu mất nước.

(<1>) Cán bộ y tế được hướng dẫn bà mẹ, TRỪ:

A. Khuyến người mẹ tiếp tục cho trẻ bú thường xuyên và tùy ý về số lần và thời gian cho bú.

B. Khuyến người mẹ cho con ăn bột có thêm dầu thực vật, rau nấu kỹ và nếu có thì cho thêm một ít thịt nghiền. Ngoài bú sữa mẹ, cần tiếp tục cho ăn ít nhất 6 lần một ngày.

C. Giải thích cho người mẹ rằng nếu trẻ vẫn tiếp tục ỉa chảy sau khi dùng hết ORS thì cần cho trẻ uống nước cơm, nước cháo, đồng thời tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ.

D. Giải thích rằng nếu cháu tiếp tục ỉa chảy 3-4 ngày thì bà ta cần ngừng cho bú đến khi cháu bé khỏi bệnh.

[
]

[<g>] Dịch tễ học nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu [</g>]

Tác nhân gây bệnh của nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu:

- A. Vi khuẩn
- B. Vi rút
- C. Ký sinh trùng
- D. Cả 3 loại trên

[
]

Tác nhân gây bệnh của bệnh dịch hạch là:

- A. Vi khuẩn
- B. Vi rút
- C. Ký sinh trùng
- D. Cả 3 loại trên

[
]

Tác nhân gây bệnh của bệnh Viêm não Nhật Bản B là:

- A. Vi khuẩn
- B. Vi rút
- C. Ký sinh trùng
- D. Cả 3 loại trên

[
]

Biện pháp đặc hiệu trong dự phòng viêm gan B là:

- A. Sàng lọc máu trước khi truyền
- B. Thực hiện an toàn trong môi trường chăm sóc
- C. Thực hiện tốt vô trùng, tiệt trùng
- D. Tiêm vắc xin viêm gan B

[
]

Tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue cao nhất ở Việt Nam trong những năm gần đây gặp ở các khu vực:

- A. Vùng núi phía Bắc
- B. Đồng bằng Bắc Bộ

C. Miền Trung – Tây Nguyên

D. Miền nam

[
]

Bệnh lây truyền qua đường máu không diễn biến theo mùa là:

A. Bệnh sốt xuất huyết

B. Bệnh sốt rét

C. Bệnh giun chỉ

D. Bệnh dịch hạch

[
]

Bệnh lây truyền qua đường máu không có ổ dịch thiên nhiên là:

A. Bệnh viêm não Nhật Bản

B. Bệnh sốt rét

C. Bệnh viêm gan B,C

D. Bệnh dịch hạch

[
]

Bệnh xuất huyết Dengue chủ yếu lây qua đường:

A. Đường hô hấp

B. Đường tiêu hoá

C. Muỗi đốt

D. Truyền máu

[
]

Tác nhân gây bệnh xuất huyết Dengue bởi nhóm virus sau :

A. Dicomaviridae

B. Flaviviridae

C. Paramyxoviridae

D. Retroviridar

[
]

Bệnh sốt xuất huyết Dengue gặp chủ yếu ở :

A. Trẻ em dưới 15 tuổi

B. Người lớn

C. Nam giới

D. Phụ nữ

[
]

Bệnh sốt xuất huyết Dengue thường gặp ở :

A. Tất cả các nước trên thế giới

B. Các nước có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới

C. Các nước có khí hậu ôn đới

D. Nước có khí hậu nhiệt đới

[
]

Loại Plasmodium là nguyên nhân chính gây bệnh sốt rét ác tính là:

A. P.falciparum

B. P.vivax

C. P.malariae

D. P.ovale

[
]

Chỉ số nào dưới đây dùng để phân loại mô hình dịch tễ sốt rét là:

A. Chỉ số ký sinh trùng

B. Chỉ số giao bào

C. Chỉ số lách to

D. Cả 3 chỉ số trên

[
]

Bệnh giun chỉ chủ yếu lây qua đường:

A. Đường da, niêm mạc

B. Đường tiêu hoá

C. Muỗi đốt

D. Truyền máu

[
]

Bệnh dịch hạch chủ yếu lây qua đường:

A. Truyền máu

B. Muỗi đốt

C. Vết chuột cắn

D. Bọ chét đốt

[
]

Khu vực có lưu hành bệnh dịch hạch ở Việt Nam hiện này là :

A. Vùng núi phía Bắc

B. Đồng bằng Bắc Bộ

C. Miền Trung - Tây Nguyên

D. Đồng bằng Nam Bộ

[
]

Dịch hạch có thể lây trực tiếp từ người – người từ:

A. Thở hạch

B. Thở nhiễm khuẩn huyết

C. Thở phổi

D. Cả 3 thể trên

[
]

Việt Nam là vùng lưu hành cao của bệnh Viêm gan B với đặc điểm là:

A. Tỷ lệ nhiễm HBV qua đường chu sinh rất cao.

B. Tỷ lệ người mang HbsAg rất cao (khoảng 8 – 15%)

C. Tỷ lệ ung thư gan nguyên phát có liên quan đến HBV cao

D. Tỷ lệ phụ nữ mang thai có HbsAg (+) cao

[
]

Bệnh lây qua đường máu có nguồn gốc truyền nhiễm từ động vật là:

A. Viêm não Nhật Bản

B. Viêm gan B

C. Bệnh dại

D. Sốt xuất huyết Dengue

[
]

Những người có thể mắc các bệnh lây qua đường máu là:

A. Người tiêm chích ma túy

B. Người có quan hệ tình dục không an toàn

C. Nhân viên y tế

D. Tất cả những người trên

[
]

Bệnh Sốt xuất huyết Dengue lây qua đường:

A. Hô hấp

B. Máu

C. Tiêu hóa

D. Da, niêm mạc

[
]

Bệnh lây qua đường máu được truyền từ động vật sang người qua trung gian bộ chét là:

A. Viêm não Nhật Bản

B. Bệnh dịch hạch

C. Sốt rét

D. Bệnh than

[
]

Biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue không đúng là:

A. Phát hiện sớm người mắc bệnh, cách ly, điều trị

B. Khai báo các trường hợp bệnh

C. Uống thuốc dự phòng

D. Triệt phá nơi trú ngụ và sinh sản của muỗi, các ổ bọ gậy Aedes Aegypti.

[
]

Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường máu không có tình trạng người mang trùng mạn tính là:

A. Viêm gan vi rút B

B. Viêm gan vi rút C

C. Nhiễm HIV/AIDS

D. Sốt xuất huyết Dengue

[
]

Nguồn truyền nhiễm của các bệnh lây qua đường máu (viêm gan B, C, nhiễm HIV) là:

- A. Máu chứa tác nhân gây bệnh
- B. Bơm kim tiêm nhiễm vi sinh vật gây bệnh
- C. Người mang trùng
- D. Công trùng tiết túc hút máu

[
]

Biện pháp dự phòng cấp I để phòng, chống các bệnh lây qua đường máu là:

- A. Điều trị triệt để người mắc bệnh
- B. Tiệt khuẩn dụng cụ tiêm truyền và diệt côn trùng hút máu tương ứng
- C. Tiêm vắc xin
- D. Uống thuốc dự phòng

[
]

Biện pháp dự phòng cấp II đối với các bệnh lây qua đường máu là:

- A. Diệt công trùng hút máu tương ứng
- B. Tiệt khuẩn các dụng cụ tiêm truyền
- C. Diệt động vật mắc bệnh
- D. Phát hiện sớm người mắc bệnh để điều trị sớm

[
]

Biện pháp dự phòng cấp I để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue là:

- A. Tiêm phòng vắc xin
- B. Theo dõi người khỏi bệnh mang trùng
- C. Quản lý động vật mắc bệnh
- D. Bảo vệ cơ thể tránh để muỗi đốt

[
]

Biện pháp tác động vào nguồn truyền nhiễm để phòng bệnh lây từ người qua đường máu là:

- A. Diệt động vật mắc bệnh
- B. Diệt côn trùng, tiết túc hút máu tương ứng
- C. Phát hiện sớm người mắc bệnh, cách ly và điều trị triệt để
- D. Tiệt khuẩn các dụng cụ tiêm truyền

[
]

Biện pháp tác động vào đường truyền để phòng bệnh lây từ động vật sang người qua đường máu là:

- A. Phát hiện sớm người bệnh, cách ly, điều trị kịp thời
- B. Diệt động vật mắc bệnh
- C. Uống thuốc dự phòng khi có phơi nhiễm
- D. Diệt công trùng, tiết túc hút máu tương ứng

[
]

Đối với truyền nhiễm lây qua đường máu muốn phòng dịch tốt quan trọng nhất là:

- A. Diệt véc tơ truyền bệnh và an toàn truyền máu và tiêm chích
- B. Giáo dục cho người lành biết cách phòng tránh
- C. Cách ly và điều trị triệt để nguồn truyền nhiễm
- D. Dự phòng bằng Vaccine và nâng cao sức đề kháng cho người bệnh

[
]

[<g>]CÁC LOẠI SAI SỐ TRONG NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC [</g>]

Nội dung dưới đây KHÔNG phù hợp với tính giá trị của nghiên cứu là:

- A. Một nghiên cứu có tính giá trị cao là nghiên cứu cho kết quả gần đúng với giá trị thực của quần thể nghiên cứu
- B. Tính nội giá trị: có nghĩa là kết quả đó đúng với quần thể cần khái quát
- C. Tính ngoại giá trị: kết quả nghiên cứu có thể khái quát hoá ra đối với các quần thể khác
- D. Một nghiên cứu có tính giá trị (chính xác) là nghiên cứu ít sai số và nhiều xảy ra trong nghiên cứu

[
]

Nội dung KHÔNG đúng với việc đánh giá vai trò của may rủi là:

- A. Kiểm định giả thuyết
- B. Tiến hành một trắc nghiệm thống kê để xác định liệu biến nghiên cứu của mẫu có thể được coi là một giải thích phù hợp của kết quả quan sát
- C. Ước lượng một khoảng tin cậy
- D. Xác định một khoảng dao động nào đó, mà trong đó ước lượng thật của kết quả sẽ không rơi vào khoảng đó với một độ tin cậy nhất định

[
]

Việc khái quát hóa kết quả nghiên cứu từ một mẫu nhỏ cho một quần thể lớn hơn có thể gặp, TRỪ:

- A. Khả năng là sự suy luận đó là không chính xác
- B. Là do may rủi hay do biến thiên mẫu
- C. Do cỡ mẫu lớn
- D. Do sai số trong quá trình triển khai nghiên cứu

[
]

Cỡ mẫu nghiên cứu ảnh hưởng tới TRỪ:

- A. Độ biến thiên của ước lượng tham số mẫu và tham số quần thể
- B. Giá trị ước lượng của tham số quần thể mà không ảnh hưởng tới giá trị ước lượng của tham số mẫu
- C. Khả năng rằng kết quả sẽ phản ánh đúng tình trạng của toàn bộ quần thể
- D. Vai trò của may rủi xen vào giá trị của các kết quả nghiên cứu

[
]

Nội dung KHÔNG thuộc đặc điểm của kiểm định giả thuyết là:

- A. Là tiến hành một trắc nghiệm thống kê và xác định mức độ biến thiên mẫu ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu.
- B. Dựa vào giá trị của các trắc nghiệm thống kê để tìm ý nghĩa xác suất (giá trị P)
- C. Giá trị P nhiều khi không chỉ ra xác suất trị số quan sát được xảy ra là do các yếu tố may rủi hay không
- D. Giá trị của ý nghĩa thống kê càng lớn, giá trị P càng nhỏ.

[
]

Ngưỡng của giá trị P xác định sự kết hợp có ý nghĩa thống kê là:

- A. Không cố định và tùy thuộc vào từng lĩnh vực nghiên cứu
- B. Luôn luôn lấy ngưỡng là 0,05
- C. Nếu giá trị P nhỏ hơn hay bằng 0,05 có nghĩa rằng 5% các kết hợp quan sát được có giá trị lớn hơn kết quả của nghiên cứu là do may rủi
- D. Nếu giá trị P nhỏ hơn hay bằng 0,05 có nghĩa rằng có sự kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh, và may rủi không đóng vai trò trong nghiên cứu

[
]

Các nội dung sau liên quan tới giá trị P trong các trắc nghiệm thống kê, TRỪ:

- A. Mức độ khác nhau giữa các nhóm hay độ mạnh của sự kết hợp và cỡ mẫu
- B. Vai trò của cỡ mẫu lớn
- C. Vai trò của biến thiên mẫu do cỡ mẫu nhỏ
- D. Luôn luôn dựa vào giá trị P để đưa ra kết luận về ảnh hưởng của một yếu tố

[
]

Trong các báo cáo bao giờ cũng nên TRỪ:

- A. Ghi lại giá trị p của kết hợp bên cạnh kết quả, chứ không đơn thuần chỉ nêu là kết quả có hay không có ý nghĩa thống kê ở một ngưỡng xác suất nào đó
- B. Loại bỏ các yếu tố mà kết quả kiểm định có $p > 0,05$
- C. Đề xuất cần phải tiếp tục làm một nghiên cứu khác với cỡ mẫu thích hợp nếu kết quả kiểm định chưa đạt ý nghĩa thống kê nhưng giá trị p đó gần với 0,05.
- D. Ghi các giá trị cụ thể của p dù ở ngưỡng $\leq$ hay $>$ ngưỡng xác suất định trước (0,05)

[
]

Nội dung KHÔNG thuộc đặc điểm của khoảng tin cậy là

- A. Là một chỉ số đánh giá rất tốt vai trò của may rủi
- B. Biểu thị một khoảng số trong đó trị số thật của kết quả chắc chắn sẽ rơi vào nội trong khoảng này
- C. Có thể cung cấp tất cả những thông tin về giá trị P liên quan tới kết luận rằng liệu có sự kết hợp có ý nghĩa thống kê ở một ngưỡng xác suất nào đó
- D. Không phản ánh mức độ biến thiên của giá trị ước lượng và ảnh hưởng của cỡ mẫu

[
]

Nội dung KHÔNG phù hợp với thông tin do khoảng tin cậy là:

- A. Rất quan trọng khi phiên giải kết quả nghiên cứu khi nó không có ý nghĩa thống kê
- B. Một khoảng tin cậy hẹp là kết quả của cỡ mẫu nhỏ sẽ hỗ trợ cho kết luận rằng không có sự tăng nguy cơ thật sự
- C. Một khoảng tin cậy rộng gợi ý rằng số liệu có thể nói lên có nguy cơ tăng lên (hay giảm đi) thực sự, nhưng cỡ mẫu không đủ để đạt lực thống kê để loại TRỪ may rủi
- D. Giá trị P và khoảng tin cậy cùng cung cấp thông tin về may rủi

[
]

Mục đích vận dụng trị P trong việc đánh giá vai trò của may rủi, TRỪ:

- A. Chỉ là chỉ dẫn về khả năng may rủi ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu

- B. Giá trị P rất nhỏ hoàn toàn có thể loại TRỪ hoàn toàn may rủi
- C. Sự khác biệt là rất nhỏ và không có ý nghĩa lâm sàng, nó có thể vẫn có ý nghĩa thống kê, mà không phải là do may rủi, nếu cỡ mẫu lớn
- D. Ngược lại, sự khác biệt lớn và có ý nghĩa lâm sàng có thể không đạt ý nghĩa thống kê nếu cỡ mẫu nhỏ

[
]

Ý nghĩa thống kê và khoảng tin cậy KHÔNG giúp

- A. Đánh giá vai trò của may rủi ảnh hưởng đến sự kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh
- B. Đánh giá vai trò của cỡ mẫu ảnh hưởng đến sự kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh
- C. Cung cấp thông tin về ảnh hưởng của các sai số hệ thống và nhiễu đến sự kết hợp
- D. Đưa ra kết luận về vai trò của yếu tố nguy cơ chỉ về mặt thống kê

[
]

Cá nội dung sau là đặc điểm của các loại sai số trong kiểm định giả thuyết, TRỪ

- A. Sai số loại I hay sai số α : Giả thuyết Ho đúng và chúng ta bác bỏ giả thuyết Ho
- B. Sai số loại I hay sai số α : Giả thuyết Ho đúng và chúng ta giữ giả thuyết Ho
- C. Sai số loại II hay sai số β : Giả thuyết H1 đúng và chúng ta chấp nhận giả thuyết Ho
- D. Xác suất mắc sai số loại I (sai số α) tương đương với giá trị P

[
]

Lực mẫu được định nghĩa là TRỪ:

- A. Khả năng bác bỏ giả thuyết H_0 và kết luận rằng có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm nghiên cứu nếu sự khác nhau đó là có thực
- B. Lực mẫu bằng $1 - \beta$
- C. Lực mẫu bằng $1 - \alpha$
- D. Nếu beta là 0,20 có nghĩa là khả năng phát hiện sự khác nhau giữa hai nhóm nếu sự khác nhau đó tồn tại là 80%.

[
]

Nội dung KHÔNG phải là đặc điểm của sai số hệ thống là:

- A. Là sai số hệ thống là bất kỳ sai số nào trong quá trình nghiên cứu làm sai lệch ước lượng sự kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh
- B. Ảnh hưởng của các sai số hệ thống là rất khó đánh giá, thậm chí là không thể đánh giá được khi phân tích kết quả nghiên cứu
- C. Khi thiết kế và tiến hành thực thi nghiên cứu cần lường trước được các sai số hệ thống có thể nảy sinh và tiến hành các bước để hạn chế chúng
- D. Hậu quả của sai số hệ thống có thể điều chỉnh được trong khi phân tích kết quả nghiên cứu

[
]

Nội dung KHÔNG phù hợp với sai số hệ thống là:

- A. Rất khó có thể được không chế một cách dễ dàng
- B. Trong quá trình phiên giải kết quả nghiên cứu ta vẫn phải coi trọng việc đánh giá vai trò của các sai số hệ thống
- C. Cần xác định chiều hướng và mức độ ảnh hưởng của sai số hệ thống đến kết quả nghiên cứu kể cả khi đó lường trước được ở giai đoạn thiết kế
- D. Tăng cỡ mẫu sẽ làm giảm tối đa sai số hệ thống

[
]

Loại sai số KHÔNG phải là sai số hệ thống là:

- A. Sai số chọn
- B. Sai số do tính toán cỡ mẫu
- C. Sai số thông tin
- D. Sai số quan sát

[
]

Nội dung KHÔNG phù hợp với đặc điểm của sai số chọn là:

- A. Sai số chọn sẽ có thể nảy sinh khi việc xác định những cá thể là đối tượng nghiên cứu vào trong các nhóm nghiên cứu, dựa trên những tiêu chuẩn khác nhau
- B. Sai số chọn đặc biệt hay gặp phải trong các nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thuần tập hồi cứu
- C. Sai số chọn đặc biệt hay gặp phải trong nghiên cứu thuần tập vì tình trạng phơi nhiễm đó được biết chắc chắn trước khi bệnh xuất hiện
- D. Sai số chọn có thể xảy ra nếu có sự khác nhau đáng kể giữa các cá thể được chọn vào nghiên cứu hơn và những người đủ tư cách nhưng không được chọn vào nghiên cứu

[
]

Các loại sai số chọn có thể là TRỪ:

- A. Sai số chẩn đoán
- B. Sai số giám sát
- C. Sai số sắp xếp cá thể vào nghiên cứu
- D. Sai số ngẫu nhiên

[
]

(Case study - trả lời câu hỏi {<1>}) Một nghiên cứu đưa ra kết quả là có một ước lượng trội rất cao sự kết hợp giữa việc sử dụng viên tránh thai với bệnh tắc mạch máu.

(<1>) Kết quả này có thể do các nguyên nhân sau TRỪ:

- A. Các thầy thuốc biết trước về sự kết hợp dương tính giữa sử dụng viên tránh thai với tắc mạch máu
- B. Tất cả các phụ nữ vào viện đều được hỏi xem đó sử dụng thuốc tránh thai để sàng lọc bệnh tắc mạch phổi
- C. Tất cả các phụ nữ vào viện nếu không có tiền sử dụng thuốc tránh thai thì bác sĩ không đặt vào nhóm có nguy cơ tắc mạch phổi
- D. Phụ nữ dùng thuốc tránh thai thường ít khi đi đến bệnh viện khám thai

[
]

(**Case study** - trả lời câu hỏi {<1>}) Một nghiên cứu về sự kết hợp giữa dùng oestrogen ngoại sinh với ung thư tử cung cho thấy sự gia tăng nguy cơ ung thư tử cung ở phụ nữ dùng oestrogen.

(<1>) Sự gia tăng nguy cơ ung thư tử cung ở phụ nữ dùng oestrogen có thể do các nguyên nhân sau TRỪ:

- A. Phụ nữ biết được dùng oestrogen ngoại sinh có thể làm tăng nguy cơ ung thư tử cung thường bị nên thường đến bệnh viện khám
- B. Khả năng được chẩn đoán ung thư cổ tử cung cao hơn ở các phụ nữ có dùng oestrogen
- C. Bác sĩ biết được giả thuyết này nên tăng cường sàng lọc ở phụ nữ dùng oestrogen ngoại sinh
- D. Những người dùng oestrogen ngoại sinh là những người ở độ tuổi có nguy cơ cao

[
]

Sai số từ chối hoặc sai số không trả lời KHÔNG phải là:

- A. Là sai số may rủi
- B. Là sai số hệ thống
- C. Nảy sinh từ sự từ chối hoặc không trả lời của những cá thể trong bất kỳ nhóm nào ở hai nhóm nghiên cứu
- D. Là sai số chọn

[
]

Sai số quan sát (hoặc sai số thông tin) bao gồm các loại sai số sau TRỪ:

- A. Sai số nhớ lại
- B. Sai số phỏng vấn
- C. Sai số từ chối
- D. Sai số phân loại

[
]

Sai số quan sát sẽ xảy ra, TRỪ:

- A. Khi có sự khác nhau một cách có hệ thống trong việc thu nhập những thông tin về phơi nhiễm hoặc về bệnh từ hai nhóm trong nghiên cứu
- B. Khi có sự khác nhau một cách có hệ thống trong việc thu nhập những thông tin về tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng vào nghiên cứu từ hai nhóm trong nghiên cứu
- C. Khi các điều tra viên thu thập số liệu khác nhau
- D. Khi điều tra viên không áp dụng đúng các bước được tập huấn trong điều tra để phỏng vấn đối tượng điều tra

[
]

Sai số nhớ lại xảy ra TRỪ khi các cá thể ở nhóm phơi nhiễm:

- A. Nhớ sai về tình trạng phơi nhiễm của bản thân
- B. Thường báo cáo tình trạng phơi nhiễm trước đây của họ khác với nhóm cá thể không bị bệnh đó.
- C. Từ chối báo cáo về tình trạng phơi nhiễm đó
- D. Báo cáo tình trạng phơi nhiễm của họ không khác biệt gì so với nhóm không phơi nhiễm

[
]

Sai số thu thập thông tin là bất cứ một sai khác hệ thống nào trong các việc sau TRỪ:

- A. Khai thác thu thập thông tin
- B. Ghi chép thông tin,
- C. Phiên giải thông tin
- D. Phân loại đối tượng vào điều tra

[
]

Sai số thu thập thông tin thường xảy ra trong các nghiên cứu sau TRỪ:

- A. Trong các nghiên cứu bệnh chứng
- B. Trong các nghiên cứu thuần tập hồi cứu
- C. Trong các nghiên cứu có liên quan đến việc đánh giá tình trạng phơi nhiễm về sự hiểu biết rõ về tình trạng bệnh có thể dẫn đến việc khai thác sai lệch về tiền sử phơi nhiễm.
- D. Trong các nghiên cứu thuần tập tương lai

[
]

Sai số bỏ cuộc chỉ xảy ra, TRỪ

- A. Trong các nghiên cứu thuần tập tương lai
- B. Trong các nghiên cứu thuần tập hồi cứu
- C. Trong trường hợp có sự bỏ cuộc của đối tượng nghiên cứu sau một thời gian dài hoặc ngắn đến khi xuất hiện hậu quả bệnh
- D. Khi số người bỏ cuộc không theo dõi được này lại có tình trạng không khác gì so với những người tham dự nghiên cứu về cả phơi nhiễm và bệnh

[
]

Sai số phân loại xảy ra khi, TRỪ

- A. Người nghiên cứu phân loại nhầm lẫn về tình trạng phơi nhiễm
- B. Người nghiên cứu phân loại nhầm lẫn về tình trạng bệnh của những người tham gia nghiên cứu
- C. Người nghiên cứu xếp lẫn nhóm có bệnh và nhóm không bệnh
- D. Người nghiên cứu xếp lẫn nhóm tham gia nghiên cứu và nhóm không tham gia nghiên cứu

[
]

Ảnh hưởng của sai số phân loại phụ thuộc vào, TRỪ

- A. Sự xếp lẫn phơi nhiễm (hay bệnh) có độc lập với bệnh (hay phơi nhiễm) hay không
- B. Nếu xếp lẫn là ngẫu nhiên (hay không khác biệt) thì tỷ lệ các cá thể bị xếp lẫn về một sự kiện có thể xấp xỉ bằng nhau
- C. Nếu xếp lẫn là ngẫu nhiên (hay không khác biệt) thì tỷ lệ các cá thể bị xếp lẫn về một sự kiện có thể xấp xỉ không bằng nhau
- D. Nếu xếp lẫn là không ngẫu nhiên thì tỷ lệ các cá thể bị xếp lẫn về một sự kiện có thể không xấp xỉ bằng nhau

[
]

Chọn quần thể nghiên cứu không chế sai số hệ thống bằng các cách sau TRỪ:

- A. Lựa chọn các cá thể đối chứng ở bệnh viện trong các nghiên cứu bệnh chứng

B. Chọn quần thể dễ xác định về nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi thường trú và những tính chất tương tự khác

C. Chọn quần thể có nguy cơ phát triển hậu quả nghiên cứu hoặc quan tâm tới nghiên cứu

D. Chọn quần thể di động và không đồng nhất để đảm bảo tính đại diện

[
]

Nội dung KHÔNG đúng với đặc điểm của yếu tố nhiễu trong nghiên cứu là:

A. Một yếu tố làm sai lệch ảnh hưởng của phơi nhiễm đối với bệnh như là vai trò của một yếu tố thứ ba

B. Một yếu tố nguy cơ đối với bệnh

C. Là một yếu tố có liên quan với phơi nhiễm nhưng lại không phụ thuộc vào phơi nhiễm nghiên cứu

D. Nhiều là yếu tố trung gian thứ ba xen vào giữa vào kết hợp nguy cơ và bệnh

[
]

Đặc điểm KHÔNG phải là bản chất của yếu tố nhiễu là:

A. Nhiều làm tăng hay giảm ước lượng sự kết hợp thật giữa phơi nhiễm và bệnh (ước lượng trội hay non)

B. Đôi khi làm thay đổi cả chiều hướng của kết hợp quan sát được

C. Phải liên quan đến cả yếu tố phơi nhiễm và bệnh

D. Là hậu quả của yếu tố phơi nhiễm và là 1 trong các yếu tố nguyên nhân của bệnh

[
]

Các biện pháp sau không chế nhiễu trong thiết kế nghiên cứu TRỪ:

A. Chọn ngẫu nhiên

B. Thu hẹp phạm vi nghiên cứu

C. Ghép cặp

D. Làm mù

[
]

Thu hẹp phạm vi nghiên cứu để không chế nhiễu có thể gặp những bất lợi sau, TRỪ:

A. Giảm khó khăn trong việc đạt được cỡ mẫu cần thiết với lực mẫu thống kê mong muốn trong một khoảng thời gian hợp lý

B. Vẫn có thể còn tồn tại yếu tố nhiễu nếu tiêu chuẩn giới hạn chưa đủ hẹp

C. Không cho phép đánh giá sự kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh ở các mức độ khác nhau

D. Có thể làm giảm tính khái quát hóa kết quả nghiên cứu nhưng không ảnh hưởng đến tính giá trị của kết hợp quan sát được

[
]

Nhược điểm của biện pháp ghép cặp là, TRỪ:

A. Ghép cặp là kỹ thuật khó, tốn kém về kinh phí và thời gian

B. Rất khó chọn ra được những cặp ghép chặt chẽ theo đúng và đủ tiêu chuẩn về từng biến số nhiễu

C. Ghép cặp khó đạt được mẫu cỡ cần thiết

D. Ghép cặp không có khả năng đánh giá được hậu quả của yếu tố không được ghép cặp

[
]

Đánh giá vai trò của may rủi bằng các cách sau TRỪ:

A. Kiểm định giả thuyết

B. Giá trị P

C. Ghép cặp

D. Ước lượng một khoảng tin cậy

[
]

Đặc điểm của giá trị P trong trắc nghiệm thống kê, TRỪ:

A. Chỉ ra xác suất trị số quan sát được xảy ra là do các yếu tố may rủi

B. Càng nhỏ thì giá trị của ý nghĩa thống kê càng lớn

C. Ngưỡng của giá trị P là cố định cho mọi lĩnh vực nghiên cứu

D. Nếu $p < 0,05$ mà bác bỏ giả thuyết H_0 thì mắc sai lầm α

[
]

Nội dung KHÔNG đúng với đặc điểm của khoảng tin cậy là:

A. Có thể cung cấp tất cả những thông tin về giá trị P

B. Phản ánh mức độ biến thiên của giá trị ước lượng

C. Cỡ mẫu càng lớn khoảng tin cậy càng hẹp

D. Cỡ mẫu càng nhỏ khoảng tin cậy càng hẹp

[
]

Nguyên tắc phiên giải kết quả của trắc nghiệm thống kê là, TRỪ:

A. Không được áp dụng máy móc và cứng nhắc giá trị P

B. Ý nghĩa thống kê chưa cần nhắc tới ý nghĩa sinh học hay lâm sàng

C. Giá trị p đã chứa đựng thông tin về sai số hệ thống

D. Giá trị p chưa chứa đựng thông tin về yếu tố nhiễu

[
]

Nội dung KHÔNG phù hợp với đặc điểm của sai số chọn là:

A. Có thể xảy ra bất kỳ trong quá trình xác định các cá thể trong nghiên cứu

B. Thường hay xảy ra với nghiên cứu thuần tập tương lai

C. Thường gặp trong chẩn đoán, giám sát, và sắp xếp cá thể vào nghiên cứu

D. Có thể xảy ra khi đối tượng nghiên cứu từ chối trả lời

[
]

Sai số quan sát bao gồm các loại sai số sau đây TRỪ:

A. Sai số nhớ lại

B. Sai số phỏng vấn

C. Sai số bỏ cuộc

D. Sai số lựa chọn

[
]

Không chế sai số hệ thống gồm các biện pháp sau TRỪ:

A. Lựa chọn quần thể nghiên cứu thích hợp

B. Lựa chọn phương pháp và công cụ thu thập thông tin thích hợp

C. Lựa chọn điều tra viên và tập huấn

D. Lựa chọn đối tượng nghiên cứu và tập huấn

[
]

Đặc điểm KHÔNG đúng với yếu tố Nhiễm là:

- A. Nằm ngoài kết hợp phôi nhiễm và bệnh
- B. Làm thay đổi mức độ kết hợp giữa phôi nhiễm và bệnh
- C. Có liên quan tới cả phôi nhiễm và bệnh
- D. Kết hợp giữa nhiễm và bệnh không phải là kết hợp căn nguyên

[
]

Biện pháp KHÔNG phải biện pháp khống chế nhiễm là:

- A. Chọn ngẫu nhiên
- B. Thu hẹp phạm vi nghiên cứu
- C. Ghép cặp
- D. Làm mù

[
]

Kỹ thuật ghép cặp dùng để:

- A. Kiểm soát các biến số đã được biết là có ảnh hưởng đến sự phân bố của bệnh nhóm bệnh và nhóm chứng mà ta nghiên cứu ở cả hai
- B. Có thể nghiên cứu được ảnh hưởng của các biến số được ghép cặp
- C. Kết quả không được quy cho ảnh hưởng của các biến số được ghép cặp
- D. Dùng trong nghiên cứu bệnh chứng mà không dùng trong nghiên cứu thuần tập

[
]

Ghép cặp là kỹ thuật:

- A. Không được cân nhắc đến cả khi thiết kế và phân tích nghiên cứu
- B. Làm tăng cỡ mẫu nghiên cứu
- C. Ghép cặp làm triệt tiêu yếu tố nhiễu
- D. Ghép cặp làm triệt tiêu yếu tố nguy cơ

[
]

Chọn câu trả lời SAI. Những hạn chế của kỹ thuật ghép cặp là

- A. Ghép cặp là kỹ thuật khó
- B. Không tốn kém về kinh phí và thời gian
- C. Rất khó chọn ra được những cặp ghép chặt chẽ theo đúng và đủ tiêu chuẩn về từng biến số nhiễu
- D. Ghép cặp không có khả năng đánh giá được hậu quả của một yếu tố được ghép cặp

[<g>]CHẨN ĐOÁN CỘNG ĐỒNG[</g>]

Nội dung nào KHÔNG phù hợp với đặc điểm của cộng đồng (community) là:

- A. Một nhóm người được tổ chức thành một đơn vị
- B. Một nhóm người có chung một đặc trưng, một quyền lợi hay một mối quan tâm nào đó
- C. Cộng đồng có thể nhỏ như một xóm, một cụm dân cư, một bệnh viện, trường học, xã, huyện đến những vùng rộng lớn như một quốc gia
- D. Mỗi cộng đồng có chung tất cả những vấn đề sức khỏe

[
]

Đặc điểm đúng về Sức khỏe là, TRỪ:

- A. Thoải mái hoàn toàn về thể chất

B. Thoải mái hoàn toàn về tinh thần và xã hội

C. Không có bệnh

D. Không phải chỉ là không có bệnh

[
]

Chẩn đoán sức khỏe cộng đồng KHÔNG nhằm:

A. Mô tả sự phân bố những đặc trưng của sức khỏe trong cộng đồng

B. Phát hiện ra những yếu tố nguy cơ

C. Xác định được những nhóm người có nguy cơ cao với một số bệnh nào đó

D. Xác định tình trạng bệnh của cá nhân trong cộng đồng

[
]

Chẩn đoán cá nhân KHÔNG có mục đích:

A. Phát hiện vấn đề sức khỏe cho một cá nhân

B. Thường thực hiện tại các cơ sở y tế

C. Để điều trị bệnh cho một cá nhân

D. Để từ đó chẩn đoán sức khỏe cộng đồng

[
]

Sức khỏe cộng đồng KHÔNG là:

A. Một trong những cố gắng của toàn xã hội nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mọi người thông qua các hoạt động tập thể hay xã hội

B. Sự kết hợp các ngành khoa học, các thực hành và quan niệm về sức khỏe nhằm giữ gìn và nâng cao sức khỏe cho mọi người thông qua các hoạt động tập thể

C. Các chương trình nhấn mạnh vào phòng bệnh và nhu cầu sức khỏe của người dân.

D. Các chương trình can thiệp cho cộng đồng những người nhập viện

[
]

Chẩn đoán cộng đồng KHÔNG bao gồm nội dung:

A. Điều tra chọn mẫu

B. Sử dụng nhiều kỹ thuật để thu thập thông tin

C. Khai thác cùng một lúc cả thông tin về cả bệnh và yếu tố nguy cơ

D. Sàng lọc các bệnh nhân ở giai đoạn muộn

[
]

Mục tiêu chẩn đoán sức khỏe cộng đồng là TRỪ:

A. Xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng

B. Mô tả tình hình sức khỏe cộng đồng và các yếu tố căn nguyên

C. Mô tả chiều hướng sức khỏe của cộng đồng

D. Mô tả sử dụng dịch vụ y tế

[
]

Mục tiêu của chẩn đoán sức khỏe cộng đồng KHÔNG bao gồm:

A. Đánh giá hiệu quả của các chương trình can thiệp cộng đồng

B. Đánh giá sự tham gia của cộng đồng trong các chương trình y tế

C. Cung cấp thông tin cho việc xây dựng các chính sách y tế

D. Cung cấp thông tin cho lập ngân sách triển khai can thiệp cộng đồng
[
]

Nội dung đánh giá sức khỏe cộng đồng KHÔNG bao gồm:

- A. Điều tra nhân khẩu học, bao gồm thống kê sinh tử
- B. Các nguyên nhân mắc bệnh và tử vong theo tuổi giới và tình trạng kinh tế
- C. Sử dụng các dịch vụ y tế, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em
- D. Dinh dưỡng và sự phát triển thể lực ở trẻ em

[
]

Nội dung đánh giá sức khỏe cộng đồng KHÔNG Bao gồm:

- A. Thông tin về kinh tế, văn hoá xã hội, tập quán
- B. Tổ chức hệ dân sự
- C. Sức khỏe tâm thần, nguyên nhân của các stress
- D. Môi trường, đặc biệt nước, nhà ở, các vector truyền bệnh

[
]

Nội dung đánh giá sức khỏe cộng đồng KHÔNG bao gồm

- A. Kiến thức, thái độ, thực hành có liên quan chính sách y tế
- B. Dịch địa phương
- C. Các loại dịch vụ và các nguồn lực sẵn có như nông nghiệp, thú y, xã hội
- D. Hệ thống y tế

[
]

Nội dung đánh giá sức khỏe cộng đồng KHÔNG bao gồm:

- A. Sự tham gia của cộng đồng vào chăm sóc sức khỏe ban đầu và y học cổ truyền
- B. Nguyên nhân thất bại của các chương trình sức khỏe trước đó và những khó khăn thách thức tồn tại trong cộng đồng
- C. Đánh giá vai trò y tế thôn bản
- D. Các dịch sẵn có trên địa bàn

[
]

Phương pháp nghiên cứu mô tả đánh giá sức khỏe cộng đồng là, TRỪ:

- A. Nghiên cứu về hình thái xuất hiện bệnh có liên quan đến các biến số như con người, không gian, thời gian
- B. Nghiên cứu tóm tắt một cách có hệ thống số liệu cơ bản về sức khỏe, nguyên nhân gây bệnh chủ yếu và tử vong
- C. Nghiên cứu mô tả các vấn đề sức khỏe của cộng đồng và các yếu tố ảnh hưởng
- D. Nghiên cứu giải thích bản chất của vấn đề sức khỏe

[
]

Mục đích chủ yếu của nghiên cứu mô tả KHÔNG bao gồm:

- A. Đánh giá chiều hướng của sức khỏe cộng đồng, so sánh giữa các vùng trong một nước hay giữa các nước

B. Cung cấp cơ sở cho việc vạch kế hoạch và đánh giá các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe

C. Xác định vấn đề cần nghiên cứu, hình thành giả thuyết, được kiểm định bằng các nghiên cứu phân tích tiếp theo

D. Giải thích tầm cỡ, qui mô của vấn đề sức khỏe

[
]

Loại sau đây KHÔNG phải là phương pháp mô tả là:

A. Nghiên cứu tương quan (correlation study): Nghiên cứu các hình thái của bệnh trong quần thể.

B. Báo cáo bệnh (case reports) hay đợt bệnh (case series)

C. Nghiên cứu các nguy hại

D. Điều tra ngang (cross- sectional surveys)

[
]

Đặc điểm của nghiên cứu tương quan là, TRỪ:

A. Mô tả mối liên quan của bệnh với một yếu tố mà ta quan tâm

B. Là cơ sở để tìm mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc

C. Luôn gồm 3 đại lượng

D. Không chỉ ra được nguyên nhân và hậu quả

[
]

Đặc điểm của Hệ số tương quan r là, TRỪ:

A. Là thông số mô tả mối quan hệ trong nghiên cứu tương quan

B. Xác định về mặt số lượng mối quan hệ tuyến tính giữa phơi nhiễm và bệnh

C. Thể hiện với mỗi thay đổi về mức độ phơi nhiễm, tần số mắc bệnh tăng hay giảm tương ứng theo

D. Giá trị của hệ số tương quan có thể thay đổi từ 0 đến +1

[
]

Nội dung KHÔNG phù hợp với nghiên cứu ngang/Điều tra ngang (cross-sectional surveys) là:

A. Là một nghiên cứu trong đó tình trạng bệnh và phơi nhiễm được đánh giá đồng thời ở một quần thể xác định tại một thời điểm

B. Cung cấp "hình ảnh chụp nhanh" về diễn biến sức khỏe của dân chúng ở một thời điểm đặc biệt

C. Cung cấp thông tin có giá trị đối với các nhà lãnh đạo y tế công cộng trong việc đánh giá tình trạng sức khỏe và các nhu cầu chăm sóc y tế của nhân dân

D. Khó cung cấp thông tin về tỷ lệ mới mắc bệnh toàn bộ các bệnh cấp tính và mãn tính, tình trạng mất khả năng lao động, việc sử dụng các dịch vụ y tế, các đặc trưng về cá nhân và nhân khẩu học

[
]

Điều tra ngang KHÔNG tiến hành dưới dạng:

A. Một cuộc điều tra sức khỏe của quần thể, thông qua việc chọn mẫu ngẫu nhiên các cá thể từ một quần thể

B. Các đối tượng nghiên cứu được hỏi theo bảng câu hỏi chuẩn mực

C. Các đối tượng nghiên cứu được khám về thể lực và xét nghiệm

D. Nhiều cuộc điều tra trên một nhóm thuần tập

[
]

Điểm nào KHÔNG phải là nhược điểm chính của điều tra ngang là:

A. Không thể xác định được bệnh xảy ra là do phơi nhiễm hay phơi nhiễm chỉ là hậu quả của bệnh.

B. Không tính được tỉ lệ mới mắc

C. Không phân tích được nguy cơ

D. Không tốn kém

[
]

Mục tiêu của điều tra ngang KHÔNG bao gồm:

A. Đáp ứng mục tiêu của chẩn đoán cộng đồng

B. Giúp các nhà quản lý y tế trong điều hành, đánh giá tình trạng sức khỏe, đánh giá các chương trình y tế và các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân

C. Hình thành và kiểm định được một giả thuyết nghiên cứu

D. Ước lượng về số mới mắc (Incidence) thông qua hai cuộc điều tra ngang

[
]

Bước KHÔNG thuộc các bước tiến hành một cuộc điều tra ngang sức khỏe cộng đồng là:

A. Xác định vấn đề nghiên cứu

B. Thảo luận với lãnh đạo địa phương và lãnh đạo của tuyến trung ương

C. Xây dựng mục tiêu điều tra

D. Lập kế hoạch điều tra

[
]

Nội dung KHÔNG phù hợp với đặc điểm của biến số là:

A. Một đặc tính của người, vật, sự việc, hiện tượng mà có thể mang các giá trị khác nhau

B. Có thể là tiêu thức của đối tượng nghiên cứu

C. Có thể là các yếu tố bên ngoài như môi trường tự nhiên, xã hội ảnh hưởng đến đối tượng nghiên cứu

D. Giá trị của biến số thường giống nhau giữa các cá thể trong cùng một quần thể, giữa các lần quan sát

[
]

Phân loại biến số theo biến định lượng KHÔNG gồm:

A. Biến liên tục

B. Biến rời rạc

C. Biến tỷ số

D. Biến khoảng chia

[
]

Đặc điểm của giá trị trung bình và độ lệch chuẩn là, TRỪ:

- A. Trong biến tỉ suất, khi độ lệch chuẩn (s) lớn hơn giá trị trung bình ($\bar{X}$) thì số liệu đó thường ít có ý nghĩa
- B. Trong biến khoảng chia khi độ lệch chuẩn (s) lớn hơn giá trị trung bình ($\bar{X}$) thì số liệu đó lại có ý nghĩa
- C. Bản chất của giá trị zero trong biến khoảng chia là không có thực
- D. Với biến khoảng chia, ta có thể nói 60°C nóng gấp 3 lần 20°C

[
]

Các biến định tính KHÔNG bao gồm các loại:

- A. Biến danh mục
- B. Biến thứ hạng
- C. Biến nhị phân
- D. Biến mức độ

[
]

Đặc điểm của biểu thị biến là, TRỪ:

- A. Một biến có thể là định lượng nhưng cũng có thể là định tính tùy theo cách ký hiệu
- B. Khi biến huyết áp tối đa của đối tượng nghiên cứu biểu thị bằng số đo mmHg, thì nó là 1 biến liên tục
- C. Khi biến huyết áp tối đa của đối tượng nghiên cứu biểu thị bằng mức độ cao huyết áp (không cao, cao, rất cao) thì nó lại là 1 biến biến danh mục
- D. Các biến định lượng và định tính cuối cùng đều có thể chuyển sang dạng biến nhị phân nếu như chúng ta có được 1 mốc để chuyển dạng

[
]

Đặc điểm của biến đổi số liệu là, TRỪ:

- A. Khi số liệu được thu thập dưới dạng biến định lượng thì sau này có thể dễ dàng chuyển sang biến định tính
- B. Nếu số liệu khi thu thập đó là 1 biến định tính thì không thể chuyển sang dạng 1 biến định lượng được nữa
- C. Nếu 1 người có huyết áp tối đa là 150 mmHg thì ta có thể xếp người đó vào nhóm cao huyết áp
- D. Khi phân tích số liệu thì 1 biến số ở dạng biến định lượng và định tính có giá trị như nhau

[
]

Đặc điểm phân loại biến theo mối quan hệ giữa các biến số là, TRỪ:

- A. Biến độc lập
- B. Biến phụ thuộc
- C. Biến chuyển động
- D. Biến hậu quả

[
]

Đặc điểm của biến độc lập là, TRỪ:

- A. Có thể là nguyên nhân hoặc là yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề đang được nghiên cứu

- B. Trong y học, biến này thường là các yếu tố nguy cơ
- C. Nó có liên quan tới biến hậu quả và không chịu sự chi phối của yếu tố nhiễu
- D. Nó tồn tại 1 cách độc lập, không chịu sự chi phối của yếu tố “quả”

[
]

Đặc điểm của biến phụ thuộc là, TRỪ:

- A. Là biến số được sử dụng để mô tả hoặc đo lường vấn đề cần nghiên cứu
- B. Nó thường là các vấn đề sức khỏe mà người nghiên cứu mong muốn khảo sát
- C. Nó có thể là hậu quả trong mối liên quan với nhiều yếu tố khác
- D. Giá trị của nó thường không phụ thuộc vào sự biến đổi của các biến ảnh hưởng đến nó.

[
]

Tiêu chuẩn 1 yếu tố được gọi là nhiễu là, TRỪ:

- A. Phải là một yếu tố nguy cơ đối với bệnh
- B. Phải có liên quan với phơi nhiễm nhưng lại không phụ thuộc vào phơi nhiễm.
- C. Là yếu tố trung gian giữa yếu tố phơi nhiễm và bệnh
- D. Phải thực sự tác động lên mối tương quan giữa phơi nhiễm và bệnh. Điều này chỉ có thể được khẳng định trong quá trình phân tích số liệu (sẽ được trình bày ở phần sau)

[
]

Sử dụng test thống kê trong trường hợp dưới đây KHÔNG đúng là:

Loại biến số	Loại mẫu	Quan sát độc lập	Quan sát ghép cặp
Biến danh mục (<i>nomial</i>)	Mẫu nhỏ	A	B
	Mẫu lớn	C	D

- A. Test chính xác của Fisher
- B. Test Dấu hiệu (Sign)
- C. χ^2 test hoặc t test
- D. χ^2 test của McNemar

[
]

Sử dụng test thống kê trong trường hợp dưới đây KHÔNG đúng là:

Biến thứ hạng (<i>ordinal</i>)	Loại mẫu	Quan sát độc lập	Quan sát ghép cặp
	Hai nhóm	A	B
	Trên hai nhóm	C	D

- A. Test 2 nhóm của Wilcoxon hoặc Mann-Whitney U-test
- B. Wilcoxon signed-rank test
- C. Kruskal-Wallis 1-way ANOVA
- D. Friedman 1-way ANOVA

[
]

Sử dụng test thống kê trong trường hợp dưới đây KHÔNG đúng là:

Biến định lượng (<i>quantitative</i>)	Loại mẫu	Quan sát độc lập	Quan sát ghép cặp
	Hai nhóm	A	B
	Trên hai nhóm	C	D

A. Test t-student hoặc χ^2 test

B. t-test ghép cặp

C. F-test (ANOVA)

D. t-test ghép cặp

[
]

Xác định các biến số trong nghiên cứu KHÔNG thông qua:

A. Dựa vào kiến thức, kinh nghiệm của người nghiên cứu và tham khảo tài liệu

B. Áp dụng phương pháp cộng đồng cùng tham gia (community participation)

C. Phân tích cây vấn đề

D. Phân tích khung logic

[
]

Lựa chọn KHÔNG phải là chỉ số nghiên cứu là:

A. Kết hợp của nhiều biến số

B. BMI được gọi là chỉ số

C. Chiều cao được xem là một chỉ số

D. Thang điểm là một dạng đặc biệt của chỉ số

[
]

Nội dung KHÔNG phù hợp với nội dung của lập kế hoạch điều tra là:

A. Là một lịch trình về các hoạt động của một nghiên cứu

B. Bao gồm bản dự trự kinh phí

C. Một kế hoạch có thể bao gồm Thời gian và địa điểm mà công việc đó cần thực hiện

D. Một kế hoạch có thể bao gồm Ai sẽ thực hiện công việc đó và cần thời gian bao lâu để hoàn thành

[
]

Đặc điểm của lập kế hoạch nghiên cứu là, TRỪ:

A. Giúp cho việc dự kiến các nguồn lực cần thiết cho nghiên cứu

B. Lường trước được các khó khăn, thuận lợi khi triển khai nghiên cứu

C. Giúp người tham gia nghiên cứu thực hiện đúng qui trình thu thập thông tin

D. Thống nhất các hoạt động giữa từng người, từng nhóm, tiết kiệm các nguồn lực

[
]

Biểu đồ GANTT thể hiện, TRỪ:

A. Nội dung công việc cần được thực hiện

B. Những ai chịu trách nhiệm thực hiện công việc đó?

C. Thời gian thực tế cần triển khai công việc

D. Khi nào công việc đó được thực hiện?

[
]

Nội dung KHÔNG phải là nội dung trong chẩn đoán cộng đồng là:

A. Huấn luyện điều tra viên và giám sát viên

B. Thử nghiệm điều tra

C. Khảo sát hệ thống

D. Chọn mẫu đại diện từ quần thể nghiên cứu

[
]

Nội dung KHÔNG phải là nội dung trong chẩn đoán cộng đồng là:

A. Điều tra thực địa

B. Phân tích trình bày số liệu

C. Viết báo cáo và phản hồi cho lãnh đạo trung ương

D. Tiến hành can thiệp

[
]

Đặc điểm của chẩn đoán cộng đồng là, TRỪ:

A. Gồm 15 bước

B. Là một cuộc điều tra ngang

C. Các vấn đề sức khỏe và yếu tố nguy cơ được đo lường tại cùng một thời điểm

D. Giúp chẩn đoán xác định các vấn đề sức khỏe của cộng đồng và từng cá nhân trong cộng đồng đó

[
]

[<g>] DỊCH TỄ HỌC HIV/AIDS [</g>]

Chọn một ý đúng trong các ý sau đây khi mô tả sự khác biệt của AIDS và HIV là:

A. AIDS và HIV là tên gọi khác nhau của một bệnh

B. AIDS là giai đoạn cuối của quá trình nhiễm virus HIV

C. AIDS là giai đoạn cửa sổ ngay sau khi nhiễm HIV

D. AIDS và HIV là tên gọi khác nhau của virus gây ra bệnh suy giảm miễn dịch mắc phải

[
]

Những trường hợp bệnh nhân mắc AIDS đầu tiên được phát hiện vào thập kỷ:

A. 80s của thế kỷ XX

B. 90s của thế kỷ XX

C. 70s của thế kỷ XX

D. 60s của thế kỷ XX

[
]

Mệnh đề KHÔNG đúng trong các mệnh đề sau đây khi nói về lịch sử dịch HIV là:

- A. Chính phủ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch HIV đã thống nhất với nhau về cách ứng phó ngay từ những năm tháng đầu tiên
- B. Kỳ thị và phân biệt đối xử đối với các hành vi của nhóm nguy cơ cao là một yếu tố làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV ở các nhóm này
- C. Kỳ thị và phân biệt đối xử với HIV là rào cản lớn đối với tính sẵn sàng đi xét nghiệm HIV và tiếp cận dịch vụ của nhóm có nguy cơ cao
- D. Các yếu tố kinh tế xã hội có vai trò quan trọng trong việc phát sinh, duy trì và phát triển của dịch HIV
- [
]

Mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây khi nói về lịch sử dịch HIV là:

- A. Việc huy động nguồn lực từng quốc gia và toàn cầu, đặc biệt từ sau Hội nghị thượng đỉnh 2001, có ý nghĩa quyết định trong nỗ lực phòng chống HIV/AIDS
- B. Những đột phá trong y học như việc tìm ra virus hay thuốc kiểm hãm sự phát triển virus HIV có ý nghĩa quyết định trong nỗ lực phòng chống HIV/AIDS
- C. Vai trò của ngành y và các cơ quan y tế lớn hơn vai trò các tổ chức xã hội và cộng đồng trong nỗ lực phòng chống HIV/AIDS
- D. Vai trò của các tổ chức xã hội và cộng đồng lớn hơn vai trò của ngành y và các cơ quan y tế trong nỗ lực phòng chống HIV/AIDS
- [
]

Virus HIV tấn công vào tế bào của hệ thống tế bào máu là:

- A. Hồng cầu
- B. Tiểu cầu
- C. Tế bào Lympho T4
- D. Tế bào khác, không thuộc các nhóm trên
- [
]

Quá trình tiến triển tự nhiên sau khi nhiễm HIV có:

- A. 5 giai đoạn
- B. 4 giai đoạn
- C. 3 giai đoạn
- D. 2 giai đoạn
- [
]

Giai đoạn cấp tính (giai đoạn cửa sổ) có ý nghĩa quan trọng trong dịch tễ học nhiễm HIV vì:

- A. Đây là thời kỳ tải lượng virus tăng cao và người nhiễm có nguy cơ tử vong cao
- B. Đây là thời kỳ tải lượng virus tăng cao nhưng không phát hiện được nhiễm HIV bằng các xét nghiệm tìm kháng thể
- C. Đây là giai đoạn cuối của nhiễm HIV khi bệnh nhân có nhiều biểu hiện nhiễm trùng cơ hội cấp tính

D. Đây là từng đợt tiến triển cấp tính trên một nền nhiễm HIV mạn tính và do đó có khả năng lây lan cao
[
]

Giai đoạn im lặng (không có triệu chứng) có ý nghĩa quan trọng trong dịch tễ học nhiễm HIV vì đây là giai đoạn:

- A. Người có HIV được phát hiện nhiều nhất
 - B. Người có HIV không có biểu hiện lâm sàng và trở thành nguồn lây trong cộng đồng
 - C. Người có HIV ít có khả năng lây lan ra cộng đồng
 - D. Người có HIV không có khả năng nói lên nhu cầu của mình
- [
]

Khi chuyển sang giai đoạn AIDS của quá trình nhiễm HIV bệnh nhân có thể có các biểu hiện sau đây:

- A. Tải lượng virus tăng cao
 - B. Số lượng tế bào Lympho T4 (CD4) giảm đi
 - C. Các biểu hiện nhiễm trùng cơ hội đặc trưng cho giai đoạn AIDS
 - D. Cả ba biểu hiện nói trên
- [
]

(Case study - trả lời câu hỏi {<1>}) Một người đàn ông 28 tuổi có tiếp xúc tình dục với phụ nữ mại dâm nghi nhiễm HIV cách đó 4 tuần

(<1>) Nhiễm HIV chắc chắn khi:

- A. ELISA (+)
- B. Western Blot (+)
- C. Tìm thấy ARN của virus HIV trong máu
- D. $CD4 < 200/mm^3$

[
]

Châu lục trên thế giới hiện nay có số người sống chung với HIV cao nhất là:

- A. Châu Á
- B. Châu Phi
- C. Châu Mỹ
- D. Châu Úc và Đại Tây Dương

[
]

Từ giữa những năm 2000s cho đến nay, số người sống chung với HIV trên toàn cầu tăng lên là do:

- A. Công tác phát hiện các trường hợp nhiễm HIV được cải thiện
- B. Số tử vong do AIDS giảm đi đáng kể do tiếp cận thuốc điều trị tốt hơn
- C. Số nhiễm mới HIV tăng lên do dự phòng không đạt hiệu quả
- D. Lý do A + B

[
]

Từ giữa những năm 2000s cho đến nay, số người chết vì HIV giảm đi đáng kể ở mức độ toàn cầu là do:

- A. Biến đổi gen của virus HIV làm giảm độc lực
- B. Tiếp cận điều trị ARV mở rộng trên phạm vi toàn cầu
- C. Nhiều trường hợp nhiễm HIV không được phát hiện do đó khi chết không được ghi nhận
- D. Lý do khác không thuộc một trong các lý do trên

[
]

Lây truyền qua tình dục đồng giới không an toàn là con đường lây truyền chính ở nước :

- A. Hoa Kỳ
- B. Trung Quốc
- C. Việt Nam
- D. Nam Phi

[
]

Lây truyền qua tình dục dị giới không an toàn là con đường lây truyền chính ở nước:

- A. Hoa Kỳ
- B. Trung Quốc
- C. Việt Nam
- D. Nam Phi

[
]

Lây truyền qua tiêm chích ma túy không an toàn là con đường lây truyền chính ở nước:

- A. Hoa Kỳ
- B. Thái Lan
- C. Việt Nam
- D. Nam Phi

[
]

Trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam vào thập kỷ:

- A. 70 của thế kỷ XX
- B. 80 của thế kỷ XX
- C. 90 của thế kỷ XX
- D. 10 của thế kỷ XXI

[
]

Khái niệm dịch HIV ở giai đoạn tập trung có nghĩa là:

- A. Tỷ lệ cao hơn 5% ở một số nhóm nguy cơ cao nhưng thấp hơn 1% ở quần thể chung
- B. Tỷ lệ cao hơn 10% ở một số nhóm nguy cơ cao nhưng thấp hơn 1% ở nhóm nguy cơ thấp
- C. Tỷ lệ cao hơn 10% ở một số nhóm nguy cơ cao và không cần quan tâm đến tỷ lệ ở quần thể chung
- D. Tỷ lệ cao hơn 5% ở một số nhóm nguy cơ cao nhưng thấp 1% ở những nhóm nguy cơ cao khác

[
]

Dịch HIV và AIDS ở Việt Nam hiện nay có đặc điểm là:

- A. Dịch tập trung ở một số tỉnh trọng điểm
- B. Dịch lan rộng ra quần thể không có nguy cơ cao
- C. Dịch tập trung ở quần thể nguy cơ cao
- D. Dịch lan rộng ở nhiều tỉnh trong cả nước

[
]

Đặc điểm lây nhiễm HIV ở Việt Nam trong những năm gần đây là:

- A. Chủ yếu qua đường tiêm chích ma túy không an
- B. Chủ yếu qua đường quan hệ tình dục không an toàn
- C. Đường tiêm chích ma túy là quan trọng nhưng có sự gia tăng lây nhiễm qua đường tình dục
- D. Đường tình dục là quan trọng nhưng có sự gia tăng lây nhiễm qua đường tiêm chích

[
]

Số trường hợp nhiễm HIV phát hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây có đặc điểm:

- A. Năm sau thấp hơn năm trước
- B. Năm sau cao hơn năm trước
- C. Năm sau và năm trước như nhau
- D. Không có số liệu so sánh chiều hướng

[
]

Tỷ lệ hiện nhiễm HIV qua giám sát trọng điểm ở các nhóm nguy cơ cao cho thấy:

- A. Tỷ lệ cao nhất ở nhóm tiêm chích ma túy
- B. Tỷ lệ cao nhất ở nhóm phụ nữ bán dâm
- C. Tỷ lệ cao nhất ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới
- D. Tỷ lệ ba nhóm nguy cơ cao nói trên xấp xỉ nhau

[
]

Trong ba nhóm nguy cơ cao (tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới) tỷ lệ hiện nhiễm ở nhóm có xu hướng tăng trong những năm gần đây là:

- A. Nhóm tiêm chích ma túy
- B. Nhóm phụ nữ bán dâm
- C. Nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới
- D. Cả ba nhóm đều thấy xu hướng tăng

[
]

Khi nói đến một nhóm có nguy cơ kép có nghĩa là nhóm đó có:

- A. Nguy cơ nhiễm HIV gấp hai lần các nhóm khác
- B. Nhiều loại hành vi nguy cơ khác nhau
- C. Tương tác với nhóm nguy cơ cao khác

D. Tương tác với nhóm nguy cơ thấp
[
]

Người ta đã phân lập được HIV từ nhiều dịch tiết cơ thể, nhưng những dịch tiết có nồng độ virus cao là:

- A. Máu, dịch sinh dục (nam hoặc nữ), và sữa mẹ
 - B. Máu, nước tiểu, và dịch sinh dục
 - C. Máu, dịch sinh dục và nước mắt
 - D. Máu, dịch sinh dục và nước bọt
- [
]

Các đường lây truyền chính của HIV là:

- A. Tình dục, máu, mẹ - con
 - B. Tình dục, máu, hôn
 - C. Máu, hôn, mẹ - con
 - D. Máu, tình dục và sử dụng chung đồ dùng cá nhân
- [
]

Trong các hành vi sau đây, hành vi có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất là:

- A. Tiêm chích chung bơm kim tiêm với người nhiễm HIV
 - B. Quan hệ tình dục sinh dục – âm đạo với người nhiễm
 - C. Quan hệ tình dục sinh dục – hậu môn với người nhiễm HIV
 - D. Mẹ nhiễm HIV cho con bú
- [
]

Yếu tố KHÔNG có vai trò quan trọng quy định xác suất lây nhiễm HIV là:

- A. Số lượng virus có trong máu hoặc dịch tiết cơ thể người nhiễm HIV
 - B. Đường vào của HIV (qua niêm mạc, máu trực tiếp hay da)
 - C. Có bệnh lây truyền qua đường tình dục trước đó hay không
 - D. Đã từng nhiễm HIV trước đó hay chưa
- [
]

Nguy cơ lây nhiễm HIV của nhân viên y tế là

- A. Nguy cơ rất đáng kể
 - B. Có nguy cơ nhưng không đáng kể
 - C. Hoàn toàn không có nguy cơ
 - D. Không có nghiên cứu lượng giá
- [
]

Mệnh đề đúng sau đây là:

- A. HIV có thể lây qua các tiếp xúc thông thường như bắt tay, ôm hôn người nhiễm
 - B. HIV không lây qua các tiếp xúc thông thường như bắt tay, ôm hôn người nhiễm
 - C. HIV chỉ lây qua quan hệ tình dục và tiêm chích không an toàn
 - D. Cán bộ y tế nhiễm HIV có nguy cơ lây sang bệnh nhân cao
- [
]

Biện pháp KHÔNG giúp phòng tránh HIV qua đường tình dục là:

- A. Hạn chế số lượng bạn tình, tốt nhất là thủy chung một bạn tình
- B. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục
- C. Quan hệ tình dục không xâm nhập
- D. Quan hệ tình dục xuất tinh bên ngoài

[
]

Biện pháp KHÔNG giúp phòng tránh HIV qua tiêm chích ma túy là:

- A. Sử dụng bơm kim tiêm sạch và riêng mỗi lần tiêm chích
- B. Sử dụng bơm kim tiêm riêng và thực hiện các biện pháp vô trùng phù hợp
- C. Sử dụng bơm kim tiêm chung với người mà mình biết chắc là không nhiễm HIV
- D. Sử dụng ma túy theo cách hút hoặc hít

[
]

Các biện pháp KHÔNG phải là biện pháp giảm hại cho người tiêm chích ma túy là:

- A. Trao đổi bơm kim tiêm đã qua sử dụng lấy bơm kim tiêm sạch
- B. Hướng dẫn vô trùng bơm kim tiêm đã qua sử dụng
- C. Điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế (ví dụ Methadone)
- D. Ngừng sử dụng ma túy hoàn toàn

[
]

Các biện pháp KHÔNG phải là biện pháp giảm hại cho người nam quan hệ tình dục đồng giới là:

- A. Kiên nhẫn không quan hệ tình dục
- B. Hạn chế số lượng bạn tình
- C. Sử dụng bao cao su mỗi lần quan hệ tình dục
- D. Quan hệ tình dục bằng các biện pháp không xâm nhập khi không có bao cao su

[
]

Để phòng ngừa nhiễm HIV qua con đường truyền máu cần:

- A. Làm xét nghiệm Western Blot cho tất cả người cho và người nhận máu
- B. Làm xét nghiệm ELISA với người cho máu
- C. Làm xét nghiệm ELISA + Western Blot cho người cho máu.
- D. Tất cả các câu trên đều sai

[
]

Để phòng ngừa nhiễm HIV do rủi ro nghề nghiệp, cán bộ y tế cần:

- A. Hỏi bệnh nhân mình tiếp xúc xem họ đã xét nghiệm HIV chưa và kết quả như thế nào
- B. Tìm cách từ chối khéo những bệnh nhân nghi ngờ thuộc nhóm nguy cơ cao
- C. Coi máu và dịch cơ thể của mọi bệnh nhân đều có thể có virus HIV và do đó thực hành biện pháp dự phòng chuẩn phổ quát
- D. Không có biện pháp nào nêu trên là phù hợp và hiệu quả

[
]

Hậu quả của đại dịch HIV với cộng đồng là:

- A. Tăng gánh nặng xã hội cho cộng đồng nói chung
- B. Tăng gánh nặng kinh tế đối với những người không nhiễm HIV
- C. Tăng sự nghi kỵ lẫn nhau trong cộng đồng nếu không có giải pháp phù hợp
- D. Tất cả các câu trên đều đúng

[
]

Hậu quả của đại dịch HIV với xã hội là:

- A. Giảm sức lao động của xã hội
- B. Tăng chi phí chăm sóc y tế và xã hội
- C. Tăng sự chia rẽ trong xã hội nếu không có các giải pháp phù hợp
- D. Tất cả các câu trên đều đúng

[
]

Hậu quả của đại dịch HIV với đời sống gia đình là:

- A. Tăng gánh nặng cho người chăm sóc chính thường là phụ nữ
- B. Tăng gánh nặng kinh tế và có thể dẫn đến nghèo hóa
- C. Tăng nguy cơ bị cô lập trong cộng đồng
- D. Tất cả các câu trên đều đúng

[
]

Mệnh đề sau đây KHÔNG đúng là:

- A. Phần lớn các cá nhân có nguy cơ cao không đi xét nghiệm HIV định kỳ là vì họ thiếu kiến thức về nguy cơ HIV của họ
- B. Phần lớn các cá nhân có nguy cơ cao không đi xét nghiệm HIV định kỳ là vì họ e ngại sự kỳ thị từ nhân viên y tế với hành vi của họ
- C. Phần lớn các cá nhân có nguy cơ cao không đi xét nghiệm HIV định kỳ là vì họ e ngại sự kỳ thị từ cộng đồng nếu họ phát hiện ra nhiễm HIV
- D. Phần lớn các cá nhân có nguy cơ cao không đi xét nghiệm HIV định kỳ là vì họ không biết phải làm gì nếu như phát hiện ra nhiễm HIV

[
]

Phân tích đúng cho mệnh đề: “HIV/ AIDS là vấn đề của những nhóm có nguy cơ cao. Nếu chúng ta có thể tác động tới những nhóm này để thay đổi hành vi của họ thì có thể hạn chế đáng kể nguy cơ HIV cho những nhóm quần thể khác.” là:

- A. Điều này đúng và tốt nhất là nên cách ly họ ra khỏi xã hội
- B. Điều này không đúng vì rất khó thay đổi hành vi những người có nguy cơ cao
- C. Điều này không đúng vì các nhóm quần thể khác không có tương tác với nhóm nguy cơ cao
- D. Điều này đúng nhưng đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội, kể cả những người có nguy cơ thấp để hạn chế việc kỳ thị, xa lánh những người nguy cơ cao

[
]

Phân tích đúng cho mệnh đề: “Chính quyền địa phương (một xã) phải hành động khẩn cấp. Cho đến nay chưa có nhiều người người nhiễm HIV vì vậy

chính quyền nên cách ly những người nhiễm HIV để bảo vệ cho những người khác” là:

A. Điều này đúng và cần phải tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ dân trong xã để phát hiện và cách ly

B. Điều này không đúng vì chỉ càng làm tăng sự che giấu. Cách tốt nhất để bảo vệ mọi người là giáo dục họ các đường lây truyền HIV để họ có thể bảo vệ cho bản thân họ

C. Điều này không đúng bởi vì nếu cách ly những người nhiễm HIV tại một nơi họ sẽ lây chéo cho nhau và dẫn đến bùng nổ dịch HIV trong xã.

D. Điều này đúng nhưng để phát hiện được người nhiễm HIV thì tốn kém vì vậy không nên làm

[
]

Phân tích đúng cho mệnh đề: “Cách tốt nhất để phòng HIV/AIDS là cấm các hoạt động mại dâm dưới mọi hình thức và TRỪ phạt những người nghiện chích ma túy để họ phải bỏ tiêm chích. Nếu chính phủ áp dụng những biện pháp như thế sẽ hạn chế được số người nhiễm HIV/AIDS” là:

A. Cách làm này là đúng và việc áp dụng các biện pháp như vậy đã cho thấy hiệu quả rõ rệt ở nhiều nơi.

B. Cách làm này không đúng vì đường lây truyền HIV quan trọng là tình dục đồng giới nam và nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới không tiêm chích ma túy và không bán dâm.

C. Cách làm này không đúng vì chỉ làm cho những người đó lẩn tránh. Ngược lại cần tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ cũng như đề nghị họ cộng tác tham gia vào chương trình phòng chống AIDS

D. Cách làm này là đúng vì đây cũng là cách bảo vệ sức khỏe cho chính những người này

[
]

Phân tích đúng cho mệnh đề: “Ở một số nước người ta đã áp dụng chương trình trao đổi bơm kim tiêm cho những người nghiện chích ma túy nhằm làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV. Các chương trình này thất bại vì tiêm chích ma túy là vấn đề cần sự can thiệp của công an chứ không phải của y tế công cộng.” là:

A. Điều này là đúng bởi vì chương trình đó làm tăng số người tiêm chích ma túy

B. Điều này là đúng bởi vì cách tốt nhất giải quyết vấn đề ma túy là bắt tất cả những người tiêm chích ma túy đi cai nghiện

C. Điều này là không đúng bởi vì kinh nghiệm các nước cho thấy ngành công an không thể giải quyết được tình trạng ma túy tràn lan

D. Điều này là không đúng vì cách tốt nhất là ngành công an và y tế hợp tác với nhau khi triển khai chương trình trao đổi bơm kim tiêm

[
]

Phân tích đúng cho mệnh đề: “Trong chương trình phòng chống HIV/AIDS một nhóm đối tượng quan trọng là thanh niên những người thường có hành vi tình dục không an toàn. Tuy nhiên đừng nên nói quá nhiều với họ về tình dục

vì nó chỉ khuyến khích thêm họ làm những điều mà họ đáng nhẽ không nên làm. Tốt nhất là nên khuyên họ đừng nên có quan hệ tình dục cho đến khi lập gia đình.” là:

A. Điều này là đúng vì không nên “vẽ đường cho hươu chạy”

B. Điều này là không đúng, bởi vì kết quả nghiên cứu cho thấy rằng thanh niên sau khi được cung cấp thông tin về tình dục an toàn sẽ lùi thời điểm bắt đầu quan hệ tình dục và nếu có quan hệ tình dục thì có khả năng tự bảo vệ mình

C. Điều này là đúng, bởi vì giáo dục về tình dục an toàn với người lớn khi đã có quan hệ tình dục rồi thì hiệu quả hơn. Tốt hơn là nên đợi cho đến khi đó.

D. Điều này là không đúng vì có nói hay không thì thanh thiếu niên vẫn cứ quan hệ tình dục sớm

[
]

Phân tích đúng cho mệnh đề: “Chúng ta đều rõ rằng HIV có trong sữa mẹ. Tốt nhất là mẹ nhiễm HIV không nên cho con bú” là:

A. Điều này là đúng và không có gì phải băn khoăn nữa vì các bà mẹ sẽ biết cách lo cho con mình

B. Điều này là đúng, nhưng thách thức là phải hướng dẫn bà mẹ cách chuẩn bị sữa bình hợp vệ sinh và hỗ trợ họ sữa hộp để nuôi con

C. Điều này là không đúng bởi vì nguy cơ lây nhiễm qua sữa mẹ rất thấp

D. Điều này là không đúng bởi vì nguy cơ lây truyền từ mẹ - con chủ yếu ở giai đoạn sinh nở khi đứa trẻ đi qua ống đẻ

[
]

Tiêm chích ma túy không phải là vấn đề của khu vực địa lý:

A. Trung Quốc và Đông Nam Á

B. Thái Bình Dương

C. Nam Mỹ

D. Hoa Kỳ

[
]

“Giảm tác hại” là tiếp cận đề cập đến:

A. Cắt cơn giải độc và phục hồi chức năng ở người sử dụng ma túy

B. Giảm nguy cơ lây nhiễm của HIV, HCV, HBV bằng các hình thức khác nhau

C. Giảm hành vi nguy cơ lây nhiễm qua đường tình dục trong nhóm có tiêm chích ma túy

D. Hướng dẫn tiêm chích an toàn

[
]

Mục tiêu chính của chương trình trao đổi bơm kim tiêm là:

A. Giảm lưu lượng bơm kim tiêm không sạch trong mạng lưới người tiêm chích ma túy

B. Thuyết phục những người tiêm chích không tiêm chích chung bơm kim tiêm

- C. Giảm nguy cơ lây nhiễm HIV cho người tiêm chích ma túy
- D. Tất cả đáp án trên

[
]

Tiêm chích ma túy không phải là vấn đề của nước:

- A. Thái lan
- B. Myanma
- C. Việt Nam
- D. Lào

[
]

Nhóm đối tượng có số ca mắc HIV tăng nhanh nhất trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX ở Việt Nam là:

- A. Người tiêm chích ma túy
- B. Những người tình dục dị giới có hành vi nguy cơ cao
- C. Nam quan hệ tình dục đồng giới
- D. Phụ nữ mang thai

[
]

Hoạt động có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất là quan hệ tình dục qua đường:

- A. Âm đạo ở tư thế nhận
- B. Hậu môn ở tư thế nhận
- C. Hậu môn ở tư thế cho
- D. Âm đạo ở tư thế cho

[
]

Việc gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm làm chỉ báo dịch HIV lan rộng là:

- A. Phụ nữ mang thai
- B. Gái mại dâm
- C. Người tiêm chích
- D. Người hiến máu

[
]

Một “dịch HIV/AIDS ở giai đoạn tập trung” được định nghĩa là:

- A. Sự tập trung lây nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ mang thai
- B. Sự tập trung lây nhiễm HIV trong nhóm có hành vi nguy cơ
- C. Sự tập trung của các ca bệnh AIDS ở trẻ em
- D. Sự tập trung của các ca bệnh HIV/AIDS trong một khu vực địa lý nhất định

[
]

“PrEP” (dự phòng tiền phơi nhiễm) đề cập đến:

- A. Cách thức hòa tan Heroin trước khi tiêm chích
- B. Uống thuốc kháng vi-rút trước khi tham gia hành vi nguy cơ cao
- C. Uống thuốc kháng vi-rút ngay sau khi tham gia hành vi nguy cơ cao
- D. Hút dung dịch heroin vào ống tiêm trước khi tiêm chích

[
]

“Tiếp cận điều trị để dự phòng” là:

- A. Điều trị thuốc kháng virus ở nhóm HIV dương tính để giảm nguy cơ lây

nhiễm sang cộng đồng nguy cơ cao có cùng hành vi

B. Điều trị thuốc kháng virus ở nhóm HIV dương tính để giảm nguy cơ bội nhiễm chéo HIV

C. Điều trị nhiễm trùng cơ hội ở nhóm bệnh nhân AIDS để dự phòng bệnh tiến triển

D. Điều trị nhiễm trùng cơ hội ở nhóm bệnh nhân AIDS để dự phòng cho các bệnh nhân HIV dương tính

[
]

Rào cản trong việc huy động nhóm nguy cơ cao đi xét nghiệm HIV là:

A. Họ không quan tâm đến sức khỏe của mình

B. Họ tin rằng nhiễm HIV có nghĩa là chết nên không muốn biết tình trạng của mình

C. Họ e ngại sự kỳ thị của cán bộ y tế và của xã hội

D. Tất cả các vấn đề trên

[
]

Chiến lược có tính chi phí-hiệu thấp trong kiểm soát sự lây truyền HIV là tập trung vào:

A. Người nhiễm HIV

B. Người có nguy cơ cao

C. Người có yếu tố nguy cơ

D. Những người có nguy cơ thấp

[
]

Các yếu tố cấu trúc có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống HIV là:

A. Chính sách, pháp luật, và tính sẵn có của BCS

B. Hành vi, phong tục tập quán

C. Số lượng gái mại dâm

D. Số lượng người tiêm chích ma túy

[
]

Cần thiệp hành vi cần phải có:

A. Xác định các hành động cụ thể cần được triển khai

B. Giải quyết các rào cản về cấu trúc

C. Xây dựng kỹ năng tự kiểm soát về cảm xúc, hành vi và nhận thức

D. Tất cả các yếu tố trên

[
]

Tỷ lệ lây nhiễm của một bệnh lây truyền qua đường tình dục có liên quan đến:

A. Tính hiệu quả lây truyền của tác nhân gây bệnh

B. Tỷ lệ trung bình thay đổi bạn tình

C. Thời gian lây nhiễm

D. Tất cả các đáp án trên

[
]

Bước đầu tiên trong việc giảm lây truyền HIV và các yếu tố khác qua đường máu ở các nước hạn chế nguồn lực là:

A. Giảm sự việc sử dụng máu toàn phần không thực sự cần thiết

- B. Sàng lọc người cho máu
 - C. Sàng lọc máu được hiến
 - D. Chỉ chấp nhận máu từ đối tượng nữ giới trước tuổi vị thành niên
- [
]

Đặc điểm của mô hình bạn tình làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng là:

- A. Có nhiều bạn tình trong cùng khoảng thời gian
 - B. Quan hệ 1 vợ 1 chồng
 - C. Có nhiều bạn tình nhưng với mỗi người trong từng khoảng thời gian
 - D. Quan hệ tình dục với cả 2 giới
- [
]

Yếu tố quyết định khả năng lây truyền HIV từ người nhiễm HIV là:

- A. Giới tính của người nhiễm
 - B. Người nhiễm đã chuyển sang giai đoạn AIDS hay chưa
 - C. Tải lượng Vi-rút/đơn vị máu của người nhiễm
 - D. Số lượng CD4/đơn vị máu của người nhiễm
- [
]

Sự tái tạo của virus HIV diễn ra chủ yếu ở:

- A. Mạch máu ngoại vi
 - B. Mô bạch huyết
 - C. Thymus
 - D. Tuyến tụy
- [
]

Đa số các trường hợp lây truyền HIV mẹ - con trong trường hợp không điều trị xảy ra ở giai đoạn:

- A. Bào thai trong tử cung
 - B. Trong quá trình chuyển dạ và đẻ
 - C. Trong giai đoạn cho con bú
 - D. Nguy cơ là như nhau ở các giai đoạn trên
- [
]

Ở các nước có nguồn lực hạn chế, phác đồ điều trị hiệu quả nhất cho bà mẹ trước khi sinh để dự phòng lây truyền mẹ con là:

- A. Nevirapine
 - B. AZT
 - C. Nevirapine + AZT
 - D. Tetracycline
- [
]

Ở các nước nguồn lực khó khăn, chiến lược tốt nhất để phòng tránh lây truyền HIV lây truyền từ mẹ sang con trong 6-8 tháng đầu là:

- A. Chỉ cho con bú, trong 6 tháng đầu
 - B. Cho bú mẹ và sau đó cho ăn bổ sung từ tháng thứ 3
 - C. Cho bú 3 tháng đầu và sau đó chuyển sang uống sữa bột
 - D. Tránh cho con bú sữa mẹ hoàn toàn
- [
]

Nguy cơ chính lây truyền HIV cho nhóm phụ nữ nguy cơ thấp là:

- A. Tiêm chích ma túy
- B. Quan hệ tình dục với nhiều bạn tình
- C. Truyền máu
- D. Từ chồng/bạn tình

[
]

Chiến lược có hiệu quả trong việc xác định một cá nhân nhiễm HIV để kết nối điều trị là:

- A. Tư vấn xét nghiệm HIV
- B. Giám sát quần thể chung
- C. Giám sát trọng điểm
- D. Xét nghiệm tất cả bệnh nhân nhập viện

[
]

“Giai đoạn cửa sổ” đề cập đến:

- A. Khoảng thời gian cuối trong nhiễm HIV, giai đoạn cho xét nghiệm HIV có thể âm tính, nhưng sự lây truyền vẫn có thể xảy ra
- B. Khoảng thời gian đầu trong lây nhiễm HIV, giai đoạn cho xét nghiệm HIV có thể âm tính, sự lây truyền không xảy ra
- C. Khoảng thời gian đầu trong lây nhiễm HIV, giai đoạn cho xét nghiệm HIV có thể âm tính, nhưng sự lây truyền vẫn có thể xảy ra
- D. Khoảng thời gian đầu trong lây nhiễm HIV, giai đoạn cho xét nghiệm HIV có thể dương tính, nhưng sự lây truyền không thể xảy ra

[
]

Giám sát huyết thanh kết hợp hành vi để xác định:

- A. Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng
- B. Mức độ nguy cơ của một cộng đồng đối với dịch HIV
- C. Dự đoán những xu hướng tương lai sự phát triển của dịch
- D. Cả B và C

[
]

Yếu tố dự báo tốt nhất cho sự tiến triển bệnh của nhiễm HIV là:

- A. Mức độ ARN của virus trong máu
- B. Mức độ TB CD8
- C. Mức độ TB CD4
- D. Mức độ kháng thể kháng HIV

[
]

Yếu tố quan trọng nhất để dự phòng sự lây truyền HIV ở một đất nước đang phát triển là:

- A. Tỷ lệ nam giới độc thân
- B. Tỷ lệ nữ giới độc thân
- C. Các cam kết chính trị của các nhà lãnh đạo
- D. Trình độ học vấn của người dân

[
]

Từ khi dịch HIV được báo cáo ở VN đến nay, kinh phí đầu tư của nhà nước cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS là:

- A. Luôn giữ ở mức cao
- B. Luôn giữ ở mức thấp
- C. Luôn cao hơn đầu tư quốc tế
- D. Tăng dần qua các năm, đặc biệt là trong những năm gần đây

[
]

Phụ nữ có nguy cơ lây nhiễm HIV cao từ người chồng do:

- A. Không có hiểu biết về nguy cơ lây nhiễm HIV từ chồng của họ
- B. Tin tưởng vào sự an toàn trong quan hệ tình dục với chồng
- C. Không có khả năng thương thuyết về sử dụng bao cao su ngay cả khi không tin tưởng vào người chồng
- D. Cả ba lý do trên

[
]

Loại ma túy có liên quan trực tiếp và phổ biến đến lây nhiễm HIV ở Việt Nam là:

- A. Heroin
- B. Thuốc lắc
- C. Ma túy đá
- D. Cocaine

[
]

Hoạt động KHÔNG phải là hoạt động giảm hại cho nhóm tiêm chích ma túy ở Việt Nam là:

- A. Điều trị thay thế bằng Methadone
- B. Trao đổi bơm kim tiêm sạch
- C. Phân phát bao cao su miễn phí
- D. Điều trị cai nghiện tại các trung tâm

[
]

Hoạt động KHÔNG phải là hoạt động giảm hại cho nhóm phụ nữ bán dâm ở Việt Nam là:

- A. Trao đổi bơm kim tiêm sạch
- B. Phân phát bao cao su miễn phí
- C. Vận động các chủ cơ sở thực hiện chương trình “100% bao cao su”
- D. Triển khai các hoạt động phòng chống bạo lực tình dục do khách hàng gây ra

[
]

Đối với các nhóm nguy cơ cao, nâng cao kiến thức về đường lây truyền HIV là biện pháp phòng chống:

- A. Cần nhưng không đủ
- B. Đủ nhưng không cần
- C. Vừa đủ vừa cần
- D. Có cũng tốt mà không có cũng không sao

[
]

Năm 2014, Việt Nam cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 do Liên Hợp Quốc phát động, mục tiêu đó muốn nói đến:

- A. 90% người nhiễm biết tình trạng của mình; 90% người chẩn đoán HIV được điều trị; 90% người được điều trị có tình trạng CD4 cải thiện
- B. 90% người nhiễm biết tình trạng của mình; 90% người chẩn đoán HIV được dự phòng lây nhiễm sang bạn tình; 90% người được điều trị có tình trạng CD4 cải thiện
- C. 90% người nhiễm biết tình trạng của mình; 90% người chẩn đoán HIV được điều trị; 90% người được điều trị có tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện được
- D. 90% người nhiễm biết tình trạng của mình; 90% người chẩn đoán HIV được điều trị; 90% người được điều trị không có nhiễm trùng cơ hội

[
]

[<g>] SỐ ĐO MẮC BỆNH TỬ VONG [</g>]

Để có được số mới mắc phải tiến hành:

- A. Nghiên cứu thử nghiệm trên cộng đồng
- B. Nghiên cứu thực nghiệm ngẫu nhiên
- C. Nghiên cứu thuần tập
- D. Điều tra ngang

[
]

Để có được số hiện mắc cần phải tiến hành:

- A. Nghiên cứu bệnh chứng
- B. Nghiên cứu can thiệp
- C. Điều tra ngang
- D. Điều tra dọc

[
]

Tỉ suất mới mắc bằng:

- A. Số mới mắc/tổng số quần thể giữa thời kỳ nghiên cứu
- B. Số mới mắc/tổng số quần thể có nguy cơ giữa thời kỳ nghiên cứu

- C. Số mới mắc/tổng số quần không nhiễm bệnh giữa thời kỳ nghiên cứu
D. Số mới mắc/tổng số bệnh nhân giữa thời kỳ nghiên cứu

[
]

Tỉ suất hiện mắc bằng:

- A. Số hiện mắc/tổng số quần thể
B. Số hiện mắc/tổng số quần thể có nguy cơ
C. Số mới mắc/tổng số quần thể
D. Số mới mắc/tổng số quần thể có nguy cơ

[
]

Tỉ suất hiện mắc tăng khi:

- A. Tăng số mới mắc
B. Giảm số mới mắc
C. Nhập cư người khỏe
D. Giảm số mới mắc

[
]

Tỷ suất hiện mắc tăng khi:

- A. Tỷ lệ tử vong cao
B. Kéo dài sự sống của người bệnh
C. Giảm số mới mắc
D. Rút ngắn thời gian bị bệnh

[
]

Tỷ suất hiện mắc tăng khi:

- A. Tỷ lệ tử vong cao
B. Giảm số mới mắc
C. Sự nhập cư của người khỏe
D. Sự nhập cư của người bệnh

[
]

Tỷ suất hiện mắc tăng khi:

- A. Rút ngắn thời gian bị bệnh
B. Sự tiến bộ của các phương tiện chẩn đoán
C. Tỷ lệ tử vong cao
D. Giảm số mới mắc

[
]

Tỷ suất hiện mắc giảm khi:

- A. Rút ngắn thời gian bị bệnh
B. Kéo dài thời gian bị bệnh
C. Tăng số mới mắc
D. Sự tiến bộ của các phương tiện chẩn đoán

[
]

Tỷ suất hiện mắc giảm khi:

- A. Kéo dài thời gian bị bệnh
B. Giảm số mới mắc
C. Sự tiến bộ của các phương tiện chẩn đoán
D. Kéo dài sự sống

[
]

Tỷ suất hiện mắc giảm khi:

- A. Sự ra đi của người khỏe
- B. Sự nhập cư của người bệnh
- C. Tăng số điều trị khỏi
- D. Sự tiến bộ của các phương tiện chẩn đoán

[
]

Tỷ suất hiện mắc giảm khi:

- A. Tỷ lệ tử vong cao
- B. Sự nhập cư của người bệnh
- C. Sự ra đi của người khỏe
- D. Sự tiến bộ của các phương tiện chẩn đoán

[
]

Tỷ suất hiện mắc tăng khi:

- A. Tỷ suất tử vong cao
- B. Nhập cư người khỏe
- C. Di cư người ốm
- D. Kéo dài thời gian bị bệnh

[
]

Mẫu số để đo lường tỷ suất mật độ mới mắc một bệnh xảy ra là:

- A. Số những trường hợp bệnh quan sát được.
- B. Số những trường hợp không có triệu chứng.
- C. Số năm người quan sát được.
- D. Số người mất trong theo dõi.

[
]

Case study - Ở một cuộc điều tra cơ bản, 17 người trong số 1000 người đã có dấu hiệu của bệnh mạch vành tim.

Chỉ số đo lường bệnh xảy ra là:

- A. Tỷ suất hiện mắc
- B. Tỷ suất mới mắc
- C. Tỷ suất mới mắc tích lũy
- D. Tỷ suất mật độ mới mắc.

[
]

Case study - Một nghiên cứu thuần tập trong thời gian 12 năm nhằm đánh giá nguy cơ của hút thuốc lá đối với bệnh tim mạch người ta thấy tỷ lệ xảy ra cơn đau thắt ngực ở những người nghiện thuốc lá cao gấp 1,6 lần so với những người không nghiện thuốc lá.

Chỉ số dùng để đo lường tỷ suất mắc bệnh xảy ra là:

- A. Tỷ suất hiện mắc
- B. Tỷ suất mắc bệnh được chuẩn hoá
- C. Tỷ lệ chết xác định theo tuổi
- D. Tỷ suất mới mắc

[
]

Case study - Trong một nghiên cứu về bệnh tăng huyết áp người ta phát hiện được 45 người mắc bệnh tăng huyết áp trong số 1000 người ở nhóm tuổi 15-49 được lấy vào nghiên cứu.

Chỉ số dùng để đo lường bệnh xảy ra là:

- A. Tỉ suất hiện mắc
- B. Tỉ suất mới mắc
- C. Tỉ lệ mắc bệnh được chuẩn hoá
- D. Tỉ suất mới mắc xác định theo tuổi

[
]

Case study - Ở một nghiên cứu cơ bản, 131 người trong số 1000 người ở lứa tuổi 60 - 64 đã mắc bệnh mạch vành tim.

Chỉ số dùng để đo lường bệnh xảy ra là:

- A. Tỉ suất hiện mắc
- B. Tỉ suất mới mắc
- C. Tỉ lệ mắc bệnh được chuẩn hoá
- D. Tỉ suất hiện mắc xác định theo tuổi

[
]

Một thay đổi trong tỉ suất hiện mắc là hậu quả thay đổi của:

- A. Tỉ suất mới mắc
- B. Nguy cơ tương đối
- C. Nguy cơ quy thuộc
- D. Cả 3 ý trên

[
]

Khi một loại thuốc hay một phương pháp điều trị có khả năng làm giảm tỷ lệ chết nhưng không làm khỏi hẳn bệnh, sẽ dẫn đến tình huống là tỷ suất:

- A. Hiện mắc của bệnh sẽ giảm
- B. Hiện mắc của bệnh sẽ tăng
- C. Mới mắc của bệnh sẽ giảm
- D. Mới mắc của bệnh sẽ tăng

[
]

Case study - Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. Trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam.

Tỉ suất chết thô ở cộng đồng A là:

- A. 300/100.000
- B. 60/1.000
- C. 10/1.000
- D. 100/1.000

[
]

Case study - Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. Trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam.

Tỉ suất chết do lao là:

- A. 20%
- B. 30%
- C. 6%
- D. 35%

[
]

Case study - Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam.

Tỉ suất chết trên mắc của lao là:

- A. 6%
- B. 20%
- C. 2%
- D. Như nhau ở nam và nữ

[
]

Case study - Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. Trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam.

Tỉ suất chết riêng phần theo nguyên nhân đối với lao là:

- A. 60/100.000
- B. 300/100.000
- C. 200/1.000
- D. 20%

[
]

Case study - Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. Trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam.

Tỉ suất chết riêng phần theo giới đối với lao là:

- A. 0,5/1.000
- B. Nam lớn hơn nữ
- C. 50/300
- D. Không thể tính được từ số liệu đã cho

[
]

Case study - Trong một cộng đồng bao gồm 100.000 người, có 1000 trường hợp mắc 1 bệnh, trong đó 200 trường hợp chết vì bệnh đó trong 1 năm.

(<1>) Tỷ lệ chết vì bệnh này là:

- A. 0,2%
- B. 2%
- C. 10%
- D. 20%

[
]

Case study - Tại một quần thể trong năm 2004 người ta đã thống kê được có 1886 trường hợp chết trong năm đó.

(<1>) Để tính được tỉ suất tử vong thô, người ta cần phải thu thập thêm các thông tin là:

- A. Tổng số người mắc bệnh trong quần thể đó trong năm 2004
- B. Tổng dân số trong quần thể đó tại thời điểm giữa năm 2004
- C. Tổng dân số của quần thể tại thời điểm cuối năm năm 2004
- D. Tổng dân số của quần thể tại thời điểm giữa năm và cuối năm đó chia đôi

[
]

Tỷ lệ chết/mắc của một bệnh là:

- A. Tỷ lệ chết thô/100.000 dân
 - B. Tỷ lệ chết theo nguyên nhân do bệnh đó.
 - C. Tỷ lệ phần trăm chết ở các bệnh nhân.
 - D. Tỷ lệ chết do bệnh đó trong tất cả những người chết vì tất cả nguyên nhân
- [
]

Tỷ lệ chết ở trẻ sơ sinh bằng số chết:

- A. Dưới 24 giờ tuổi, trên 10.000 trẻ đẻ sống
- B. Dưới 7 ngày tuổi, trên 10.000 cuộc đẻ
- C. Dưới 7 ngày tuổi, trên 10.000 trẻ đẻ ra sống
- D. Dưới 28 ngày tuổi, trên 10.000 cuộc đẻ

[
]

Case study - Trong một cộng đồng gồm 1.000.000 người, có 1.000 trường hợp mắc một bệnh cấp tính, trong đó có 300 trường hợp chết vì bệnh này trong năm.

Tỉ suất chết/mắc về bệnh này trong năm là:

- A. 3%
- B. 1%
- C. 10%
- D. 30%

[
]

Case study - Trong một cộng đồng có 100.000 người, có 1.000 trường hợp bệnh và 200 trường hợp chết vì bệnh đó trong năm.

Tỉ suất chết do bệnh này trong năm đó là:

- A. 200/1.000
- B. 200/100.000
- C. 800/1000
- D. 800/100.000

[
]

Tỷ suất mới mắc bệnh được định nghĩa là:

- A. Số ca hiện có của một bệnh trong một khoảng thời gian chia cho số dân lúc bắt đầu thời gian này
- B. Số ca hiện có của một bệnh trong một khoảng thời gian chia cho số dân ở thời điểm giữa thời gian này
- C. Số ca mới mắc của một bệnh trong một khoảng thời gian chia cho số dân có nguy cơ lúc bắt đầu nghiên cứu
- D. Số ca mới mắc của một bệnh trong một khoảng thời gian chia cho số dân ở thời điểm giữa thời gian này

[
]

Tỷ suất hiện mắc bệnh tại một thời điểm được định nghĩa là:

- A. Số ca hiện mắc trong một thời gian nhân với thời gian kéo dài trung bình của bệnh
- B. Số ca hiện mắc trong một thời gian chia cho số dân lúc bắt đầu thời gian này
- C. Số ca hiện mắc tại một thời điểm chia cho số dân ở thời điểm đó
- D. Số ca hiện có trong một thời gian chia cho số dân ở cuối thời gian này

[
]

Nguy cơ mắc bệnh có thể được đo lường bằng:

- A. Tỷ suất mới mắc.
- B. Tỷ suất mới mắc nhân với thời gian trung bình của bệnh
- C. Tỷ suất hiện mắc.
- D. Tỷ suất hiện mắc nhân với thời gian trung bình của bệnh

[
]

Tỷ suất hiện mắc của bệnh đái tháo đường cao hơn so với một năm trước khi bắt đầu tiến hành chương trình phát hiện và điều trị tích cực là do:

- A. Giảm tỷ suất mới mắc
- B. Giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường
- C. Giảm tỷ lệ chết so với số mắc bệnh đái tháo đường
- D. Tăng tỷ lệ chết của bệnh đái tháo đường

[
]

Tỷ suất hiện mắc tăng lên khi:

- A. Kéo dài thời gian bị bệnh
- B. Di cư người khỏe
- C. Tăng số mới mắc
- D. Cả 3 ý trên

[
]

Case study - Tỷ suất mới mắc ung thư trong 1 năm là 60/100000, thời gian trung bình của bệnh ung thư đó là 2 năm

Tỷ suất hiện mắc của bệnh ung thư đó là:

- A. 30/100000
- B. 60/100000
- C. 12/100000
- D. 120/100000

[
]

Với một bệnh có thời gian phát triển trung bình tương đối ổn định thì:

- A. $D = P/I$
- B. $P = I/D$
- C. $I = P/D$
- D. $D = P \times I$

[
]

Kết quả của một nghiên cứu ngang là:

- A. Số mới mắc, tỷ suất mới mắc
- B. Thời gian phát triển trung bình của bệnh
- C. Số mới mắc, tỷ suất hiện mắc
- D. Số hiện mắc, tỷ suất hiện mắc

[
]

Kết quả một nghiên cứu dọc là:

- A. Thời gian phát triển trung bình của bệnh
- B. Số mới mắc, tỷ suất mới mắc
- C. Số mới mắc, tỷ suất hiện mắc
- D. Số hiện mắc, tỷ suất mới mắc

[
]

Ví dụ về tỉ suất hiện mắc là:

- A. Số lần bị viêm họng ở trẻ em dưới 3 tuổi hàng năm
- B. Tổng số các trường hợp mới bị ung thư tuyến tiền liệt hàng năm trên 100.000 đàn ông
- C. Số bệnh nhân đái tháo đường ở một trường đại học
- D. Tổng số bệnh nhân bị tăng huyết áp trên 100.000 dân hàng năm.

[
]

Case study - Có 112 người bị ốm trong đó 76 nữ và 36 nam sau một cuộc dã ngoại trong tổng số 250 người (80 nam và 170 nữ).

(<1>) Tỉ suất được tính toán đúng là tỉ suất tấn công:

- A. Theo giới đối với nam $36/112 = 0,32$
- B. Theo giới đối với nam $80/250 = 0,30$
- C. Theo giới đối với nữ $76/112 = 0,70$
- D. Chung $112/250 = 0,45$

[
]

Case study - Một loại vacxin phòng bệnh cúm được thử nghiệm trên một nhóm người tình nguyện. Trong số 95 người được tiêm vacxin, có 3 trường hợp bị ốm, và trong số 95 người đã nhận placebo, có 16 trường hợp mắc bệnh cúm trong thời gian theo dõi.

Tính toán nguy cơ tương đối (RR) nhiễm bệnh cúm trong số những người nhận vắc xin và so với người nhận placebo là:

- A. 16/3
- B. 3/16
- C. 3/95
- D. 16/96

[
]

Case study - Thành phố A có 100.000 dân, trong năm 2000 đã ghi nhận được: 100 người chết do mọi nguyên nhân. 60 người bị sốt xuất huyết, trong đó có 3 người chết do bệnh này.

Tỷ suất chết chung của thành phố A năm 2000 là:

- A. 3/60
- B. 100/100.000
- C. 3/100.000
- D. 60/100

[
]

Case study - Thành phố A có 100.000 dân, trong năm 2000 đã ghi nhận được: 100 người chết do mọi nguyên nhân. 60 người bị sốt xuất huyết, trong đó có 3 người chết do bệnh này.

Tỷ suất chết của bệnh sốt xuất huyết là:

- A. 3/60
- B. 100/100.000
- C. 3/100.000
- D. 60/100

[
]

Case study - Trong một nghiên cứu theo dõi bệnh sốt rét tại huyện miền núi có sử dụng thuốc Artemisinin để điều trị cho bệnh nhân sốt rét. Qua theo dõi 1892 người thấy có 244 trường hợp mới mắc trong thời gian theo dõi 2 năm. Tỷ suất mới mắc tích lũy của sốt rét trong thời gian nghiên cứu là:

- A. 0.13
- B. 0.15
- C. 0.17
- D. 0.19

[
]

Tỷ suất chết/mắc được tính bằng:

- A. Số chết do mọi nguyên nhân/tổng số quần thể vào giữa năm đó
- B. Số người chết trong một độ tuổi nhất định/tổng số quần thể
- C. Số người chết do một nguyên nhân nhất định/tổng số quần thể giữa năm
- A. Số chết do bị một bệnh nhất định/tổng số người bị bệnh đó

[
]

Hiện nay HIV đã có thuốc điều trị, nếu thuốc được sử dụng rộng rãi sẽ:

- A. Làm giảm số hiện mắc
- B. Làm giảm số mới mắc
- C. Làm tăng số mới mắc
- D. Làm tăng số hiện mắc

[
]

Case study - Trong một nghiên cứu sàng lọc tiến hành trên 5000 phụ nữ, người ta đã tìm thấy có 25 người mắc bệnh ung thư vú. Năm năm sau đó, người ta đã phát hiện thêm 10 trường hợp bị bệnh.

Tỷ suất mới mắc ung thư vú sau 5 năm nghiên cứu là:

- A. $10/(5000-25)$
- B. $10/5000$
- C. $10/25$
- D. $10/(5000+25)$

[
]

Tỷ suất hiện mắc là một phân số, trong đó mẫu số là:

- A. Tổng số quần thể
- B. Tổng số quần thể có nguy cơ
- C. Tổng số quần thể ở một độ tuổi nhất định
- D. Tổng số quần thể tại thời điểm nghiên cứu

[
]

Case study - Một bệnh bắt buộc phải điều trị tại bệnh viện, hàng tháng có 100 trường hợp vào viện, số người thường xuyên được điều trị là 20.

Thời gian trung bình của bệnh là:

- A. 5 ngày
- B. 6 ngày
- C. 7 ngày
- C. 8 ngày

[
]

Mẫu số của tỷ suất chết chung là:

- A. Tổng số quần thể
- B. Tổng số quần thể có nguy cơ
- C. Tổng số quần thể ở một độ tuổi nhất định
- D. Tổng số người bị bệnh

[
]

[<g>]SÀNG TUYỂN [</g>]

Dùng một thử nghiệm định tính để phát hiện một bệnh trong quần thể, khi đối chiếu với kết quả thực tế cho kết quả

Test NC	Có bệnh	Không bệnh	Tổng
(+)	a	b	a + b
(-)	c	d	c + d
Tổng	a + c	b + d	a+b+c+d

Độ nhạy của test được tính bằng:

- A. $a/(a+b)$
- B. $b/(a+b)$
- C. $a/(a+c)$
- D. $c/(a+c)$

[
]

Dùng một thử nghiệm định tính để phát hiện một bệnh trong quần thể, khi đối chiếu với kết quả thực tế cho kết quả

Test NC	Có bệnh	Không bệnh	Tổng
(+)	a	b	a + b
(-)	c	d	c + d
Tổng	a + c	b + d	a+b+c+d

Độ đặc hiệu của test được tính bằng:

- A. $a/(a+b)$
- B. $b/(a+b)$
- C. $b/(b+d)$
- D. $d/(b+d)$

[
]

Dùng một thử nghiệm định tính để phát hiện một bệnh trong quần thể, khi đối chiếu với kết quả thực tế cho kết quả

Test NC	Có bệnh	Không bệnh	Tổng
(+)	a	b	a + b
(-)	c	d	c + d
Tổng	a + c	b + d	a+b+c+d

Giá trị dự đoán dương tính là:

- A. $a/(a+b)$
- B. $b/(a+b)$
- C. $a/(a+c)$
- D. $c/(a+c)$

[
]

Dùng một thử nghiệm định tính để phát hiện một bệnh trong quần thể, khi đối chiếu với kết quả thực tế cho kết quả

Test NC	Có bệnh	Không bệnh	Tổng
(+)	a	b	a + b
(-)	c	d	c + d
Tổng	a + c	b + d	a+b+c+d

Giá trị dự đoán âm tính là:

A. $a/(a+b)$

B. $b/(a+b)$

C. $c/(c+d)$

D. $d/(c+d)$

[
]

Độ nhạy của một test là:

A. Khả năng phát hiện những trường hợp không bị bệnh của test đó

B. Khả năng phát hiện những trường hợp bị bệnh của test đó

C. Xác suất bị bệnh của một người có kết quả test (+)

D. Xác suất không bị bệnh của một người có kết quả test (-)

[
]

Độ đặc hiệu của một test là:

A. Khả năng phát hiện những trường hợp không bị bệnh của test đó

B. Khả năng phát hiện những trường hợp bị bệnh của test đó

C. Xác suất bị bệnh của một người có kết quả test (+)

D. Xác suất không bị bệnh của một người có kết quả test (-)

[
]

Giá trị dự đoán dương tính của một test là:

A. Khả năng phát hiện những trường hợp không bị bệnh của test đó

B. Khả năng phát hiện những trường hợp bị bệnh của test đó

C. Xác suất bị bệnh của một người có kết quả test (+)

D. Xác suất không bị bệnh của một người có kết quả test (-)

[
]

Giá trị dự đoán âm tính của một test là:

A. Khả năng phát hiện những trường hợp không bị bệnh của test đó

B. Khả năng phát hiện những trường hợp bị bệnh của test đó

C. Xác suất bị bệnh của một người có kết quả test (+)

D. Xác suất không bị bệnh của một người có kết quả test (-)

[
]

Sàng tuyển phát hiện bệnh sớm là:

A. Dự phòng cấp 1

B. Dự phòng cấp 2

C. Dự phòng cấp 3

D. Dự phòng cấp 0

[
]

Kỹ thuật sàng tuyển được sử dụng để phát hiện bệnh ở giai đoạn:

A. Cảm thụ

- B. Tiền lâm sàng
 - C. Lâm sàng
 - D. Khỏi hoặc tàn tật hoặc tử vong
- [
]

Mục đích của sàng tuyển là:

- A. Phát hiện bệnh sớm
 - B. Giảm tàn phế
 - C. Chẩn đoán xác định
 - D. Chăm sóc giảm nhẹ
- [
]

Đối tượng thường được lựa chọn cho chương trình xét nghiệm sàng tuyển là:

- A. Những người khỏe mạnh bình thường
 - B. Những người đã được chẩn đoán bệnh
 - C. Những người có nguy cơ cao
 - D. Bao gồm những người khỏe mạnh và những người có nguy cơ cao
- [
]

Case study - Người ta đo huyết áp tâm trương để phát hiện cao huyết áp, khi huyết áp của người được đo $\geq$ ngưỡng thì coi là cao huyết áp.

Để tăng độ nhạy của test thì phải dùng ngưỡng :

- A. 90mmHg
 - B. 100mmHg
 - C. 120mmHg
 - D. 110mmHg
- [
]

Case study - Người ta đo huyết áp tâm trương để phát hiện cao huyết áp, khi huyết áp của người được đo $\geq$ ngưỡng thì coi là cao huyết áp.

Để tăng độ đặc hiệu của test thì phải dùng :

- A. 90mmHg
 - B. 100mmHg
 - C. 120mmHg
 - D. 110mmHg
- [
]

Test có độ nhạy cao nhưng kém đặc hiệu sẽ đem lại:

- A. Nhiều kết quả (+) giả
 - B. Nhiều kết quả (-) giả
 - C. Ít kết quả (+) giả
 - D. Ít kết quả (-) giả
- [
]

Test có độ đặc hiệu cao nhưng kém nhạy sẽ đem lại:

- A. Nhiều kết quả (+) giả
 - B. Nhiều kết quả (-) giả
 - C. Ít kết quả (+) giả
 - D. Ít kết quả (-) giả
- [
]

Để tiến hành sàng lọc phát hiện bệnh người ta thường dùng test:

- A. Có độ đặc hiệu cao
- B. Có độ đặc hiệu thấp
- C. Có giá trị dự đoán (-) cao
- D. Có độ nhạy cao

[
]

Để tiến hành chẩn đoán bệnh người ta thường dùng test:

- A. Có độ đặc hiệu cao
- B. Có độ đặc hiệu thấp
- C. Có giá trị dự đoán (+) cao
- D. Có độ nhạy cao

[
]

Các giá trị dự đoán dương tính hoặc âm tính của một test phụ thuộc vào độ nhạy, độ đặc hiệu của test và:

- A. Tỷ suất mới mắc bệnh trong quần thể
- B. Thời gian phát triển trung bình của bệnh
- C. Tỷ suất hiện mắc bệnh trong quần thể
- D. Sự lặp lại của test

[
]

Dùng một test có độ nhạy là 100%, độ đặc hiệu 100% để phát hiện bệnh trong cộng đồng thì sẽ:

- A. Tỷ lệ âm tính giả và dương tính giả tùy thuộc vào tỷ suất hiện mắc bệnh đó
- B. Tỷ lệ âm tính giả và dương tính giả tùy thuộc vào tỷ suất mới mắc bệnh đó
- C. Không có dương tính giả và âm tính giả
- D. Tỷ lệ âm tính giả và dương tính giả tùy thuộc và thời gian mắc bệnh đó

[
]

Dùng một test có độ nhạy gần 100% để phát hiện bệnh trong cộng đồng thì:

- A. Bỏ sót nhiều người bị bệnh
- B. Bỏ sót ít người bị bệnh
- C. Sự bỏ sót còn tùy thuộc vào thời gian bị bệnh
- D. Sự bỏ sót còn tùy thuộc và tỷ suất mới mắc bệnh

[
]

Case study - Khi tỷ suất hiện mắc bệnh trong quần thể là 0,1, xác suất của kết quả dương tính giả là 0,08

Xác suất bị bệnh khi test (+) là:

- A. 0,67
- B. 0,79
- C. 0,53
- D. 0,58

[
]

Dùng một test hoặc kỹ thuật nào đó để chia quần thể thành 2 phần; nghi ngờ bị bệnh và không bị bệnh thì hoạt động này là:

- A. Dự phòng cấp I
- B. Phát hiện bệnh cho cộng đồng
- C. Can thiệp cộng đồng
- D. Phòng bệnh cho cộng đồng

[
]

Dùng một test có mức chính xác kém và ít tốn kém, test đó thuộc:

- A. Test chẩn đoán bệnh
- B. Test phát hiện bệnh
- C. Test có độ đặc hiệu cao
- D. Test có giá trị dự đoán kết quả dương tính cao

[
]

Đối với ung thư cổ tử cung, làm sinh thiết vùng tổn thương là test:

- A. Test chẩn đoán bệnh
- B. Test phát hiện bệnh
- C. Test có độ nhạy thấp
- D. Test có giá trị dự đoán âm tính cao

[
]

Khi lựa chọn chương trình sàng tuyển, những tiêu chuẩn cần phải dựa vào bao gồm các yếu tố sau, TRỪ:

- A. Bệnh
- B. Test
- C. Môi trường
- D. Quần thể đích

[
]

Để phát hiện và chẩn đoán bệnh ung thư cổ tử cung người ta phải sử dụng 2 test: a - làm phiên đồ âm đạo, tiến hành trước. b - sinh thiết vùng tổn thương, thực hiện sau. Điều này có nghĩa là:

- A. Độ nhạy của test b cao hơn độ nhạy của test a
- B. Độ đặc hiệu của test b cao hơn độ đặc hiệu của test a
- C. Độ đặc hiệu của 2 test là như nhau
- D. Độ nhạy của 2 test là như nhau

[
]

Case study - Để phát hiện và chẩn đoán bệnh ung thư cổ tử cung người ta phải sử dụng 2 test: a - làm phiên đồ âm đạo, tiến hành trước. b - sinh thiết vùng tổn thương, thực hiện sau

Điều này có nghĩa là:

- A. Độ nhạy của test a cao hơn độ nhạy của test b
- B. Độ đặc hiệu của test a cao hơn độ đặc hiệu của test b
- C. Độ đặc hiệu của 2 test là như nhau
- D. Độ nhạy của 2 test là như nhau

[
]

Đối với ung thư đại tràng, tìm máu trong phân là test:

- A. Phát hiện bệnh
- B. Chẩn đoán bệnh
- C. Có độ nhạy thấp
- D. Có giá trị tiên đoán kết quả âm tính thấp

[
]

Đối với ung thư đại tràng, làm sinh thiết vùng nghi ngờ là test:

- A. Phát hiện bệnh

- B. Chẩn đoán bệnh
- C. Có độ nhạy thấp
- D. Có giá trị tiên đoán kết quả âm tính thấp

[
]

Kết quả của một test là cơ sở của điều trị, test đó thuộc test:

- A. Chẩn đoán bệnh
- B. Có độ nhạy cao
- C. Có độ đặc hiệu cao
- D. Có giá trị dự đoán kết quả dương tính cao

[
]

Kết quả của một test chưa phải là cơ sở của điều trị, test đó thuộc test:

- A. Test chẩn đoán bệnh
- B. Test có độ nhạy cao
- C. Test có độ đặc hiệu cao
- D. Test có giá trị dự đoán kết quả dương tính cao

[
]

Áp dụng một test cho một người có sự rối loạn nhất định, test đó thuộc

- A. Chẩn đoán bệnh
- B. Có độ nhạy cao
- C. Có độ đặc hiệu cao
- D. Có giá trị dự đoán kết quả dương tính cao

[
]

Áp dụng một test cho một người có vẻ ngoài khỏe mạnh, test đó thuộc test:

- A. Chẩn đoán bệnh
- B. Có độ nhạy cao
- C. Có độ đặc hiệu cao
- D. Có giá trị dự đoán kết quả dương tính cao

[
]

Một test được thực hiện trên từng cá thể, test đó thuộc test:

- A. Chẩn đoán bệnh
- B. Có độ nhạy cao
- C. Có độ đặc hiệu cao
- D. Có giá trị dự đoán kết quả dương tính cao

[
]

Một test được thực hiện trên từng nhóm người, test đó thuộc test:

- A. Chẩn đoán bệnh
- B. Có độ nhạy cao
- C. Có độ đặc hiệu cao
- D. Có giá trị dự đoán kết quả dương tính cao

[
]

Một test có mức chính xác kém và ít tốn kém (rẻ hơn), test đó thuộc test:

- A. Chẩn đoán bệnh
- B. Có độ nhạy cao
- C. Có độ đặc hiệu cao
- D. Có giá trị dự đoán kết quả dương tính cao

[
]

Một test có mức chính xác cao và thường tốn kém hơn (đắt hơn), test đó thuộc test:

- A. Chẩn đoán bệnh
- B. Có độ nhạy cao
- C. Có độ đặc hiệu cao
- D. Có giá trị dự đoán kết quả dương tính cao

[
]

[<g>] CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG [</g>]

Chương trình tiêm chủng mở rộng bắt đầu triển khai ở Việt Nam từ năm:

- A. 1980
- B. 1981
- C. 1982
- D. 1983

[
]

Đối tượng chủ yếu của chương trình tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam là:

- A. Trẻ em, phụ nữ
- B. Trẻ em dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai
- C. Trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai
- D. Trẻ em dưới 10 tuổi, phụ nữ có thai

[
]

Chương trình tiêm chủng mở rộng cung cấp dịch vụ tiêm chủng:

- A. Miễn phí cho đối tượng của chương trình
- B. Đối tượng của chương trình phải trả 1 phần kinh phí
- C. Đối tượng của chương trình phải trả toàn bộ kinh phí
- D. Có loại vắc xin đối tượng phải trả tiền, có loại không

[
]

Đến năm 2014, số loại vắc xin được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng là:

- A. 9 loại
- B. 10 loại
- C. 11 loại
- D. 12 loại

[
]

Lịch sử phát triển chương trình tiêm chủng mở rộng được chia thành:

- A. 3 giai đoạn
- B. 4 giai đoạn
- C. 5 giai đoạn
- D. 6 giai đoạn

[
]

Trong giai đoạn thí điểm chương trình tiêm chủng mở rộng đã triển khai ở:

- A. 30% tỉnh/thành phố
- B. 50% tỉnh/thành phố

- C. 70% tỉnh/thành phố
- D. 90% tỉnh/thành phố

[
]

Trong giai đoạn mở rộng chương trình tiêm chủng mở rộng đã triển khai ở:

- A. 70% tỉnh/thành phố
- B. 80% tỉnh/thành phố
- C. 90% tỉnh/thành phố
- D. 100% tỉnh/thành phố

[
]

Số hình thức tiêm chủng được áp dụng ở Việt Nam là:

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

[
]

Mục tiêu chung của chương trình tiêm chủng mở rộng là:

- A. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao cho trẻ em và phụ nữ, giảm tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em
- B. Duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt và loại trừ uốn ván sơ sinh
- C. Không ngừng nâng cao chất lượng tiêm chủng
- D. Cả 3 ý trên

[
]

7 loại vắc xin cần tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt tỷ lệ 90% là các vắc xin:

- A. Bạch hầu, Lao, Ho gà, Uốn Ván, Sởi, Bại Liệt, Viêm gan B
- B. Lao, Bạch hầu, Uốn Ván, Sởi, Bại Liệt, Viêm gan B, Hib
- C. Uốn ván, Ho gà, Bạch hầu, Lao, Sởi, Rotavirus, Viêm gan B
- D. Lao, Bạch hầu, Sởi, Quai bị, Uốn ván, Viêm gan B, Ho gà

[
]

Mục tiêu cụ thể của chương trình tiêm chủng mở rộng là :

- A. Tiêm đủ mũi uốn ván cho phụ nữ có thai
- B. Triển khai tiêm nhắc lại vắc xin sởi mũi 2 trên phạm vi cả nước
- C. Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi cho trẻ từ 1-5 tuổi
- D. Cả 3 ý trên

[
]

Case study - Một bà mẹ bé 1 bé trai 15 ngày tuổi đến trạm y tế xã xin bác sĩ tư vấn và chỉ định tiêm chủng, bà mẹ nói cháu chưa tiêm bất kỳ 1 loại vắc xin nào

Cháu bé có thể tiêm loại vắc xin là:

- A. Viêm gan B
- B. Lao
- C. Viêm gan B và Lao
- D. Bại liệt

[
]

Case study - Một trẻ đủ 2 tháng tuổi được mẹ đưa đến tiêm chủng

Trẻ đó cần tiêm những loại vắc xin là:

- A. Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B, Hib, Bại liệt
- B. Bạch hầu, Lao, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B, Bại liệt
- C. Bạch hầu, Ho gà, Hib, Viêm gan B, Sởi, Bại liệt
- D. Bại liệt, Bạch hầu, Ho gà, Hib, Uốn ván, Rotavirus

[
]

Vắc xin Bạch hầu được chỉ định tiêm:

- A. Mũi 1 khi trẻ đủ 2 tháng tuổi
- B. Mũi 2 cách mũi một 6 tháng
- C. Mũi 3 cách mũi hai 12 tháng
- D. Nhắc lại sau mũi ba 2 năm

[
]

Để tạo miễn dịch cơ bản cho trẻ đối với bạch hầu, uốn ván, ho gà cần tiêm vắc xin:

- A. Tiêm 2 mũi, mỗi mũi cách nhau 1 tháng, mũi 1 khi trẻ đủ 2 tháng tuổi
- B. Tiêm 3 mũi, mỗi mũi cách nhau 1 tháng, mũi 1 khi trẻ đủ 2 tháng tuổi
- C. Tiêm 2 mũi khi trẻ 2 tháng và 3 tháng tuổi, mũi thứ 3 sau mũi hai 1 năm.
- D. Tiêm 3 mũi khi trẻ đủ 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi và 6 tháng tuổi

[
]

Lịch tiêm chủng vắc xin Sởi mũi 1 là:

- A. Đủ 5-7 tháng tuổi
- B. Đủ 7-9 tháng tuổi
- C. Đủ 9-11 tháng tuổi
- D. Đủ 11-13 tháng tuổi

[
]

Lịch tiêm chủng vắc xin viêm não Nhật bản mũi 1 là:

- A. Trẻ ≥ 9 tháng tuổi
- B. Trẻ ≥ 10 tháng tuổi
- C. Trẻ ≥ 11 tháng tuổi
- D. Trẻ ≥ 12 tháng tuổi

[
]

Nếu trẻ không được tiêm chủng đúng lịch thì sau đó cần:

- A. Tiêm chủng càng sớm càng tốt
- B. Chờ đến lịch tiếp theo
- C. Không tiêm vắc xin đó nữa
- D. Cả 3 ý trên đều sai

[
]

Phụ nữ có thai lần đầu, cần tiêm vắc xin uốn ván là:

- A. 1 mũi
- B. 2 mũi
- C. 3 mũi
- D. 4 mũi

[
]

Nếu 1 người phụ nữ lần đầu mang thai đã tiêm đủ mũi vắc xin uốn ván thì các lần mang thai tiếp theo cần tiêm:

- A. 1 mũi vắc xin uốn ván
- B. 2 mũi vắc xin uốn ván
- C. 3 mũi vắc xin uốn ván
- D. 4 mũi vắc xin uốn ván

[
]

Để đạt hiệu quả phòng uốn ván sơ sinh tốt nhất thì phụ nữ mang thai phải tiêm vắc xin uốn ván mũi cuối trước khi sinh ít nhất:

- A. 1 tháng
- B. 2 tháng
- C. 3 tháng
- D. 4 tháng

[
]

Mũi uốn ván 1 và 2 phải cách nhau ít nhất:

- A. 1 tháng
- B. 6 tháng
- C. 1 năm
- D. 2 năm

[
]

Vắc xin tiêm trong da là vắc xin:

- A. Lao
- B. Sởi
- C. Viêm não Nhật bản
- D. Viêm gan B

[
]

Vắc xin tiêm dưới da là vắc xin:

- A. Lao
- B. Bạch hầu
- C. Viêm não Nhật bản
- D. Viêm gan B

[
]

Vắc xin tiêm dưới da là vắc xin:

- A. Hib
- B. Sởi
- C. Thương hàn
- D. Viêm gan B

[
]

Vắc xin tiêm bắp là vắc xin:

- A. Lao
- B. Sởi
- C. Viêm não Nhật bản
- D. Viêm gan B

[
]

Vắc xin KHÔNG phải là vắc xin tiêm bắp là:

- A. Bạch hầu
- B. Uốn ván

- C. Bại liệt
- D. Viêm gan B

[
]

Vị trí tiêm các loại vắc xin tiêm bắp cho trẻ ≤ 12 tháng tuổi là ở:

- A. Mông
- B. Cánh tay
- C. Đùi
- D. Có thể lựa chọn một trong các vị trí trên

[
]

Chỉ định hoãn tiêm chủng nếu trẻ:

- A. Ốm
- B. Sốt
- C. Đang mắc các bệnh nhiễm trùng cấp tính
- D. Cả 3 ý trên

[
]

Chống chỉ định tiêm chủng nếu trẻ:

- A. Sốt cao
- B. Có tiền sử phản ứng mạnh với liều vắc xin cùng loại ở lần tiêm trước
- C. Đang mắc bệnh nhiễm trùng cấp tính
- D. Cả 3 ý trên

[
]

[<g>] NGUYÊN LÝ PHÒNG CHỐNG DỊCH [</g>]

Biện pháp nào giúp đề phòng các bệnh truyền nhiễm là:

- A. Các biện pháp nhà nước
- B. Các biện pháp y tế
- C. Các biện pháp giáo dục sức khỏe cho nhân dân
- D. Cả 3 ý trên

[
]

Biện pháp nhà nước giúp phòng chống các bệnh truyền nhiễm là:

- A. Các biện pháp chẩn đoán và phát hiện sớm
- B. Các biện pháp giáo dục sức khỏe
- C. Các biện pháp trong kế hoạch kinh tế quốc dân
- D. Cả 3 ý trên

[
]

Biện pháp KHÔNG phải biện pháp nhà nước trong lĩnh vực vệ sinh giúp phòng chống các bệnh truyền nhiễm là:

- A. Cung cấp nước sạch
- B. Vận chuyển và xử lý rác
- C. Quy hoạch nơi chôn cất tử thi
- D. Giáo dục tập quán vệ sinh

[
]

Nội dung giáo dục sức khỏe giúp phòng chống các bệnh truyền nhiễm là:

- A. Giáo dục cho nhân dân hiểu về các bệnh truyền nhiễm
- B. Giáo dục cho nhân dân các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm
- C. Giáo dục cho nhân dân các biện pháp chống bệnh truyền nhiễm

D. Cả 3 ý trên

[
]

Các biện pháp phòng dịch được tiến hành khi:

A. Chưa có dịch

B. Có dịch

C. Sau khi có dịch

D. Cả 3 ý trên

[
]

Các biện pháp chống dịch được tiến hành khi:

A. Chưa có dịch

B. Có dịch

C. Sau khi có dịch

D. Cả 3 ý trên

[
]

Các biện pháp phòng chống dịch nhằm tác động vào:

A. Nguồn truyền nhiễm

B. Đường truyền nhiễm

C. Khỏi cảm nhiễm

D. Cả 3 ý trên

[
]

Các biện pháp chủ yếu để phòng chống các bệnh truyền nhiễm là:

A. Các biện pháp đối với nguồn truyền nhiễm

B. Các biện pháp đối với đường truyền nhiễm

C. Các biện pháp tăng cường sức đề kháng cho nhân dân

D. Tất cả các biện pháp kể trên

[
]

Chẩn đoán phát hiện sớm một bệnh nhân trong một vụ dịch không dựa vào:

A. Chẩn đoán lâm sàng

B. Chẩn đoán xét nghiệm

C. Điều tra dịch tễ học

D. Các nghiên cứu dịch tễ học phân tích

[
]

Phải khai báo, thông báo đặc biệt các bệnh là:

A. Sốt vàng, Dịch hạch và Tả

B. Sốt vàng, Dịch hạch và Tiêu chảy cấp

C. Tả, Dịch hạch và Sốt rét

D. Tả, Sốt vàng và Cúm

[
]

Cách ly có nghĩa là sự tách biệt hoặc giới hạn hoạt động của:

A. Những người trong một hộ gia đình

B. Các gia đình sống gần nhau

C. Tất cả những người đã tiếp xúc

D. Những người nhiễm khuẩn

[
]

Nếu được yêu cầu đến để điều tra một bệnh truyền nhiễm, điều đầu tiên anh/chị cần xác định là :

- A. Phương thức lây truyền
- B. Kiểm tra lại chẩn đoán
- C. Phương pháp phòng chống
- D. Giới hạn của khu dịch

[
]

Các biện pháp sau áp dụng đối với nguồn truyền nhiễm,TRỪ:

- A. Chẩn đoán, phát hiện sớm
- B. Cách ly
- C. Khử trùng
- D. Tiêm vắc xin

[
]

Nhìn chung biện pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá là:

- A. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân
- B. Cắt đường truyền nhiễm
- C. Phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân.
- D. Tiêm vaccin phòng bệnh.

[
]

Nhìn chung các biện pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh truyền nhiễm đường hô hấp là:

- A. Phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân.
- B. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân.
- C. Cắt đường truyền nhiễm.
- D. Tiêm vaccin phòng bệnh.

[
]

Nhìn chung các biện pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh truyền nhiễm đường máu là:

- A. Phát hiện sớm và điều trị triệt để bệnh nhân.
- B. Cắt đường truyền nhiễm.
- C. Tiêm vaccin phòng bệnh.
- D. Điều trị dự phòng cho những người tiếp xúc với bệnh nhân.

[
]

Nhìn chung các biện pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh truyền nhiễm qua đường da và niêm mạc là:

- A. Phát hiện sớm và điều trị triệt để bệnh nhân.
- B. Cách ly và khử trùng chất thải bỏ của bệnh nhân.
- C. Tiêm vaccin phòng bệnh.
- D. Giáo dục sức khoẻ và vệ sinh cá nhân.

[
]

Biện pháp KHÔNG áp dụng đối với đường truyền nhiễm của nhóm bệnh đường tiêu hóa là:

- A. Cung cấp nước sạch
- B. Xử lý phân

- C. Giải quyết rác
- D. Diệt côn trùng truyền bệnh

[
]

Biện pháp áp dụng đối với đường truyền nhiễm của nhóm bệnh đường máu là:

- A. Diệt côn trùng truyền bệnh
- B. Giáo dục sức khỏe
- C. Diệt ruồi
- D. Tất cả các biện pháp trên

[
]

Biện pháp áp dụng đối với khối cảm thụ là:

- A. Tiêm vắc xin
- B. Chẩn đoán sớm
- C. Cách ly
- D. Điều trị

[
]

Biện pháp áp dụng đối với khối cảm thụ là:

- A. Gây miễn dịch chủ động
- B. Gây miễn dịch thụ động
- C. Dùng hóa dược
- D. Tất cả các biện pháp trên

[
]

[<g>] DỊCH TỄ HỌC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM [</g>]

Bệnh không lây nhiễm KHÔNG phải là bệnh:

- A. Không có khả năng lây truyền từ người sang người.
- B. Thường không xác định được nguyên nhân gây bệnh cụ thể
- C. Có thể xác định được yếu tố nguy cơ
- D. Không thể phòng ngừa được

[
]

Theo Tổ chức Y tế thế giới, bốn nhóm bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất là:

- A. Bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường, bệnh đường hô hấp mạn tính
- B. Bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường, tai nạn thương tích
- C. Bệnh tim mạch, ung thư, xơ gan, đái tháo đường
- D. Bệnh tim mạch, xơ gan, đái tháo đường, bệnh đường hô hấp mạn tính

[
]

Yếu tố nguy cơ chung của các bệnh không lây nhiễm phổ biến là, TRỪ:

- A. Hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia.
- B. Dinh dưỡng không hợp lý
- C. Ô nhiễm môi trường

D. Hạn chế vận động thể lực.

[
]

Bệnh không lây nhiễm là bệnh của các nước:

A. Thu nhập cao

B. Thu nhập thấp

C. Thu nhập trung bình

D. Tất cả các nước

[
]

Tỉ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm chủ yếu ở các nước :

A. Thu nhập cao

B. Thu nhập thấp

C. Thu nhập trung bình

D. Thu nhập thấp và trung bình

[
]

Tỉ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm cao hơn các bệnh lây nhiễm ở các nước khu vực TRỪ:

A. Châu Mỹ

B. Châu Phi

C. Châu Âu

D. Đông Nam Á.

[
]

Theo báo cáo của WHO, bệnh không lây nhiễm chiếm tỉ lệ tử vong cao nhất trên thế giới là :

A. Bệnh đái tháo đường

B. Bệnh tim mạch

C. Bệnh ung thư.

D. Bệnh phổi mạn tính

[
]

Tại Việt Nam, bệnh không lây nhiễm chiếm tỉ lệ tử vong cao nhất là :

A. Bệnh đái tháo đường

B. Bệnh tim mạch

C. Bệnh ung thư.

D. Bệnh phổi mạn tính

[
]

Tại Việt Nam, năm có tỉ lệ mắc bệnh không lây nhiễm cao hơn tỉ lệ mắc bệnh lây nhiễm là :

A. 1976

B. 1986

C. 1996

D. Tất cả các ý trên đều sai

[
]

Tại Việt Nam, năm có tỉ lệ tử vong do bệnh không lây nhiễm cao hơn tỉ lệ tử vong do bệnh lây nhiễm là :

A. 1976

B. 1986

C. 1996

D. Tất cả các ý trên đều sai

[
]

Hút thuốc lá có thể gây ra các loại ung thư sau TRỪ:

A. Ung thư thực quản

B. Ung thư dạ dày

C. Ung thư tụy

D. Ung thư não

[
]

Bệnh tim mạch quan trọng nhất liên quan đến hút thuốc lá là:

A. Bệnh mạch vành

B. Bệnh mạch máu ngoại vi

C. Phình động mạch chủ

D. Rối loạn nhịp tim

[
]

Chế độ ăn nhiều chất béo động vật làm tăng nguy cơ gây ung thư:

- A. Vú và đại trực tràng
- B. Vú và cổ tử cung
- C. Cổ tử cung và đại trực tràng
- D. Cổ tử cung và vú

[
]

Thực phẩm chứa nhiều muối nitrat, nitrit làm tăng nguy cơ gây ung thư:

- A. Gan
- B. Lách
- C. Thực quản
- D. Tụy.

[
]

Nấm mốc trong gạo, lạc làm tăng nguy cơ gây ung thư:

- A. Vòm họng
- B. gan
- C. Đại trực tràng
- D. Tụy

[
]

Yếu tố bảo vệ của bệnh tim mạch là:

- A. HDL-C
- B. LDL-C
- C. Triglycerid
- D. Tất cả các câu trên đều sai

[
]

Lạm dụng rượu bia là yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng gây ung thư sau, TRỪ:

- A. Ung thư vòm họng
- B. Ung thư vú
- C. Ung thư thanh quản
- D. Ung thư tuyến giáp

[
]

Một đơn vị uống chuẩn là lượng đồ uống tương đương:

- A. 5 gram cồn nguyên chất
- B. 10 gram cồn nguyên chất
- C. 15 gram cồn nguyên chất
- D. 20 gram cồn nguyên chất

[
]

Lượng rượu uống an toàn là:

- A. Dưới 1 đơn vị uống chuẩn/ngày đối với nam và nữ, một tuần có 2 ngày không uống bia rượu
- B. Dưới 2 đơn vị uống chuẩn/ngày đối với nam và dưới 1 đơn vị uống chuẩn/ngày đối với nữ, một tuần có 2 ngày không uống bia rượu
- C. Dưới 4 đơn vị uống chuẩn/ngày đối với nam và dưới 2 đơn vị uống chuẩn/ngày đối với nữ, một tuần có 2 ngày không uống bia rượu
- D. Dưới 6 đơn vị uống chuẩn/ngày đối với nam và dưới 4 đơn vị uống chuẩn/ngày đối với nữ, một tuần có 2 ngày không uống bia rượu

[
]

Yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch là:

- A. Lạm dụng rượu
- B. Uống rượu hàng ngày ở mức độ vừa phải
- C. Uống rượu hàng ngày ở mức độ ít
- D. Tất cả các ý trên đều đúng

[
]

Nguyên tắc cơ bản để phòng chống bệnh không lây phổ biến là:

- A. Lồng ghép các hoạt động phòng chống
- B. Dựa vào cộng đồng
- C. Toàn diện
- D. Tất cả các ý trên đều đúng

[
]

Nguyên tắc phòng chống bệnh không lây nhiễm ”dựa vào cộng đồng” với mục đích TRỪ:

- A. Tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ phòng chống yếu tố nguy cơ
- B. Sàng lọc phát hiện sớm

C. Theo dõi sau khi đã ổn định tại các cơ sở y tế

D. Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực

[
]

Nguyên tắc phòng chống bệnh không lây nhiễm “toàn diện” bao gồm:

A. Cả 3 cấp độ dự phòng

B. Có sự phối hợp đa ngành

C. Xây dựng mô hình phòng chống chung cho các bệnh không lây nhiễm

D. Tất cả các ý trên đều đúng

[
]

Các loại ung thư trong nhóm 10 loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới Việt Nam TRỪ:

A. Phổi

B. Dạ dày

C. Gan

D. Tuyến giáp

[
]

Các loại ung thư trong nhóm 10 loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới Việt Nam TRỪ:

A. Vú

B. Tuyến giáp

C. Dạ dày

D. Gan

[
]

Loại ung thư hay gặp ở người tiếp xúc với nhựa đường hắc ín là ung thư:

A. Da

B. Phổi

C. Bàng quang

D. Máu

[
]

Loại ung thư hay gặp ở người tiếp xúc với amiang là ung thư:

A. Ung thư da

B. Ung thư phổi

C. Ung thư bàng quang

D. Ung thư máu

[
]

Loại ung thư hay gặp ở những người thợ nhuộm tiếp xúc với anilin là:

A. Ung thư da

B. Ung thư phổi

C. Ung thư bàng quang

D. Ung thư máu

[
]

Loại ung thư hay gặp ở người tiếp xúc với tia phóng xạ là ung thư:

A. Ung thư da

B. Ung thư phổi

C. Ung thư bàng quang

D. Ung thư máu

[
]

Vi rút Epstein – Barr gây ung thư:

A. Vòm họng

B. Gan

C. Thanh quản

D. Phổi

[
]

Không hút thuốc phòng ung thư là biện pháp dự phòng :

A. Cấp 0

B. Cấp 1

C. Cấp 2

D. Cấp 3

[
]

Tiêm phòng vaccin viêm gan B cho trẻ em là biện pháp dự phòng:

A. Cấp 0

B. Cấp 1

C. Cấp 2

D. Cấp 3

[
]

Sàng tuyển phát hiện sớm ung thư vú là biện pháp dự phòng:

A. Cấp 0

B. Cấp 1

C. Cấp 2

D. Cấp 3

[
]

Cung cấp đủ thuốc chống đau cho bệnh nhân ung thư là biện pháp dự phòng:

A. Cấp 0

B. Cấp 1

C. Cấp 2

D. Cấp 3

[
]

Biện pháp sàng lọc tăng huyết áp là:

A. Đo huyết áp

B. Đánh giá các yếu tố nguy cơ

C. Đánh giá tổn thương cơ quan đích

D. Tất cả các ý trên đều đúng

[
]

Biện pháp sử dụng để phát hiện sớm ung thư vú bao gồm:

A. Tự khám vú

B. Chụp XQuang vú

C. Khám vú tại cơ sở y tế chuyên khoa

D. Tất cả các ý trên đều đúng

[
]

Dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng TRỪ:

A. Thay đổi phân

- B. Chảy máu trực tràng
- C. Giảm áp lực trong trực tràng
- D. Đau bụng bất thường

[
]

Dấu hiệu cảnh báo ung thư khoang miệng TRƯ:

- A. Há miệng bị hạn chế
- B. Nấm miệng
- C. Các nốt sùi ở miệng
- D. Chảy máu

[
]

Đối tượng cần sàng lọc bệnh đái tháo đường 2 năm 1 lần là những người:

- A. Từ 65 tuổi trở lên
- B. Từ 55 tuổi trở lên
- C. Từ 45 tuổi trở lên
- D. Từ 35 tuổi trở lên

[
]

Đối tượng cần sàng lọc bệnh đái tháo đường hàng năm là:

- A. Những người giảm dung nạp hoặc rối loạn đường huyết lúc đói
- B. Những người 1 lần có kết quả xét nghiệm đường máu bất thường
- C. Phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang
- D. Tất cả các ý trên đều đúng

[
]

Xét nghiệm phát hiện sớm ung thư tiền liệt tuyến là:

- A. PSA
- B. AFP
- C. CEA
- D. CA 125

[
]

Theo phân loại HA của JNC VI và WHO/ESH, tiền tăng huyết áp là:

- A. HA tâm thu 125-134 mm Hg hoặc HA tâm trương 80-85 mmHg
- B. HA tâm thu 125-134 mm Hg hoặc HA tâm trương 80-89 mmHg
- C. HA tâm thu 130-139 mm Hg hoặc HA tâm trương 80-85 mmHg
- D. HA tâm thu 130-139 mm Hg hoặc HA tâm trương 80-89 mmHg

[
]

Theo JNC VI và WHO/ESH, chiến lược kiểm tra lại đối với người tiền tăng huyết áp là trong vòng:

- A. 3 tháng
- B. 6 tháng
- C. 1 năm
- D. 2 năm

[
]

Theo JNC VI và WHO/ESH, chiến lược kiểm tra lại đối với người huyết áp bình thường là trong vòng:

- A. 6 tháng
- B. 12 tháng
- C. 18 năm
- D. 24 tháng

[
]

Theo JNC VI và WHO/ESH, chiến lược kiểm tra lại đối với người tăng huyết áp độ 1 là trong vòng:

- A. 2 tháng
- B. 3 tháng
- C. 4 tháng
- D. 5 tháng

[
]

Theo phân loại tình trạng dinh dưỡng theo chỉ số khối cơ thể (BMI), mức độ thừa cân là:

- A. $BMI > 22$
- B. $BMI > 22,5$
- C. $BMI > 23$
- D. $BMI > 23,5$

[
]

Theo phân loại tình trạng dinh dưỡng theo chỉ số khối cơ thể (BMI), mức độ tiền béo phì là:

- A. $22,5 < BMI < 24$
- B. $22,5 < BMI < 25$
- C. $23 < BMI < 24$
- D. $23 < BMI < 25$

[
]

[<g>]PHẦN TEST TỔNG HỢP CƠ BẢN[</g>]

Các nghiên cứu Dịch tễ học tập trung vào nghiên cứu:

- A. Cá thể
- B. Quần thể
- C. Loài
- D. Nhóm

[
]

Sự xuất hiện vượt quá số mong đợi của các ca bệnh/sự kiện liên quan đến sức khỏe trong một cộng đồng được gọi là:

- A. Đại dịch
- B. Dịch địa phương
- C. Dịch
- D. Dịch khu vực

[
]

Bất kể yếu tố nào làm thay đổi đến điều kiện sức khỏe được gọi là:

- A. Yếu tố ảnh hưởng
- B. Yếu tố nguy cơ
- C. Yếu tố trung gian
- D. Hậu quả đầu ra

[
]

Dự phòng ở giai đoạn sớm của bệnh để làm giảm sự tiến triển bệnh gọi là:

- A. Dự phòng cấp 0
- B. Dự phòng cấp I
- C. Dự phòng cấp II
- D. Dự phòng cấp III

[
]

Triển khai một chương trình giáo dục sức khỏe là dự phòng:

- A. Dự phòng cấp 0
- B. Dự phòng cấp I
- C. Dự phòng cấp II
- D. Dự phòng cấp III

[
]

Nghiên cứu Dịch tễ học mô tả sự phân bố vấn đề sức khỏe trong cộng đồng gọi là nghiên cứu:

- A. Phân tích
- B. Mô tả
- C. Quan sát
- D. Can thiệp

[
]

Dịch Black Death là dịch:

A. Dịch hạch

B. Tả

C. Đậu mùa

D. Thương hàn

[
]

Percival Pott đã quan sát và thấy rằng những người thợ dọn ống khói có tỉ lệ mắc bệnh cao là bệnh:

A. Ung thư phổi

B. Ung thư dạ dày

C. Ung thư bộ phận sinh dục

D. Ung thư vú

[
]

Khả năng một cá thể bị mắc một vấn đề sức khỏe hay tử vong được gọi là:

A. Sự chuyển dịch mô hình bệnh tật

B. Nguy cơ

C. Giả thuyết

D. xác suất

[
]

Số hiện mắc là:

A. Số lượng ca bệnh hoặc tử vong trong quần thể ở một thời điểm nhất định

B. Sự xảy ra ca bệnh mới mắc trong một khoảng thời gian cụ thể trên một quần thể xác định

C. Tỉ lệ được tính bằng số sự kiện xảy ra trong quần thể trong một khoảng thời gian nhất định.

D.

[
]

Số đếm (count) là:

A. Sự xảy ra ca bệnh mới mắc trong một khoảng thời gian cụ thể trên một quần thể xác định

B. Số ca bệnh hoặc vấn đề sức khỏe đang nghiên cứu mà nhà nghiên cứu đếm được

C. Cả A và B

D. không phải A, B, C

[
]

Ca bệnh mới mắc trong một khoảng thời gian cụ thể trên một quần thể xác định được gọi là:

- A. Số mới mắc
- B. Số hiện mắc
- C. Số đếm
- D. Tần số

[
]

Tỉ suất là một dạng của tỉ lệ:

- A. Có tính đến yếu tố thời gian
- B. Được sử dụng để đo lường nguy cơ
- C. Được sử dụng để đo lường hậu quả
- D. Được sử dụng để đo lường yếu tố nhiễu

[
]

Một dạng của tỉ lệ tử vong được tính toán không cân nhắc đến yếu tố nhân khẩu và có thể dẫn đến những nhận định sai là:

- A. Tỉ lệ mắc thô
- B. Tỉ lệ mắc hiệu chỉnh theo tuổi
- C. Tỉ lệ mắc theo nguyên nhân
- D. Tỉ lệ mắc/tử vong chuyên biệt theo nhóm tuổi

[
]

Một dạng của tỉ lệ tử vong tính theo nguyên nhân gây tử vong được gọi là:

- A. Tử vong thô
- B. Tử vong theo giới
- C. Tử vong theo nguyên nhân
- D. Tử vong theo tuổi

[
]

Tỉ lệ tử vong tính trên nhóm người mắc một bệnh cụ thể gọi là:

- A. Tử vong thô
- B. Chết trên mắc
- C. Tử vong theo nguyên nhân
- D. Tử vong chuyên biệt theo tỉ lệ

[
]

Số ca tử vong trong một quần thể do một bệnh hoặc một nguyên nhân cụ thể chia cho tổng số ca tử vong trong quần thể rồi nhân với 100 gọi là:

- A. Tử vong thô
- B. Tử vong theo nguyên nhân
- C. Tử vong chuyên biệt theo tỉ lệ
- D. Chết trên mắc

[
]

Chỉ số đợt bệnh xảy ra của một bệnh trong suốt cuộc đời một con người là tỉ lệ:

- A. Hiện mắc kỳ
- B. Mắc vòng đời
- C. Hiện mắc điểm
- D. Mới mắc

[
]

Sinh, tử, cưới xin, li dị, chết chu sinh là những ví dụ về sự kiện:

- A. Trong cuộc sống
- B. Sống còn
- C. Chấn thương
- D. Sức khỏe

[
]

Thu thập thông tin một cách hệ thống và liên tục về sự xảy ra các vấn đề sức khỏe bệnh tật của quần thể được gọi là:

- A. Phân tích số liệu
- B. Giám sát y tế công cộng
- C. Giám sát hội chứng
- D. Giám sát lâm sàng

[
]

Việc sử dụng các số liệu y tế để phát hiện hoặc dự báo khả năng xảy ra của các vấn đề sức khỏe hoặc vụ dịch và định hướng các can thiệp dự phòng gọi là:

- A. Phân tích số liệu
- B. Giám sát y tế công cộng
- C. Giám sát hội chứng
- D. Giám sát lâm sàng

[
]

Cơ sở dữ liệu ghi nhận/ thu thập các thông tin về bệnh tật gọi là:

- A. Nơi đăng ký (registry)
- B. Giám sát YTCC
- C. Giám sát lâm sàng
- D. Hồ sơ

[
]

Thuật ngữ chỉ số năm một người mong đợi sống tối đa là:

- A. Tử vong mẹ
- B. Tuổi thọ
- C. Tử vong trẻ

D. Tuổi thọ trung bình

[
]

Thuật ngữ chỉ tử vong mẹ do nguyên nhân từ thai sản là:

A. Fetal Mortality

B. Infant Mortality

C. Maternal Mortality

D. Mother mortality

[
]

Tử vong trẻ trước khi được sinh ra gọi là:

A. Fetal Mortality

B. Maternal Mortality

C. Infant Mortality

D. Adult mortality

[
]

Số trẻ sinh ra sống trong một khu vực trong một khoảng thời gian chia cho tổng số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-44) trong khu vực đó được gọi là tỉ suất:

A. Sinh thô

B. Tử vong chu sinh (Perinatal Mortality Rate)

C. Sinh chung (General fertility rate)

D. Sinh chuyên biệt theo nhóm tuổi

[
]

Tổng số tử vong ở khoảng thời gian từ sau 28 tuần thai kỳ tới ≤ 7 ngày sau sinh trong một khoảng thời gian trong một quần thể trên tổng số trẻ sinh ra sống cộng số chết bào thai sau 28 tuần thai kỳ trong cùng giai đoạn của cùng quần thể đó được gọi là:

A. Infant Fertility Rate

B. Perinatal Mortality Rate

C. Fetal Mortality Rate

D. Case fertility rate

[
]

Nội dung KHÔNG phải là mục đích của nghiên cứu mô tả là:

A. Cho phép đánh giá chiều hướng sức khỏe trong cộng đồng.

B. Cung cấp cơ sở cho lập kế hoạch, cung cấp và đánh giá dịch vụ y tế.

C. Cải thiện các nghiên cứu về chiều hướng tử vong bào thai trong một khu vực nhất định.

D. Gợi ý hình thành giả thuyết

[
]

Loại nghiên cứu cung cấp thông tin về sự xảy ra của vấn đề sức khỏe theo con người, địa điểm và thời gian là nghiên cứu dịch tễ học:

- A. M tả
- B. Phân tích
- C. Can thiệp
- D. Môi trường

Nghiên cứu là ví dụ về một dạng của nghiên cứu mô tả là:

- A. Nghiên cứu bệnh chứng
- B. Báo cáo ca bệnh
- C. Nghiên cứu thuần tập
- D. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng

[
]

Chủng tộc và điều kiện kinh tế xã hội là ví dụ về:

- A. Đặc trưng con người
- B. Chiều hướng theo thời gian dài
- C. Chùm quần thể
- D. Đặc trưng về nhân khẩu học

[
]

Thuật ngữ chỉ xuất xứ của từng cá thể hoặc họ hàng làng nước gọi là:

- A. Quê quán
- B. Cộng đồng
- C. Tử vi
- D. nơi ở

[
]

Thuật ngữ chỉ vị trí của con người trong xã hội được gọi là:

- A. Tình trạng kinh tế, xã hội
- B. Lá số
- C. Chùm
- D. Tầng

[
]

Dịch xảy ra tại từng thời điểm là ví dụ của sự xuất hiện bệnh theo:

- A. Địa điểm
- B. Thời gian
- C. Không gian
- D. Con người

[
]

Tăng và giảm tần số mắc bệnh trong một khoảng thời gian nhiều năm hoặc trong một năm gọi là:

- A. Xu hướng của nhiều năm
- B. Dịch tại từng thời điểm
- C. Xu hướng về chu kỳ dịch
- D. Dịch tại từng thời kỳ

[
]

Texas Sharpshooter Effect liên quan tới nội dung:

- A. Point Epidemics
- B. Secular Trends
- C. Clustering
- D. Stratifying

[
]

Thuật ngữ chỉ đặc trưng, số lượng có sự thay đổi theo thời gian gọi là:

- A. Sự kết hợp
- B. Biến số
- C. Giá trị thường gặp
- D. Giá trị trung vị

[
]

Sự kết hợp giữa hai biến số có thể là:

- A. Luôn là kết hợp dương
- B. Luôn là kết hợp âm
- C. Hoặc là kết hợp dương hoặc là kết hợp dương
- D. Luôn là A và B

[
]

Một trong những tiêu chuẩn về kết hợp căn nguyên được đề cập là:

- A. Tính tạm thời
- B. Nồng độ sinh học
- C. Tính logic của thứ tự xuất hiện nguyên nhân và hậu quả
- D. Tính chắc chắn

[
]

Ví dụ về kết hợp giữa phơi nhiễm với nhựa đường và dầu và ung thư sinh dục ở những người thợ dọn ống khói là ví dụ về:

- A. Tính tạm thời
- B. Nồng độ sinh học
- C. Tính logic của thứ tự xuất hiện nguyên nhân và hậu quả
- D. Tính chắc chắn

[
]

Loại kết hợp mà ở đó khi một đại lượng này tăng lên bao nhiêu thì đại lượng kia cũng tăng lên tương ứng là kết hợp:

- A. Dương tính
- B. Âm tính
- C. Liên tục
- D. Rời rạc

[
]

Một giá trị đơn được lựa chọn để đại diện cho tham số quần thể được gọi là:

- A. Sự suy diễn
- B. Ước lượng khoảng tin cậy
- C. Ước lượng điểm
- D. Ước lượng trung bình

[
]

Thuật ngữ đề cập đến một nghiên cứu mà đơn vị phân tích là quần thể hoặc một nhóm người chứ không phải là các cá thể được gọi là nghiên cứu:

- A. Sinh thái học
- B. Bệnh chứng
- C. Thuận tập
- D. Can thiệp

[
]

Nghiên cứu Framingham Study là ví dụ về nghiên cứu:

- A. Sinh thái học
- B. Bệnh chứng
- C. Thuận tập
- D. Can thiệp

[
]

Thu nhận thông tin về phơi nhiễm xảy ra trong quá khứ là một ví dụ về nghiên cứu:

- A. Tiến cứu
- B. Hồi cứu
- C. Sinh thái
- D. Điều tra ngang

[
]

Đo lường trong nghiên cứu bệnh chứng sử dụng chỉ số:

- A. r tương quan
- B. OR (Odds Ratio)
- C. RR (Relative Risk)
- D. RRD(Risk reduction defference)

[
]

Đo lường trong nghiên cứu thuận tập sử dụng chỉ số:

- A. r tương quan
- B. OR (Odds Ratio)
- C. RR (Relative Risk)
- D. RRD(Risk reduction defference)

[
]

Thiết kế nghiên cứu mà ở đó nhà nghiên cứu thử nghiệm một can thiệp nhưng đối tượng nghiên cứu được phân bổ không ngẫu nhiên vào các nhóm thuộc loại thiết kế:

- A. Bán thử nghiệm lâm sàng
- B. Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng
- C. Bệnh chứng
- D. Thuần tập

[
]

Thuật ngữ đề cập đến một quan sát mà ở đó quần thể đích có tỉ lệ tử vong thấp hơn so với quần thể chung được gọi là:

- A. Hawthorne Effect
- B. Healthy Worker Effect
- C. Ecological Fallacy
- D. Loss follow up

[
]

Thuật ngữ chỉ khả năng một công cụ đo lường đảm bảo cho những kết quả thống nhất nếu thực hiện rút mẫu nhiều lần khác nhau để làm nghiên cứu là:

- A. Độ tin cậy
- B. Tính giá trị
- C. Độ nhạy
- D. Độ đặc hiệu

[
]

Giá trị đề cập tới khả năng một trắc nghiệm phát hiện được những cá thể không bị bệnh và thực tế là họ cũng không bị bệnh là:

- A. Tính giá trị
- B. Độ nhạy
- C. Độ đặc hiệu
- D. Độ lặp lại

[
]

Thuật ngữ chỉ nơi mà tác nhân gây bệnh có xâm nhập, tồn tại và phát triển là:

- A. Vật chủ
- B. Tác nhân
- C. Môi trường
- D. Người mang mầm bệnh

[
]

Thuật ngữ chỉ sự đề kháng của một cộng đồng/ quần thể đối với một tác nhân nhiễm trùng và được xem là kết quả của miễn dịch rộng rãi trên toàn bộ quần thể với tác nhân gây bệnh đó là miễn dịch:

- A. Chủ động
- B. Chung loài
- C. Thụ động
- D. Nhân tạo

[
]

Thuật ngữ chỉ khoảng thời gian từ khi tác nhân nhiễm trùng xâm nhập cơ thể đến khi có biểu hiện triệu chứng hoặc hội chứng đầu tiên ở người bị nhiễm trùng là:

- A. Khoảng thời gian nhiễm trùng
- B. Thời kỳ ủ bệnh
- C. Thời kỳ độc tính
- D. Khả năng gây tử vong

[
]

Clostridium botulinum là ví dụ về tác nhân gây bệnh qua:

- A. Đường tình dục
- B. Đường tiêu hóa
- C. Véc tơ truyền bệnh
- D. Đường hô hấp

[
]

Vì rút bại liệt lây truyền qua:

- A. Đường tình dục
- B. Đường tiêu hóa
- C. Véc tơ truyền bệnh
- D. Đường hô hấp

[
]

Vắc xin cho tới thời điểm 2014, Việt Nam chưa sản xuất được nhưng đã đưa vào tiêm chủng mở rộng là vắc xin:

- A. Rubella
- B. Uốn ván
- C. Sởi
- D. Thương hàn

[
]

Thuật ngữ chỉ sự lây truyền bệnh từ động vật sang người là:

- A. Sexually Transmitted Disease
- B. Zoonotic Disease

C. Foodborne Illness

D. airborne disease

[
]

Viêm gan virus C là ví dụ của nhiễm trùng lây truyền qua:

A. Đường không khí

B. Vật dụng gián tiếp

C. Côn trùng tiết tó trung gian

D. Đường tiêu hóa

[
]

Nghiên cứu nên áp dụng khi nhà nghiên cứu quan tâm tới các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và khai thác về các phơi nhiễm xảy ra liên quan tới hậu quả sức khỏe tiềm ẩn này là:

A. Can thiệp

B. Bệnh chứng

C. Thuần tập hồi cứu

D. Sinh thái

[
]

Nghiên cứu phù hợp cho thiết kế hoặc tiến cứu hoặc hồi cứu khi nhà nghiên cứu quan tâm tới những phơi nhiễm hiếm gặp là:

A. Can thiệp

B. Thuần tập

C. Điều tra ngang

D. Bệnh chứng

[
]

Độ mạnh của một kết hợp là một trong những tiêu chuẩn đánh giá mối quan hệ nhân quả, chỉ số được sử dụng tốt nhất để đo lường sự kết hợp là:

A. Số mới mắc trong nhóm phơi nhiễm

B. Số mới mắc tích lũy trong nhóm phơi nhiễm

C. Tỷ số của hai độ chênh (odds) về phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ trong nhóm bệnh và nhóm không mắc bệnh.

D. Tỷ số của hai độ chênh (odds) về mắc bệnh và không mắc bệnh giữa nhóm phơi nhiễm và không phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ

[
]

Tỷ suất mới mắc của một bệnh luôn luôn phản ánh nguy cơ mắc bệnh. Tỷ suất mới mắc được đo lường trong:

A. nghiên cứu thuần tập

B. Nghiên cứu bệnh chứng

C. Điều tra ngang

D. Nghiên cứu tương quan

[
]

Nguyên cơ qui thuộc quần thể là:

- A. Tỷ suất
- B. Tỷ lệ
- C. Tỷ số
- D. Cả 3 ý trên đều sai

[
]

Mật độ mới mắc là:

- A. Tỷ suất
- B. Tỷ lệ
- C. Tỷ số
- D. Cả 3 ý trên đều sai

[
]

Số hiện mắc là:

- A. Tỷ suất
- B. Tỷ lệ
- C. Tỷ số
- D. Cả 3 ý trên đều sai

[
]

Nguyên cơ tương đối là:

- A. Tỷ suất
- B. Tỷ lệ
- C. Tần số
- D. Cả 3 ý trên đều sai

[
]

(Case study - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<6>}) Một nghiên cứu thẩm định về tình trạng tử vong liên quan đến nghề nghiệp bằng việc đối chiếu thông tin tử vong ghi trong giấy chứng tử và và bảng phân loại bệnh tật ICD cho thấy sau khi thẩm định 100,000 ca tử vong được xác định bằng giấy chứng tử, nhà nghiên cứu thấy có 1,195 trường hợp giấy chứng tử vong ghi nhận tử vong do bệnh nghề nghiệp đã được xếp đúng mã ICD; 788 trường hợp giấy chứng tử ghi tử vong do bệnh nghề nghiệp nhưng đối chiếu mã ICD thì không đúng. 97,672 trường hợp giấy chứng tử xác nhận tử vong không do bệnh nghề nghiệp và được xếp đúng theo qui định ICD; 345 trường hợp theo mã ICD là tử vong do bệnh nghề nghiệp nhưng lại được chứng tử ghi nhận là tử vong không do nghề nghiệp.

(<1>) Các số liệu của nghiên cứu trên được ghi vào bảng 2x2 dưới đây:

	Xếp loại ICD		
Giấy chứng tử	Tử vong do bệnh nghề nghiệp	Tử vong không do bệnh nghề nghiệp	Tổng
TV do bệnh nghề nghiệp	a	b	
TV không do bệnh nghề nghiệp	c	d	
Tổng			

Giá trị của a,b,c,d được ghi đúng vào bảng 2*2 là:

A. a. 345; b.788; c. 1195; d.97672

B. a.1195; b.788; c.345; d.97672

C. a.1195; b. 97672; c.345; d. 788

D. a. 345; b. 97672; c. 1195; d. 788

(<2>) Độ nhạy và độ đặc hiệu của việc sử dụng phương pháp xác nhận nguyên nhân tử vong bằng giấy chứng tử được tính là:

A. Độ nhạy.77,6% ; Độ đặc hiệu.99,2%

B. Độ nhạy. 60,3%; Độ đặc hiệu. 99,6%

C. Độ nhạy. 77,6%; Độ đặc hiệu. 99,6%

D. Độ nhạy 69,3%; Độ đặc hiệu. 99,2%

(<3>) Giá trị dự đoán dương tính của việc sử dụng xác nhận nguyên nhân tử vong bằng phương pháp ghi nhận qua giấy chứng tử được tính là:

A. 77%

B. 99%

C. 100%

D. 60%

(<4>) Phương pháp xác định nguyên nhân tử vong qua hệ thống ghi nhận thông tin tử vong “giấy chứng tử” cung cấp số liệu so với số tử vong do bệnh nghề nghiệp thực tế là:

A. Ước lượng non

B. Ước lượng trội

C. Ước lượng không non cũng không trội

D. Không xác định được

(<5>) Việc sử dụng số liệu từ hệ thống chứng tử trên để phân tích xu hướng tử vong do bệnh nghề nghiệp là một ví dụ về:

- A. Hệ thống giám sát chủ động
- B. Hệ thống giám sát bị động
- C. Hệ thống giám sát thuần tập hồi cứu
- D. Hệ thống giám sát điều tra ngang

(<6>) Độ nhạy và độ đặc hiệu được tính toán ở trên đo lường giá trị của phương pháp ghi nhận tử vong qua hệ thống chứng tử là:

- A. Độ chính tin cậy của hệ thống ghi nhận
- B. Độ lặp lại của hệ thống ghi nhận
- C. Tính giá trị của hệ thống ghi nhận
- D. Nguy cơ qui thuộc của hệ thống ghi nhận

[
]

(**Case study** - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<5>}) Thoái hóa điểm vàng (maculopathy) là một nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người từ 65 tuổi trở đi và ảnh hưởng từ 16 đến 26% số người trong nhóm tuổi này. Trong một nghiên cứu của Klein, những người từ 43 đến 86 tuổi thuộc một thị trấn tỉnh Wisconsin được mời tham gia nghiên cứu để xác định liệu rằng hút thuốc lá có liên quan gì tới thoái hóa hoàng điểm theo tuổi này không? Tại điều tra cơ bản ban đầu, người tham gia nghiên cứu được hỏi về thói quen hút thuốc và được theo dõi trong vòng 5 năm sau đó và được khám xác định xem có dấu hiệu của thoái hóa hoàng điểm. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bảng dưới đây.

<u>Tình trạng hút thuốc</u>	<u>N</u>	<u>Thoái hóa hoàng điểm</u>
Chưa bao giờ hút thuốc	368	26
Đã từng hút thuốc lá	864	79

(<1>) Nghiên cứu trên là thiết kế nghiên cứu:

- A. Điều tra cắt ngang
- B. Bệnh chứng
- C. Thuần tập tiến cứu
- D. Thuần tập lồng ghép bệnh chứng

(<2>) Thiết lập bảng 2 x 2 dựa trên số liệu trên là:

- A. a/b/c/d: 79/785/26/342
- B. a/b/c/d: 26/785/79/342
- C. a/b/c/d: 79/342/26/785
- D. a/b/c/d: 26/342/79/785

(<3>) Tỉ suất mới mắc tích lũy thoái hóa hoàng điểm ở nhóm không hút thuốc lá và nhóm hút thuốc lá được tính là:

- A. 0.75 và 2.23
- B. 0.064 và 0.021
- C. 0,1 và 0,076
- D. 0.091 và 0.071

(<4>) Nguy cơ tương đối của thoái hóa hoàng điểm giữa nhóm hút thuốc và nhóm không hút thuốc được tính là:

- A. 1.29
- B. 1.32
- C. 1.08
- D. 6.97

(<5>) Giả định rằng hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ của thoái hóa hoàng điểm, tỉ lệ mắc thoái hóa hoàng điểm có thể phòng ngừa được nhóm người ở thị trấn tỉnh Wisconsin nếu như người hút thuốc lá đã chưa bao giờ hút thuốc được tính là:

- A. 28
- B. 23
- C. 17
- D. 11

[
]

(Case study - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<3>}) Số liệu dưới đây thu thập được từ một nghiên cứu về đau lưng của một quốc gia. Một trường hợp được chẩn đoán là đau lưng khi có ít nhất một lần bị đau lưng kéo dài trong khoảng thời gian 6 tháng. Các trường hợp đau lưng này được xác định từ việc điều tra phỏng vấn trên các nhóm nghề nghiệp khác nhau và trên điều tra quốc gia chọn mẫu ngẫu nhiên.

	Sản xuất điện thoại di động			Ngành dệt			Điều tra quốc gia chọn mẫu ngẫu nhiên		
Nhóm tuổi	Người	Ca đau lưng	Tỉ lệ	Người	Ca đau lưng	Tỉ lệ	Người	Ca đau lưng	Tỉ lệ
25-39	1000	2	.002	100	2	.02	10,000	30	.003
40-55	700	25	.037	500	30	.06	15,000	900	.06
55+	50	15	.300	1500	150	.100	15,000	1200	.08

Tổng số	1750	42	.024	2100	182	.087	40,000	2130	.053
---------	------	----	------	------	-----	------	--------	------	------

(<1>) Tỉ số đau lưng ở nhóm ngành nghề sản xuất điện thoại chuẩn hóa theo mẫu điều tra quốc gia là:

A. 0.86

B. 0.79

C. 0.02

D. 0.001

(<2>) Tỉ số đau lưng ở nhóm ngành nghề dệt chuẩn hóa theo mẫu điều tra quốc gia

A. 1.64

B. 1.21

C. 0.08

D. 0.005

(<3>) Hai tỉ số tính ở 2 câu trên có/không thể so sánh được với nhau vì:

A. Có vì sử dụng chuẩn hóa gián tiếp

B. Không vì sử dụng chuẩn hóa gián tiếp

C. Có vì sử dụng chuẩn hóa trực tiếp

D. Không vì sử dụng chuẩn hóa trực tiếp

[
]

(Case study - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<4>}) Các bằng chứng chỉ ra rằng béo phì là yếu tố nguy cơ của ung thư đại tràng còn chưa đầy đủ đặc biệt trong nhóm phụ nữ. Trong một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí quốc tế (*Am J Epidemiol* 1999;150.390-398) đã báo cáo sự kết hợp giữa béo phì và ung thư đại tràng trong nhóm nam và nữ giới từ 25-74 tuổi. Nghiên cứu này điều tra ban đầu đối tượng nghiên cứu lần đầu tiên trong điều tra dinh dưỡng quốc gia từ năm 1971 đến năm 1975 và sau đó theo dõi các đối tượng đến năm 1992. Bảng dưới đây trình bày kết quả nghiên cứu.

BMI	Số lượng ca ung thư đại tràng mới mắc	Năm-người theo dõi	Tỉ suất mới mắc thô/100.000 dân
<22	28	53,475	
22 - <24	41	38,919	
24 - <26	36	36,610	

26 - <28	40	32,635	
28 - <30	35	21,122	
30+	42	34,904	

(<1>) Loại thiết kế nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu trên là:

- A. Điều tra cắt ngang
- B. Nghiên cứu sinh thái học
- C. Nghiên cứu bệnh chứng dựa vào quần thể
- D. Nghiên cứu thuần tập

(<2>) Tỷ suất mới mắc/100.000 dân theo BMI là:

- A. BMI <22 là 52.4
- B. BMI 22 - <24 là 98.3
- C. BMI 24 - <26 là 165.7
- D. Không đủ dữ liệu để tính suất mới mắc/100.000 dân theo BMI

(<3>) Nguy cơ tương đối (RR) của ung thư đại tràng ở nhóm có BMI từ 28-<30 so với nhóm có BMI nhỏ nhất được tính là:

- A. 3.16
- B. 1.25
- C. Không đủ dữ liệu để tính
- D. Tất cả các ý trên đều sai

(<4>) Nguy cơ qui thuộc phần trăm ở nhóm BMI từ 28-<30 được tính là:

- A. 12,5
- B. 20%
- C. 31.6
- D. 68.4%

[
]

Hai lý do nghiên cứu bệnh chứng thích hợp kiểm định yếu tố nguy cơ của ung thư nào là:

- A. Là bệnh hiếm+ cho phép kiểm định đồng thời nhiều yếu tố nguy cơ
- B. Không phải bệnh hiếm + cho phép kiểm định đồng thời nhiều yếu tố nguy cơ
- C. bệnh hiếm+ chỉ cho phép kiểm định 1 nguy cơ
- D. Không phải bệnh hiếm + chỉ cho phép kiểm định 1 nguy cơ

[
]

[<g>] Sự khác biệt giữa nghiên cứu bệnh chứng dựa vào quần thể và nghiên cứu bệnh chứng không dựa vào quần thể là [</g>]

Lựa chọn nhóm chủ cứu dựa vào quần thể đại diện cho quần thể hơn lựa chọn nhóm này dựa vào bệnh viện:

A. Đúng B. Sai

[
]

Lựa chọn nhóm chủ cứu dựa vào quần thể đại diện cho nhóm bệnh trong quần thể hơn lựa chọn nhóm này dựa vào bệnh viện:

A. Đúng B. Sai

[
]

Lựa chọn nhóm đối chứng dựa vào quần thể đại diện cho nhóm người không mắc bệnh nghiên cứu trong quần thể hơn là chọn từ bệnh viện:

A. Đúng B. Sai

[
]

Lựa chọn nhóm đối chứng dựa vào quần thể đại diện cho nhóm người khỏe mạnh trong quần thể hơn là chọn từ bệnh viện:

A. Đúng B. Sai

[
]

Case study - Một điều tra quốc gia được tiến hành đánh giá tình trạng sức khỏe người dân dựa trên hệ thống đăng ký số liệu y tế sẵn có.

Thiết kế phù hợp cho việc lựa chọn đối tượng vào nghiên cứu này là

A. Nghiên cứu theo dõi dọc

B. Hệ thống giám sát thụ động

C. Điều tra cắt ngang

D. Sàng lọc dựa vào cộng đồng

[
]

Case study - Trong một nghiên cứu các ca bệnh được lựa chọn phải là các trường hợp mới được chẩn đoán có tiền sử mắc ung thư thần kinh đệm nhưng trước đó chưa được chẩn đoán bị di căn.

Điều cho thấy ưu điểm nhất của việc lựa chọn đối tượng nghiên cứu là những trường hợp mới mắc chứ không phải chọn những trường hợp đã mắc trong nghiên cứu này là:

A. Số mới mắc sẽ cho phép tính toán trực tiếp nguy cơ tương đối.

B. Sử dụng số mới mắc sẽ giảm sai số không hệ thống trong nghiên cứu bệnh chứng.

C. Việc thu thập thông tin về phơi nhiễm từ ca mới mắc ít bị ảnh hưởng bởi tình trạng mắc bệnh từ trước.

D. Sử dụng số mới mắc cho phép đánh giá về tác động của phơi nhiễm không bị sai số so với sử dụng ca đã mắc chỉ là những ca sống sót theo thời gian sẽ dẫn mất thông tin về phơi nhiễm ở những đối tượng đã tử vong.

[
]

Sai số chọn trong nghiên cứu bệnh chứng thường gây khó khăn trong phiên giải kết quả. Điều KHÔNG gây ra sai số chọn là:

- A. Tình trạng phơi nhiễm có thể ảnh hưởng tới việc chọn đối tượng vào nhóm chứng.
 - B. Tình trạng phơi nhiễm có thể ảnh hưởng tới việc chọn nhóm chủ cứu.
 - C. Tình trạng bệnh có thể ảnh hưởng tới thông tin nhớ lại
 - D. Nhóm phơi nhiễm được báo cáo nhập viện nhiều hơn nhóm không phơi nhiễm
- [
]

Case study - Nghiên cứu dưới đây thu thập thông tin về sử dụng nguồn nước trong cộng đồng dân cư một tổ dân phố. Dựa trên số liệu cung cấp của nhà máy nước về loại nguồn nước cho 85 hộ gia đình, nhà nghiên cứu gửi phiếu đến các hộ gia đình hỏi về tình hình thực tế loại nguồn nước gia đình họ sử dụng. Giả định rằng loại nguồn nước hộ gia đình sử dụng là thông tin sát thực nhất, biết độ nhạy, độ đặc hiệu, và giá trị dự đoán dương tính của việc sử dụng số liệu cung cấp từ nhà máy nước so với thực tế sử dụng lần lượt là 77%, 75%, và 57%, tương ứng. Biết rằng 26 hộ gia đình báo cáo thực tế sử dụng nước máy.

Số liệu điền vào bảng dưới đây là:

Số liệu từ nhà máy nước	Báo cáo từ HGD về sử dụng nước máy		
	Có	Không	Tổng
Sử dụng nước máy	a	B	
Không sử dụng nước máy	c	D	
Tổng			

- A. a/b/c/d: 20/44/6/15
- B. a/b/c/d: 6/15/20/44
- C. a/b/c/d: 20/15/6/44
- D. a/b/c/d: 6/44/20/15

[
]

Ca bệnh được xác định trong một nghiên cứu dựa vào tiền sử có mắc bệnh đó không? Đây là ví dụ về định nghĩa ca bệnh dựa trên tiêu chuẩn là tiêu chuẩn về:

- A. Căn nguyên
- B. Sinh thái học

C. Biểu hiện lâm sàng

D. Nguyên nhân

[
]

(**Case study** - trả lời các câu hỏi {<1>} đến {<2>}) Sử dụng số liệu trong bảng 1 của bài báo Ung thư não và nguồn nước uống (Brain Cancer and drinking water source) (phụ lục 1).

Bảng 1. Đặc trưng của nhóm bệnh-chứng trong nghiên cứu bệnh-chứng của ung thư não và nước uống ở Iowa trong những năm 1980 (nguồn nước uống được xác định chắc chắn ở ít nhất 70% thời gian sống)

Đặc điểm	Nhóm bệnh		Nhóm chứng		OR	95%CI
	n	%	n	%		
Tuổi:						
40-54	72	24,7	189	9,5		
55-64	81	27,8	441	22,2		
65-74	99	34,0	738	37,2		
75-84	30	13,4	615	31,0		
Giới tính						
Nam	155	53,3	1308	66,0		
Nữ	136	46,7	675	34,0		
Tham gia của nhóm đại diện						
Có	81	27,8	1982	66,0		
Không	210	72,2	1	0,1		
Dân số trung bình (nghìn)						
≤2.50	112	38,5	780	39,3	1,0	
2.51-10.00	81	27,8	528	26,6	0,9	0,7-1,3
10.01-50.00	66	22,7	429	21,6	0,9	0,7-1,3
≥50.01	32	11,0	246	12,4	0,7	0,5-1,1
Nghề nông						
Không	206	70,8	1355	68,3	1,0	
Có	85	29,2	628	31,7	1,5	1,1-2,1

*OR được tính toán sử dụng hồi quy tuyến tính, với hiệu chỉnh cho tuổi (theo nhóm) và giới

(<1>)Nguyên cơ qui mắc ung thư não trong quần thể do làm nghề nông là:

- A. 33%
- B. 57%
- C. 10%
- D. 29%

(<2>) Bảng 1 trình bày tỉ suất chênh hiệu chỉnh ước tính nguy cơ của ung thư não theo kích cỡ quần thể. Sử dụng cỡ dân số < 25,000 làm nhóm so sánh, tỉ suất chênh thô ở nhóm quần thể có dân số > 50,100 dân là:

- A. 0.7
- B. 0.8
- C. 0.9
- D. 1

[
]

(Case study - trả lời các câu hỏi {<1>} đến {<2>}) Dựa vào bảng số 3 của bài báo Ung thư não và nguồn nước uống (Brain Cancer and drinking water source) (phụ lục 1).

Bảng 3. Tỷ suất chênh OR và 95% CI cho tỷ lệ mới mắc ung thư não trong nghiên cứu bệnh chứng được thực hiện trong những năm 1980, theo thời gian cư trú với nguồn nước bề mặt khử Clo và trung bình thời gian cuộc đời tập trung THM*

	Nam		Nữ		Tổng	
	OR	95%CI	OR	95%CI	OR	95%CI
Clo nước bề mặt (năm)						
0	1,0	--	1,0	--	1,0	--
	(92,875)		(78,400)			
1-19	1,3	0,8-2,1	1,0	0,6-1,6	1,1	0,8-1,6
	(36,268)		(36-160)			
20-39	1,7	0,9-3,3	1,6	0,8-3,0	1,6	1,0-2,6
	(14,84)		(15,55)			
≥40	2,5	1,2-5,0	0,7	0,3-1,8	1,3	0,8-2,3
	(13,81)		(7,60)			
P	0,04		0,4		0,1	

Vòng đời trung bình THM tập trung ($\mu\text{g/l}$)						
$\leq 0,7$	1,0		1,0		1,0	
	(58,501)		(41,194)			
0,8-2,2	0,9	0,6-1,6	0,9	0,5-1,5	0,9	0,6-1,3
	(35-314)		(36,181)			
2,3-32,5	1,0	0,6-1,8	0,8	0,5-1,5	0,9	0,6-1,4
	(45-382)		(43,213)			
$\geq 32,6$	1,4	0,7-2,9	0,9	0,4-1,8	1,1	0,7-1,8
	(17-111)		(16,87)			
P	0,04		0,9		0,3	

*Từ mô hình hồi quy tuyến tính hiệu chỉnh cho giới tính, tuổi (phân tầng), nghề nông, và trung bình thời gian cuộc đời của kích thước quần thể cư trú tại thị trấn và thành phố.

(<1>) Tỷ suất chênh về khoảng thời gian phơi nhiễm với clo của nước bề mặt liên quan với ung thư não được trình bày. Tỷ suất chênh và 95% khoảng tin cậy của tỷ suất chênh được phân tích cho nhóm nam giới có thời gian phơi nhiễm với clo nước bề mặt từ 1-19 năm và nhóm nam giới phơi nhiễm ≥ 40 năm là 1.3 (0.8, 2.1) và 2.5 (1.2, 5.0) tương ứng.

Nhận định mô tả phù hợp nhất về vai trò của may rủi trong hai kết quả trên là:

A. OR của nhóm nam phơi nhiễm ≥ 40 năm có nhiều khả năng được ước lượng do may rủi vì nó được tính toán từ ít ca bệnh và chứng hơn.

B. OR của nhóm nam phơi nhiễm từ 1-19 năm có khả năng được ước lượng do may rủi bởi vì ước lượng điểm của OR gần giả thuyết Ho (gần giá trị 1).

C. OR của nhóm nam phơi nhiễm ≥ 40 năm có nhiều khả năng được ước lượng do may rủi vì khoảng tin cậy rộng.

D. OR của nhóm nam phơi nhiễm ≥ 40 năm ít có khả năng được ước lượng do may rủi vì khoảng tin cậy không chứa 1.

[
]

(<2>) Tỷ suất chênh với các mức độ phơi nhiễm khác nhau với Trihalomethane (TMH) liên quan tới ung thư não. Tỷ suất chênh và khoảng tin cậy đối với phơi nhiễm với TMH trong suốt vòng đời ở nồng độ 0.8-2.2 $\mu\text{g/l}$ trong nam giới là 0.9 (0.6, 1.6). Tỷ suất chênh và khoảng tin cậy đối với phơi nhiễm với TMH trong suốt vòng đời ở nồng độ ≥ 32.6 $\mu\text{g/l}$ trong nữ giới là 0.9 (0.4, 1.8).

Nhận định phù hợp nhất với hai ước lượng về tỷ suất chênh này là:

- A. Các giá trị OR ở hai nhóm là bằng nhau vì ước lượng điểm OR bằng nhau.
 B. Các giá trị OR ở hai nhóm bằng nhau vì khoảng tin cậy tương ứng đều không chứa 1.
 C. Ước lượng OR ở nhóm nam chính xác hơn vì khoảng tin cậy hẹp hơn.
 D. Ước lượng OR ở nhóm nữ chính xác hơn vì mức độ phơi nhiễm cao hơn.\
- [
]

Case study - Sử dụng số liệu bảng 4 của bài báo Ung thư não và nguồn nước uống (Phụ lục 1)

Bảng 4. Tỷ suất chênh OR và 95%CI cho tỷ suất mới mắc ung thư não trong nghiên cứu bệnh chứng thực tiễn ở Iowa trong những năm 80, theo thời gian cư trú với nguồn nước bề mặt Clo và theo mức độ nước máy*

Nước bề mặt khử Clo (năm)	Nam		Nữ		Tổng	
	OR	95%CI	OR	95%CI	OR	95%CI
>TB lượng nước máy						
0	1,0 (30,423)	--	1,0 (35,199)	--	1,0	--
1-19	1,3 (16,139)	0,7-2,7	1,3 (20,71)	0,6-2,5	1,3	0,8-2,0
20-39	1,8 (5,43)	0,6-5,1	1,1 (6,30)	0,4-3,1	1,4	0,7-2,9
≥40	4,0 (7,38)	1,5-10,8	0,6 (3,28)	0,2-2,1	1,6	0,7-3,4
p	0,03		1,0		0,09	
<TB lượng nước máy						
0	1,0 (45-437)	--	1,0 (39-191)	--	1,0	--
1-19	1,0 (15,124)	0,5-2,1	0,8 (14-83)	0,4-1,6	0,0	0,5-1,5
20-39	0,8 (5,41)	0,3-2,4	2,1 (8-23)	0,8-5,5	1,4	0,7-2,8
≥40	1,5 (5,42)	0,5-4,6	0,8 (4,31)	0,3-2,7	1,1	0,5-2,5

p	0,9	0,5	0,6
*Từ mô hình hồi quy tuyến tính hiệu chỉnh cho giới tính, tuổi (phân tầng), nghề nông, và trung bình thời gian cuộc đời của kích thước quần thể cư trú tại thị trấn và thành phố Giá trị phản ánh đúng nhất tỉ suất chênh thô ước lượng nguy cơ mắc ung thư não của nhóm phơi nhiễm với clo nước bề mặt ≥ 40 năm trong nam giới thuộc nhóm sử dụng nước trên mức trung vị là (nhóm so sánh là nhóm không có thời gian phơi nhiễm với clo nước bề mặt). A. 4.0 B. 1.5 C. 3.6 <u>D. 2.6</u> [
] Case study - Trong nghiên cứu Ung thư não và nguồn nước uống (Phụ lục 1) tác giả chỉ ra rằng “ có sự liên quan đáp ứng liều giữa khoảng thời gian phơi nhiễm với clo nước bề mặt qua đường nước uống với ung thư não”. Sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán căn nguyên của Bradford Hill criteria để lập luận về mối quan hệ nhân quả trong nghiên cứu này có thể đưa ra là: <u>A.</u> Chưa đủ bằng chứng về quan hệ nhân quả vì các tiêu chuẩn của Bradford and Hill chưa chắc chắn. B. Đủ bằng chứng để lập luận về mối quan hệ nhân quả trong nghiên cứu này vì mức độ kết hợp giữa phơi nhiễm clor nước bề mặt và ung thư não ở mức độ trung (OR=1.7 ở nhóm phơi nhiễm từ 20-39 năm; OR=2.5 ở mức độ phơi nhiễm ≥ 40 năm (strength) C. Đủ bằng chứng để lập luận về mối quan hệ nhân quả trong nghiên cứu này vì ung thư não là một hậu quả diễn ra kéo dài và có thời gian ủ bệnh, vì vậy việc khai thác tiền sử phơi nhiễm clo qua sử dụng nước máy uống sẽ có những sai số nhớ lại nhất định vì sẽ không phân định được phơi nhiễm đó là có trước hay sau khi bị bệnh (temporality) D. Chưa có bằng chứng khoa học về cơ chế liên quan giữa clo và ung thư não (plausibility) [
] (Case study - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<5>}) Một nghiên cứu tương quan/ sinh thái học giữa nước uống và ung thư não đã được triển khai bởi tác giả thứ nhất của bài báo (Phụ lục 1). Trong nghiên cứu đó tỉ lệ tử vong do ung thư não trong 923 địa phận của Mỹ được so sánh với hàm lượng THM được đo trong nước uống cung cấp cho từng địa phận tương ứng. Đối với những địa phận mà các mẫu nước được lấy từ nguồn nước phục vụ cho ít nhất 85% dân số của địa bàn, hệ số tương quan giữa tỉ lệ tử vong do ung thư não và nồng độ THM là 0.24 ở nhóm nam da trắng và 0.19 ở nhóm nữ da trắng. (<1>) Với kết quả này, đồng nghiệp của bạn kết luận rằng THM trong nước uống có liên quan nhân quả với ung thư não. Tuy nhiên, bạn thì cẩn trọng hơn			

trong việc phiên giải kết quả từ nghiên cứu này với lý do đây là một nghiên cứu sinh thái học.

Định nghĩa nghiên cứu tương quan/sinh thái học là:

A. Nghiên cứu tương quan là nghiên cứu quát sát mô tả mối tương quan giữa hai biến số mà trong y học thường là giữa yếu tố nguy cơ và hậu quả sức khỏe sử dụng số liệu của quần thể (aggregated data)

B. Nghiên cứu tương quan là nghiên cứu quát sát mô tả mối tương quan giữa hai biến số mà trong y học thường là 2 yếu tố độc lập không có mối quan hệ nguy cơ và hậu quả sức khỏe sử dụng số liệu của quần thể (aggregated data)

C. Nghiên cứu tương quan là nghiên cứu quát sát mô tả mối tương quan giữa hai biến số mà trong y học thường là giữa yếu tố nguy cơ và hậu quả sức khỏe sử dụng số liệu của 1 nhóm cá thể của quần thể (aggregated data)

D. Nghiên cứu tương quan là nghiên cứu quát sát mô tả mối tương quan giữa hai biến số mà trong y học thường là 2 yếu tố độc lập không có mối quan hệ nguy cơ và hậu quả sức khỏe sử dụng số liệu của 1 nhóm cá thể của quần thể (aggregated data)

(<2>) Những hạn chế của thiết kế nghiên cứu này làm bạn cần cẩn trọng khi phiên giải về mối liên quan nhân quả là:

A. Trong nghiên cứu này có thể có những cá thể sống trong khu vực mà nguồn nước có nồng độ THM cao nhưng chưa chắc cá thể đó đã sử dụng nguồn nước của địa bàn đó.

B. Trong nghiên cứu này có thể những cá thể sống trong khu vực mà nguồn nước có nồng độ THM cao nhưng chưa chắc cá thể đó đã báo cáo sử dụng nguồn nước của địa bàn đó.

C. Trong nghiên cứu này có thể có những cá thể sống trong khu vực mà nguồn nước có nồng độ THM cao nhưng chưa chắc cá thể đó đã báo cáo là đã sử dụng nguồn nước của địa bàn đó.

D. Số liệu về phơi nhiễm THM trong nguồn nước của quần thể để ước lượng cho phơi nhiễm của cá thể giúp nhận định được kết quả thích hợp.

(<3>) Trong nghiên cứu này các tác giả đã sử dụng thông tin do nhóm bệnh và nhóm chứng cung cấp về loại nguồn nước chính sử dụng, nước máy và khối lượng nước họ tiêu thụ để tính ra được mức độ phơi nhiễm tích lũy với THMU trong cuộc đời. Tuy nhiên lịch sử tự nhiên của ung thư não gồm thời điểm biểu hiện bệnh, phát triển, thay đổi, tiến triển bệnh diễn ra trong nhiều năm. Vì vậy việc phơi nhiễm THM trong quá khứ sẽ quan trọng hơn việc phơi nhiễm gần đây. Theo bạn, giai đoạn quan trọng để xác định được độ dài tối đa và tối thiểu từ khi phơi nhiễm tới khi có chẩn đoán lần đầu về mắc bệnh là:

A. Giai đoạn ủ bệnh

B. Tử vong của các ca bệnh sau 1 năm

C. Giai đoạn kéo dài từ khi phơi nhiễm đến khi có biểu hiện bệnh

D. Cả A và C

(<4>) Trong nghiên cứu này tác giả chọn ca bệnh là tất cả các loại ung thư não. Nếu tác giả đặt giả thuyết rằng phơi nhiễm THM chỉ có liên quan tới một số loại ung thư não nhất định. Chiến lược phân tích nên được lựa chọn là:

A. Hiệu chỉnh theo loại ung thư não sử dụng mô hình toán học.

B. Phân tích theo tầng (theo loại ung thư)

C. Chuẩn hóa trực tiếp theo loại ung thư.

D. Chuẩn hóa gián tiếp theo loại ung thư.

(<5>) Tác giả đã giới hạn phân tích trong phạm vi nhóm bệnh và nhóm chứng là những cá thể có ít nhất 70% thời gian sống sử dụng một loại nguồn nước uống nhất định. Cách tiếp cận này đã hạn chế được loại sai số tốt nhất là:

A. Yếu tố nhiễu

B. Sai lệch lựa chọn

C. Sai số thông tin

D. Sai số ngẫu nhiên

[
]

(**Case study** - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<5>}) Sử dụng bảng số liệu số 3 trong bài báo Ung thư não và nguồn nước uống (Phụ lục 1)

Bảng 3. Tỷ suất chên OR và 95% CI cho tỷ lệ mới mắc ung thư não trong nghiên cứu bệnh chứng được thực hiện trong những năm 1980, theo thời gian cư trú với nguồn nước bề mặt khử Clo và trung bình thời gian cuộc đời tập trung THM*

	Nam		Nữ		Tổng	
	OR	95%CI	OR	95%CI	OR	95%CI
Clo nước bề mặt (năm)						
0	1,0	--	1,0	--	1,0	--
	(92,875)		(78,400)			
1-19	1,3	0,8-2,1	1,0	0,6-1,6	1,1	0,8-1,6
	(36,268)		(36-160)			
20-39	1,7	0,9-3,3	1,6	0,8-3,0	1,6	1,0-2,6
	(14,84)		(15,55)			
≥40	2,5	1,2-5,0	0,7	0,3-1,8	1,3	0,8-2,3
	(13,81)		(7,60)			

p	0,04		0,4		0,1	
Vòng đời trung bình THM tập trung (µg/l)						
≤0,7	1,0		1,0		1,0	
	(58,501)		(41,194)			
0,8-2,2	0,9	0,6-1,6	0,9	0,5-1,5	0,9	0,6-1,3
	(35-314)		(36,181)			
2,3-32,5	1,0	0,6-1,8	0,8	0,5-1,5	0,9	0,6-1,4
	(45-382)		(43,213)			
≥32,6	1,4	0,7-2,9	0,9	0,4-1,8	1,1	0,7-1,8
	(17-111)		(16,87)			
p	0,04		0,9		0,3	

*Từ mô hình hồi quy tuyến tính hiệu chỉnh cho giới tính, tuổi (phân tầng), nghề nông, và trung bình thời gian cuộc đời của kích thước quần thể cư trú tại thị trấn và thành phố.

(<1>) Số liệu điền vào bảng 2x2 về kết hợp giữa ung thư não với ≥40 năm sử dụng nguồn nước có THM tính chung cho cả hai giới là:

	≥40 năm	Không phơi nhiễm	Total
Bệnh	a	b	
Chứng	c	d	
Tổng			

A. a/b/c/d: 20/1275/141/170

B. a/b/c/d: 20/170/141/1275

C. a/b/c/d: 141 /170/20/1275

D. a/b/c/d: 141/1275/20/170

(<2>) Tỷ suất chênh về phơi nhiễm với THM giữa nhóm ung thư não và không ung thư não cho cả hai giới là:

A. 1.1

B. 1.2

C. 1.3

D. 1.4

(<3>) Giả sử rằng tỉ suất chênh hiệu chỉnh theo giới cho mối liên quan giữa thâm niên ≥ 40 năm phơi nhiễm với clor nước bề mặt và ung thư não là 1.1 thì Giới là:

A. Yếu tố nhiều

B. Không phải yếu tố nhiều

C. Chưa đủ dữ liệu để kết luận Giới là yếu tố nhiều

D. Có thể có, có thể không là yếu tố nhiều

(<4>) Giới tính có phải là yếu tố tương tác với phơi nhiễm clor nước bề mặt làm tăng nguy cơ mắc ung thư não trong nghiên cứu này không?

A. Không vì khoảng tin cậy không trùng nhau

B. Không vì OR ở nam là 2.5 và ở nữ là 0.7

C. Không vì Ước lượng điểm về OR của từng giới không nằm trong khoảng tin cậy của giới kia

D. Cả 3 ý trên đều đúng

(<5>) Theo số liệu ở bảng số 1

Bảng 1. Đặc trưng của nhóm bệnh-chứng trong nghiên cứu bệnh-chứng của ung thư não và nước uống ở Iowa trong những năm 1980 (nguồn nước uống được xác định chắc chắn ở ít nhất 70% thời gian sống)

Đặc điểm	Nhóm bệnh		Nhóm chứng		OR	95%CI
	n	%	n	%		
Tuổi:						
40-54	72	24,7	189	9,5		
55-64	81	27,8	441	22,2		
65-74	99	34,0	738	37,2		
75-84	30	13,4	615	31,0		
Giới tính						
Nam	155	53,3	1308	66,0		
Nữ	136	46,7	675	34,0		
Tham gia của nhóm đại diện						
Có	81	27,8	1982	66,0		
Không	210	72,2	1	0,1		
Dân số trung bình (nghìn)						
≤2.50	112	38,5	780	39,3	1,0	

2.51-10.00	81	27,8	528	26,6	0,9	0,7-1,3
10.01-50.00	66	22,7	429	21,6	0,9	0,7-1,3
≥50.01	32	11,0	246	12,4	0,7	0,5-1,1
Nghề nông						
Không	206	70,8	1355	68,3	1,0	
Có	85	29,2	628	31,7	1,5	1,1-2,1

*OR được tính toán sử dụng hồi quy tuyến tính, với hiệu chỉnh cho tuổi (theo nhóm) và giới

Theo số liệu bảng 1, người làm nghề nông là yếu tố nguy cơ của ung thư não (OR=1.5). Giả định rằng trong nhóm chứng, nghề nông có sự kết hợp với thời gian phơi nhiễm với clor nước bề mặt. Liệu rằng nghề nghiệp có phải là yếu tố nhiễu của kết hợp được báo cáo trong cột tổng của bảng số 3 không? Tại sao?

- A. Có vì OR ở bảng số 3 đã hiệu chỉnh theo nghề nghiệp
 B. Có vì OR ở bảng số 3 chưa hiệu chỉnh theo nghề nghiệp
 C. Không vì OR ở bảng số 3 đã hiệu chỉnh theo nghề nghiệp
 D. Không vì OR ở bảng số 3 chưa hiệu chỉnh theo nghề nghiệp

(**Case study** - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<3>}) Sử dụng số liệu trong bảng 1

Bảng 1. Đặc trưng của nhóm bệnh-chứng trong nghiên cứu bệnh-chứng của ung thư não và nước uống ở Iowa trong những năm 1980 (nguồn nước uống được xác định chắc chắn ở ít nhất 70% thời gian sống)

Đặc điểm	Nhóm bệnh		Nhóm chứng		OR	95%CI
	n	%	n	%		
Tuổi:						
40-54	72	24,7	189	9,5		
55-64	81	27,8	441	22,2		
65-74	99	34,0	738	37,2		
75-84	30	13,4	615	31,0		
Giới tính						
Nam	155	53,3	1308	66,0		

Nữ	136	46,7	675	34,0		
Tham gia của nhóm đại diện						
Có	81	27,8	1982	66,0		
Không	210	72,2	1	0,1		
Dân số trung bình (nghìn)						
≤2.50	112	38,5	780	39,3	1,0	
2.51-10.00	81	27,8	528	26,6	0,9	0,7-1,3
10.01-50.00	66	22,7	429	21,6	0,9	0,7-1,3
≥50.01	32	11,0	246	12,4	0,7	0,5-1,1
Nghề nông						
Không	206	70,8	1355	68,3	1,0	
Có	85	29,2	628	31,7	1,5	1,1-2,1

*OR được tính toán sử dụng hồi quy tuyến tính, với hiệu chỉnh cho tuổi (theo nhóm) và giới

(<1>) Tỷ suất chênh OR thô giữa nhóm nghề với nguy cơ ung thư não là:

Nghề nông	Bệnh	Chứng
Có	85	628
Không	206	1355

- A. OR thô= 0.89. Không có sự kết hợp giữa nghề nghiệp và ung thư não
 B. OR thô= 0.89. Có sự kết hợp giữa nghề nghiệp và ung thư não
 C. OR thô = 0.19. Không có sự kết hợp giữa nghề nghiệp và ung thư não
 D. OR thô = 0.19. Có sự kết hợp giữa nghề nghiệp và ung thư não

(<2>) Giả sử rằng 10% ca bệnh ở nhóm báo cáo không làm nghề nông thực chất là có làm nghề nông và 15% đối tượng ở nhóm chứng mặc dù báo cáo là làm nghề nông nhưng thực tế lại chưa bao giờ làm nghề nông. Đo lường kết hợp thực giữa nghề nông và ung thư não là (Giả định việc xếp loại bệnh tật không mắc sai số):

- A. OR = 1.4
 B. OR =1.6
 C. OR = 4.8
 D. OR = 2.9

(<3>) So sánh OR của câu <1> và câu <2>, sự khác biệt đó có thể do :

- A. Là do sự xếp lần khác biệt về phơi nhiễm.
- B. Là do sự xếp lần không khác biệt về phơi nhiễm.
- C. Là do sự xếp lần khác biệt về bệnh
- D. Là do sự xếp lần không khác biệt về bệnh

[
]

Chỉ số đo lường tính giá trị của phương pháp được sử dụng để xếp loại phơi nhiễm ví dụ như xác định nghề nghiệp trong bài báo Ung thư não và nguồn nước uống (Phụ lục 1) là:

- A. interclass correlation coefficient
- B. kappa statistic
- C. standard error
- D. sensitivity

[
]

(Case study - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<2>}) Dựa vào số liệu ở bảng 1 trong bài báo Ung thư não và nguồn nước uống (Phụ lục 1)

Bảng 1. Đặc trưng của nhóm bệnh-chứng trong nghiên cứu bệnh-chứng của ung thư não và nước uống ở Iowa trong những năm 1980 (nguồn nước uống được xác định chắc chắn ở ít nhất 70% thời gian sống)

Đặc điểm	Nhóm bệnh		Nhóm chứng		OR	95%CI
	n	%	n	%		
Tuổi:						
40-54	72	24,7	189	9,5		
55-64	81	27,8	441	22,2		
65-74	99	34,0	738	37,2		
75-84	30	13,4	615	31,0		
Giới tính						
Nam	155	53,3	1308	66,0		
Nữ	136	46,7	675	34,0		
Tham gia của nhóm đại diện						
Có	81	27,8	1982	66,0		
Không	210	72,2	1	0,1		
Dân số trung bình (nghìn)						
≤2.50	112	38,5	780	39,3	1,0	

2.51-10.00	81	27,8	528	26,6	0,9	0,7-1,3
10.01-50.00	66	22,7	429	21,6	0,9	0,7-1,3
≥50.01	32	11,0	246	12,4	0,7	0,5-1,1
Nghề nông						
Không	206	70,8	1355	68,3	1,0	
Có	85	29,2	628	31,7	1,5	1,1-2,1

*OR được tính toán sử dụng hồi quy tuyến tính, với hiệu chỉnh cho tuổi (theo nhóm) và giới

(<1>) Đánh giá rằng OR thô của kết hợp giữa nghề nghiệp và ung thư não có bị nhiễu bởi yếu tố tuổi và giới không:

- A. Có vì OR thô và OR hiệu chỉnh bằng nhau
- B. Có. vì OR thô =0.89 và OR hiệu chỉnh =1.5
- C. Không. vì OR thô =0.89 và OR hiệu chỉnh =1.5
- D. Không. vì OR thô và OR hiệu chỉnh bằng nhau

(<2>) Đặc điểm trong thiết kế nghiên cứu có thể làm cho OR thô trong bảng 1 bị nhiễu bởi yếu tố tuổi/giới là:

A. Nhóm chứng không được ghép cặp với nhóm bệnh theo tuổi và giới nên nhóm chứng đã không được chọn ngẫu nhiên vì vậy phân tích cần kiểm soát được yếu tố ghép cặp này.

B. Nhóm chứng được ghép cặp với nhóm bệnh theo tuổi nhưng không theo giới nên nhóm chứng đã không được chọn ngẫu nhiên vì vậy phân tích cần kiểm soát được yếu tố ghép cặp này.

C. Nhóm chứng được ghép cặp với nhóm bệnh theo giới nhưng không theo tuổi nên nhóm chứng đã không được chọn ngẫu nhiên vì vậy phân tích cần kiểm soát được yếu tố ghép cặp này.

D. Nhóm chứng được ghép cặp với nhóm bệnh theo tuổi và giới nên nhóm chứng đã không được chọn ngẫu nhiên vì vậy phân tích cần kiểm soát được yếu tố ghép cặp này.

[
]

Hai tiêu chuẩn chính trong lựa chọn ca bệnh là:

- A. Tiêu chuẩn về lâm sàng và căn nguyên
- B. Tiêu chuẩn về cận lâm sàng và căn nguyên
- C. Tiêu chuẩn về lâm sàng và cận lâm sàng
- D. Tiêu chuẩn về cận lâm sàng và thời gian ủ bệnh

[
]

Đặc điểm mô tả tốt nhất sự khác biệt giữa nghiên cứu thuần tập lồng ghép bệnh chứng (nested case control) và nghiên cứu thuần tập dựa vào ca bệnh (case cohort study) là:

- A. Cả hai thiết kế đều lựa chọn nhóm chứng từ nhóm quần thể ban đầu được theo dõi theo thời gian nhưng nghiên cứu case cohort lựa chọn nhóm chứng một cách ngẫu nhiên
- B. Cả hai thiết kế đều lựa chọn nhóm chứng từ nhóm quần thể ban đầu được theo dõi theo thời gian nhưng nghiên cứu case cohort lựa chọn nhóm chứng bằng cách ghép cặp với nhóm chủ cứu
- C. Trong nghiên cứu case-cohort, nhóm chứng không được lựa chọn bằng cách ghép cặp với nhóm chủ cứu.
- D. Trong nghiên cứu nested case control, nhóm chủ cứu được lựa chọn từ nhóm thuần tập không phơi nhiễm.

[
]

Một thành phần KHÔNG thuộc 3 thành phần chính trong công thức tính tỉ suất mới mắc là:

- A. Số mới mắc
- B. Quần thể có nguy cơ
- C. Quần thể phơi nhiễm
- D. Khoảng thời gian

[
]

Case study - Trong khoảng thời gian 10 năm, số ca mắc chấn thương do đạp xe tăng mặc dù tỉ lệ chấn thương do đạp xe hiệu chỉnh theo tuổi trong quần thể giảm (giả định rằng nguy cơ về chấn thương do đạp xe và chất lượng thông tin thu được không thay đổi trong vòng 10 năm đó).

(<1>) Lý do KHÔNG phải là giải thích phù hợp cho sự thay đổi về số liệu chấn thương nói trên là:

- A. Kích cỡ quần thể sau 10 có thể tăng (dân số trẻ hóa do tỉ lệ sinh cao hơn tỉ lệ tử vong, hoặc nhập cư của các gia đình có con nhỏ và di cư của các gia đình có con lớn tuổi)
- B. Cấu trúc nhóm tuổi trong quần thể thay đổi theo thời gian
- C. Kinh tế xã hội phát triển và nguy cơ chấn thương trong giao thông tăng
- D. Nhóm trẻ em trong quần thể có nguy cơ chấn thương cao hơn

[
]

Điều kiện nào dưới đây thích hợp cho việc sử dụng tỉ suất chênh OR để ước lượng nguy cơ tương đối RR.

- A. Số mới mắc trong một quần thể có nguy cơ được xác định
- B. Nhóm chứng đại diện cho các cá thể trong quần thể mà từ đó có các ca bệnh được phát hiện.
- C. Vấn đề nghiên cứu là hiếm trong quần thể.

D. Vấn đề nghiên cứu là phổ biến trong quần thể

[
]

Case study - Mối liên quan giữa nạo thai bắt buộc và ung thư vú được nhiều nghiên cứu dịch tễ học trước đây đề cập. Các nghiên cứu thuần tập đã không tìm thấy sự kết hợp trong khi đó một nghiên cứu bệnh chứng đã tìm thấy sự kết hợp.

(<1>) Giải thích phù hợp nhất về sự khác biệt kết quả giữa hai loại thiết kế này là:

A. Nghiên cứu bệnh chứng bị mắc phải sai số lựa chọn trong khi nghiên cứu thuần tập không bị mắc sai số này

B. Sai số nhớ lại có thể gặp trong nghiên cứu bệnh chứng trong khi nghiên cứu thuần tập không mắc sai số này.

C. Phương pháp xác định ca bệnh trong nghiên cứu bệnh chứng là khác biệt so với lựa chọn ca bệnh trong nghiên cứu thuần tập.

D. Sai số bỏ cuộc trong nghiên cứu thuần tập gây ra sự khác biệt này

[
]

Case study - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<3>}) Swaen và cộng sự đã tiến hành một nghiên cứu năm 1998 trên 6,803 nam giới làm việc ít nhất 6 tháng trước ngày 1/1/1980 tại một trong 9 nhà máy hóa chất ở Hà Lan. Những người đàn ông này được theo dõi về tử vong trong khoảng thời gian từ 1/1/56 đến 1/1/96. Trước ngày 1/1/80 có 2,842 người lao động đã làm việc trong môi trường có phơi nhiễm với acrylonitrile và 3,961 nam công nhân còn lại không bị phơi nhiễm. Từ ngày 1/1/80, môi trường lao động không còn tồn tại acrylonitrile nữa. Để đo lường mối kết hợp giữa phơi nhiễm nghề nghiệp với acrylonitrile và các hậu quả sức khỏe, nhà nghiên cứu đã tính tỉ số tử vong chuẩn hóa cho cả nhóm phơi nhiễm và nhóm không phơi nhiễm. Thời gian theo dõi năm người được tính cho từng nhóm tuổi và được nhân với tỉ lệ tử vong của nam giới trong quần thể để tính ra số tử vong của nam giới ở Hà Lan tiếp xúc với acrylonitrile. 290 trường hợp tử vong trong nhóm có phơi nhiễm và 983 trường hợp tử vong trong nhóm phơi nhiễm

(<1>) Loại thiết kế được sử dụng trong nghiên cứu này là:

A. Điều tra ngang

B. Nghiên cứu thuần tập hồi cứu

C. Nghiên cứu thuần tập tương lai

D. Nghiên cứu bệnh chứng

(<2>) Đối với hậu quả sức khỏe là ung thư não, tỉ lệ tử vong chuẩn hóa (SMR =173.9) ở nhóm phơi nhiễm cao hơn gấp 2 lần tỉ lệ này ở nhóm không phơi nhiễm. Lý do KHÔNG thích hợp cho việc lý giải cho việc 2 tỉ lệ này khi so sánh với nhau chỉ là tương đối là:

A. SMR là phương pháp chuẩn hóa gián tiếp mà ở đó SMR được tính bằng số ca tử vong xác định được trong mẫu nghiên cứu so với số ca tử vong mong đợi của quần thể chuẩn.

B. Cấu trúc tuổi của quần thể phơi nhiễm và quần thể không phơi nhiễm có thể khác nhau

C. Việc sử dụng tỉ lệ tử vong của quần thể chuẩn như là một hình thức so sánh trung gian

D. Việc sử dụng tỉ lệ tử vong của quần thể chuẩn làm thích ứng tuyệt đối trong so sánh 2 tỉ lệ

(<3>) Để có thể so sánh thích hợp được tỉ lệ tử vong ở nhóm phơi nhiễm và nhóm không phơi nhiễm trong nghiên cứu này, kỹ thuật phù hợp nhất là:

A. Sử dụng phương pháp chuẩn hóa trực tiếp

B. Sử dụng phương pháp chuẩn hóa gián tiếp

C. Kết hợp phương pháp chuẩn hóa trực tiếp và gián tiếp

D. Sử dụng phương pháp tính tổng thời gian phơi nhiễm của các cá thể và phương pháp chuẩn hóa trực tiếp

[
]

Case study - Một nhóm các chuyên gia đã rà soát hồ sơ bệnh án của 525 bệnh nhân ra viện với chẩn đoán đột quỵ theo mã ICD (430-438). Nhóm chuyên gia phân loại đột quỵ theo hai nhóm là có thiếu máu não (ICD-434) và đột quỵ khác (không phải ICD-434). Giả sử rằng việc phân loại này của nhóm chuyên gia là rất chính xác. Trong 525 ca tổng số, 325 ca được chẩn đoán trong hồ sơ là đột quỵ do thiếu máu não theo mã ICD-434. Trong số 325 ca này, nhóm chuyên gia xác định 85 xác định không phải đột quỵ ICD-434. Có 20 ca nhóm chuyên gia xác định là đột quỵ không thuộc mã ICD-434.

(<1>) Giá trị KHÔNG đúng với các giá trị của trắc nghiệm trên là:

A. Độ nhạy 92,3%

B. Độ đặc hiệu 68%

C. Giá trị dự đoán dương tính 73,8%

D. Giá trị dự đoán âm tính 5%

[
]

Đặc điểm KHÔNG được đề cập trong ứng dụng của Đường cong “response operating characteristic” gọi tắt là (ROC) là:

A. ROC thể hiện sự thỏa hiệp giữa độ nhạy và độ đặc hiệu

B. Khi đường cong càng nghiêng trái và mở rộng về phía trên thì test trắc nghiệm càng đạt tính giá trị cao.

C. Độ cong càng giảm và càng tiến về vị trí 45 độ thì giá trị trắc nghiệm càng giảm

D. Diện tích dưới đường cong càng nhỏ, tính giá trị trắc nghiệm càng cao

[
]

Case study - Nếu sử dụng code- 434 ghi nhận trong hồ sơ để xác định các ca bệnh đột quỵ do thiếu máu não có độ nhạy 99% nhưng độ đặc hiệu chỉ là 40%

(<1>) Điều này sẽ ảnh hưởng tới việc xác định nhóm có thiếu máu não thực sự là:

- A. Các ca đột quỵ do thiếu máu não sẽ đồng nhất hơn về mặt giải phẫu bệnh
- B. 60% ca đột quỵ không thuộc ICD-434 được chẩn đoán là đột quỵ do ICD-434
- C. Nhiều ca âm tính giả được chẩn đoán
- D. Các ca bệnh đại diện cho quần thể các bệnh nhân đột quỵ do ICD-434

[
]

Yếu tố KHÔNG ảnh hưởng tới giá trị dự đoán dương tính của một trắc nghiệm sàng tuyển là:

- A. Tỷ lệ hiện mắc của vấn đề sức khỏe cần sàng tuyển trong cộng đồng
- B. Độ đặc hiệu của trắc nghiệm
- C. Dương tính giả
- D. Độ nhạy

[
]

Case study - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<2>}) Một nghiên cứu tiền hành so sánh tỉ lệ đụng xe ô tô ở hai thành phố liên quan tới việc sử dụng điện thoại di động. Số liệu về sử dụng điện thoại di động và đụng xe ô tô được trình bày trong bảng số liệu dưới đây.

Sử dụng điện thoại di động	Thành phố A			Thành phố B		
	Số người	Số trường hợp tai nạn	Tỉ lệ	Số người	Số trường hợp tai nạn	Tỉ lệ
Thường xuyên	4479	293		100	2	
Vừa phải	974	27		300	6	
Không sử dụng	1106	15		8293	145	
Tổng	6559	335		8693	153	

* /1000 người

(<1>) Tỉ lệ thô tai nạn trên 1000 dân của hai thành phố A là:

- A. Thành phố A. 51,1/1000
- B. Thành phố A. 17,6/1000
- C. Thành phố A là 38.5/1000

D. Thành phố A là 32/1000

(<2>) Giả sử rằng tổng dân số của cả quần thể A và B là một quần thể chuẩn, sử dụng bảng số liệu trên, nhận định KHÔNG đúng là:

Quần thể A. $(4579 \times .0654) + (1274 \times .0277) + (9399 \times .0136)/15,252 = 29.9/1000$

Quần thể B. $(4579 \times .0200) + (1274 \times .0200) + (9399 \times .0178)/15,252 = 18.6/1000$

A. Tỷ lệ tử vong của nhóm tuổi nhỏ nhất trong quần thể A trong tổng số tử vong chuẩn hóa là 17,7%

B. Tỷ lệ tử vong chuẩn hóa của nhóm tuổi nhỏ nhất của quần thể A so với tổng số tử vong chuẩn hóa là 17,7%

C. Tỷ lệ tử vong chuẩn hóa của nhóm tuổi nhỏ nhất của cả hai quần thể so với tổng số tử vong chuẩn hóa là 17,7%

D. Các câu trên đều sai

[
]

Trong nghiên cứu can thiệp cộng đồng, hiệu quả truyền thông của chương trình can thiệp được đánh giá. Lựa chọn phù hợp trong. i) phân bổ nhóm nhận can thiệp; ii) thu thập thông tin trước và sau can thiệp; iii) phân tích hiệu quả truyền thông là:

A. Nhóm, cá thể, nhóm

B. Cá thể, nhóm, nhóm

C. Nhóm, nhóm, nhóm

D. Cá thể, cá thể, cá thể

[
]

[<g>] Đặc điểm của nghiên cứu thuần tập là [</g>]

Ưu điểm của thiết kế thuần tập so với nghiên cứu bệnh chứng là nghiên cứu thuần tập có thể ước lượng trực tiếp nguy cơ:

A. Đúng B. Sai

[
]

Một nhược điểm của nghiên cứu thuần tập so với nghiên cứu bệnh chứng là không đo lường được nhiều hậu quả đầu ra:

A. Đúng B. Sai

[
]

Một nhược điểm của nghiên cứu thuần tập là cần theo dõi một mẫu lớn nếu tỷ lệ mắc bệnh đó trong cộng đồng là thấp:

[
]

A. Đúng B. Sai

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng là một dạng đặc biệt của nghiên cứu thuần tập

A. Đúng B. Sai

[<g>] Đặc điểm của nghiên cứu mô tả là [</g>]

Nghiên cứu tương quan không dùng để kiểm định mối quan hệ nhân quả vì nó đo lường bệnh và phơi nhiễm tại cùng thời điểm:

A. Đúng B. Sai

[
]

Nghiên cứu tương quan tiến hành nhanh, ít tốn kém và cho phép so sánh giữa các quốc gia:

A. Đúng B. Sai

[
]

Báo cáo ca bệnh là một dạng của nghiên cứu mô tả có nhóm chứng:

A. Đúng B. Sai

[
]

Điều tra ngang có nhược điểm về hạn chế tính khái quát nhưng có khả năng đo lường nguy cơ tốt:

A. Đúng B. Sai

[<g>] Đặc điểm đo lường mối quan hệ nhân quả [</g>]

Khác biệt tuyệt đối về nguy cơ là hiệu số của hai tỉ suất mới mắc trong khi khác biệt tương đối về nguy cơ được xem là nguy cơ qui thuộc:

A. Đúng B. Sai

[
]

Hệ số tương quan đo lường mức độ tuyến tính giữa hai biến số. Do vậy sẽ là thích hợp sử dụng hệ số tương quan để đo lường độ mạnh của sự kết hợp giữa hai biến số:

A. Đúng B. Sai

[
]

Nguy cơ tương đối và tỉ suất chênh có thể được sử dụng xác định qui mô kết hợp giữa phơi nhiễm và hậu quả:

A. Đúng B. Sai

[
]

Nguy cơ qui thuộc phần trăm là một đo lường đánh giá bao nhiêu phần trăm trong nhóm có bệnh là do phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ. Nguy cơ qui thuộc được hiệu chỉnh theo tỉ lệ phơi nhiễm trong quần thể được gọi là ngu cơ qui thuộc quần thể:

A. Đúng B. Sai

[<g>] Đặc điểm của các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học [</g>]

Nghiên cứu bệnh chứng có nhiều ưu điểm phù hợp với bệnh hiếm gặp và những bệnh có thời gian ủ bệnh kéo dài hoặc kiểm định các yếu tố nguy cơ bà hậu quả:

A. Đúng B. Sai

[
]

Tỉ suất mật độ mới mắc hay còn gọi là tỉ lệ mới mắc tích lũy dùng để đo lường độ mạnh của sự kết hợp:

A. Đúng B. Sai

[
]

Nhóm chủ cứu và nhóm đối chứng trong nghiên cứu bệnh chứng phải được lựa chọn tương đồng nhau. Vì vậy cách chọn nhóm chứng tốt nhất là từ quần thể tổng quát:

A. Đúng B. Sai

[
]

Thông tin của nghiên cứu mô tả về ai mắc, ở đâu, khi nào giúp hiểu được lịch sử tự nhiên của bệnh:

A. Đúng B. Sai

[
]

Case study - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<2>}) Nguy cơ qui thuộc được đo lường nhằm đánh giá tác động của một phơi nhiễm có hại lên sức khỏe cộng đồng. Sử dụng số liệu trong một nghiên cứu thuần tập trong nghiên cứu dưới đây về liên quan giữa hoạt động thể chất và đột quỵ. Ước tính nguy cơ qui thuộc phần trong trong nhóm không hoạt động thể chất. Giả định rằng hoạt động thể chất và đột quỵ có mối liên quan nhân quả.

Mức độ hoạt động thể chất	Bị đột quỵ	Không bị đột quỵ	Năm người theo dõi (PY)	Số mới mắc /1,000 PY
Tích cực	45	5,955	43,200	
Không tích cực	135	13,865	100,800	
Tổng	180	19,820	144,000	

(<1>) Giải thích KHÔNG hợp lý về nguy cơ qui thuộc của hoạt động thể chất không tích cực tới đột quỵ là:

A. $ARP = (I1 - I0) / I1 = (RR - 1) / RR = 22\%$

B. Trong nhóm những người hoạt động thể chất không tích cực bị đột quỵ thì 22% là do không hoạt động thể chất tích cực

C. Nếu những người không hoạt động thể chất tích cực thực hiện hoạt động thể chất tích cực từ sớm trong cuộc đời của họ, nguy cơ đột quỵ của họ sẽ giảm được 22%

D. Trong nhóm những người hoạt động thể chất tích cực bị đột quỵ thì 22% là do không hoạt động thể chất tích cực

(<2>) Kết quả từ điều tra sức khỏe quốc gia cho thấy tỉ lệ người dân có hoạt động thể chất tích cực là 27%. Sử dụng cùng với số liệu ở bảng trên để ước tính nếu chương trình can thiệp nâng cao hoạt động thể chất trong cộng đồng được triển khai và kết quả là mọi người trong cộng đồng đều thực hành hoạt động thể chất tích cực thì sẽ giảm được % nguy cơ đột quỵ trong cộng đồng. (Biết rằng nguy cơ qui thuộc quần thể phần trăm (PARP)= $P(RR - 1) / P(RR - 1) + 1$; Trong đó p=tỉ lệ phơi nhiễm trong quần thể và RR=nguy cơ tương đối) là:

- A. Giảm 17%
- B. Giảm 18%
- C. Giảm 19%
- D. Giảm 20%

[
]

Case study - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<5>}) Năm 1998, các nhà nghiên cứu đặt giả thuyết rằng kĩ năng và khả năng giao tiếp của trẻ có liên quan với bệnh Alzheimer. Để kiểm định giả thuyết này, nhà nghiên cứu tiến hành đánh giá bài viết luận của 350 nữ tu sĩ thực hiện năm 1930 và dựa vào đó chia 350 nữ tu sĩ này thành nhóm có rối loạn kĩ năng giao tiếp (150) và nhóm không có rối loạn kĩ năng giao tiếp (200). Năm 1998, các nhà nghiên cứu sử dụng số liệu đăng ký sinh tử khai thác về tử vong và nguyên nhân tử vong của những tu sĩ này. Các số liệu của nghiên cứu được trình bày trong bảng dưới đây:

Nhóm có rối loạn kĩ năng giao tiếp			Nhóm không có rối loạn kĩ năng giao tiếp		
Nguyên nhân tử vong	Số tử vong	Năm tử vong	Nguyên nhân tử vong	Số tử vong	Năm tử vong
Alzheimer	2	1980	Alzheimer	1	1985
Alzheimer	5	1985	Alzheimer	3	1990
Alzheimer	6	1990	Alzheimer	4	1995
Alzheimer	5	1995	Tim mạch	8	1980
Tim mạch	10	1980	Tim mạch	10	1990
Tim mạch	15	1995	Bệnh khác	20	1960
Bệnh khác	25	1960	Bệnh khác	10	1970

Bệnh khác	30	1970			
-----------	----	------	--	--	--

(<1>) Nghiên cứu trên được thiết kế thuộc loại nghiên cứu:

- A. Thuần tập tiến cứu
- B. Thuần tập hồi cứu
- C. Thuần tập vừa tiến cứu vừa hồi cứu
- D. Thuần tập lồng ghép bệnh chứng

(<2>) Để tính tỉ suất mật độ mới mắc trong từng nhóm cần tính được tổng thời gian phơi nhiễm có nguy cơ. Tổng thời gian phơi nhiễm có nguy cơ dựa vào những số liệu dưới đây TRỪ:

- A. Năm bắt đầu theo dõi
- B. Năm xuất hiện tử vong
- C. Số ca tử vong ở các năm tương ứng
- D. Năm kết thúc phân tích số liệu

(<3>) Tỉ số về mật độ mới mắc Alzheimer ở nhóm có rối loạn kỹ năng giao tiếp và nhóm không rối loạn kỹ năng giao tiếp là:

- A. 2.24
- B. 0,651
- C. 3,4
- D. Không giá trị nào ở trên

(<4>) Sử dụng số liệu từ nghiên cứu này, tỉ suất chênh về kết hợp giữa rối loạn kỹ năng giao tiếp và bệnh Alzheimer là:

- A. 18
- B. 132
- C. 8
- D. 3.27

(<5>) So sánh giá trị tỉ số về mật độ mới mắc Alzheimer ở nhóm có rối loạn kỹ năng giao tiếp và nhóm không rối loạn kỹ năng giao tiếp được ở câu c với tỉ suất chênh tính được ở câu d thấy không có sự khác biệt nhiều. Giải thích về sự không khác biệt giữa hai giá trị này là:

- A. RR và OR gần bằng nhau vì tỉ lệ mắc Alzheimer thấp <10% trong cộng đồng
- B. RR và OR gần bằng nhau vì tỉ lệ mắc Alzheimer thấp $\geq 10\%$ trong cộng đồng
- C. OR là ước lượng gần đúng của RR vì tỉ lệ mắc Alzheimer thấp <10% trong cộng đồng
- D. A và C là giải thích phù hợp

[
]

Việc so sánh tỉ lệ tử vong giữa các khu vực thường dựa trên tỉ lệ tử vong chuẩn hóa theo tuổi trực tiếp. Phương pháp đề cập tới việc chuẩn hóa tỉ lệ tử vong theo nhóm tuổi theo phương pháp trực tiếp này là:

- A. Số sự kiện xảy ra trong mỗi nhóm tuổi của một quần thể chuẩn được sử dụng để tính toán được tỉ lệ chuẩn hóa cho quần thể nghiên cứu
- B. Tỉ suất sự kiện xảy ra trong mỗi nhóm tuổi của một quần thể chuẩn được sử dụng để tính toán được tỉ lệ chuẩn hóa cho quần thể nghiên cứu
- C. Tỉ suất sự kiện xảy ra trong mỗi nhóm tuổi của các quần thể nghiên cứu được sử dụng cùng với cấu trúc dân số của một quần thể chuẩn để tính ra được tỉ lệ chuẩn hóa cho các quần thể cần đem so sánh
- D. Tỉ suất sự kiện xảy ra trong mỗi nhóm tuổi của các quần thể nghiên cứu được sử dụng để so sánh với tỉ suất này của quần thể chuẩn

[
]

Tiêu chuẩn phù hợp nhất trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim là:

- A. Biểu hiện lâm sàng
- B. Tiêu chuẩn của Bradford
- C. Tiêu chuẩn căn nguyên
- D. Tiêu chuẩn nguyên nhân

[
]

Trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, lý do lý giải thích hợp cho việc phân bổ đối tượng ngẫu nhiên vào 2 nhóm chủ cứu và đối chứng là:

- A. Để tạo nên hai nhóm tương đồng nhau về cả yếu tố đã biết và chưa biết cho rằng có kết hợp với kết quả đầu ra.
- B. Giảm sai số phát sinh khi người bệnh biết được họ sẽ được nhận thuốc nào.
- C. Giảm sai số phát sinh khi nhà nghiên cứu biết được phân bổ can thiệp vào 2 nhóm
- D. Để giảm sai số ngẫu nhiên

[
]

[<g>] Đặc điểm của kỹ thuật chuẩn hóa gián tiếp [</g>]

Kỹ thuật chuẩn hóa gián tiếp sử dụng tỉ lệ tử vong chuyên biệt theo nhóm tuổi của một quần thể chuẩn:

- A. Đúng
- B. Sai

[
]

Tỉ số tử vong chuẩn hóa (SMR) là ví dụ của tỉ suất thô tính theo từng tầng:

- A. Đúng
- B. Sai

[
]

Tỉ số tử vong chuẩn hóa (SMR) được sử dụng để so sánh giữa các quần thể khác nhau:

- A. Đúng
- B. Sai

[
]

Kỹ thuật chuẩn hóa trực tiếp sử dụng tỉ trọng các nhóm tuổi của một quần thể chuẩn để chuẩn hóa:

A. Đúng B. Sai

[
]

(Case study - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<4>}) Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trên 242 bệnh nhân HIV dương tính và ở quý hai của giai đoạn thai kỳ về hiệu quả của AZT trong dự phòng lây nhiễm cho con trong quá trình sinh.

Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bảng dưới đây:

	AZT	Giả dược	Tổng
Tổng số trẻ sinh	121	121	242
Số trẻ không bị lây nhiễm	112	90	202
Số trẻ bị lây nhiễm	9	31	40
Tỉ lệ lây nhiễm (%)	7.4	25.6	16.5

(<1>) Thuật ngữ phù hợp nhất chỉ tỉ lệ lây nhiễm là:

- A. Tỉ lệ
- B. Tỉ suất tương đối
- C. Tỉ suất tuyệt đối
- D. Độ chênh

(<2>) Sử dụng số liệu trong bảng trên ước tính nguy cơ tương đối nhiễm HIV ở trẻ sinh ra từ mẹ được dùng AZT so với trẻ sinh ra từ mẹ không dùng AZT là:

- A. 0.29
- B. 0.3
- C. 0.31
- D. 0.32

(<3>) Dựa vào số liệu của bảng trên, tỉ lệ các trường hợp trẻ bị lây truyền HIV từ mẹ qua quá trình sinh có thể dự phòng được từ việc dùng AZT dự phòng được tính toán thích hợp là:

- A. $PF1 = 1 - RR = 1 - 0.29$
- B. $PF1 = 1 - RR = 1 - 0.74$
- C. $PF1 = 1 - RR = 1 - 0.256$
- D. $PF1 = 1 - RR = 1 - 0.30$

(<4>) Để đánh giá hiệu quả điều trị dự phòng này của AZT, trong một nghiên cứu bệnh chứng, nhà nghiên cứu đã lựa chọn nhóm bệnh và nhóm chứng. Cách chọn phù hợp nhất là:

A. Nhóm chủ cứu là những trẻ sinh ra nhiễm HIV; Nhóm chứng là trẻ sinh ra không nhiễm HIV.

B. Nhóm chủ cứu là những trẻ sinh ra nhiễm HIV; Nhóm chứng là trẻ không nhiễm HIV sinh ra từ những bà mẹ nhiễm HIV.

C. Nhóm chủ cứu là những trẻ sinh ra nhiễm HIV; nhóm chứng là những trẻ có mẹ nhiễm HIV nhưng không được nhận AZT.

D. Nhóm bệnh là trẻ nhiễm HIV có mẹ nhiễm HIV nhận điều trị AZT trước sinh, nhóm chứng là trẻ không nhiễm HIV có mẹ nhận AZT trước sinh.

[
]

(**Case study** - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<4>}) Một nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) và hành vi tình dục có nguy cơ cao trong 966 nam thanh niên trưởng thành tập trung tại một trung tâm giáo dục thanh niên. Nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn, khám, xét nghiệm và kết quả được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 1:

Biến số	Mean (SD)	range của giá trị min/max	Trung vị
Tuổi lần đầu tiên quan hệ tình dục	12.3 (2.0)	5-17	13
Số bạn tình từ trước đến thời điểm phỏng vấn	13.7 (16.8)	1-100	8
Số bạn tình trong vòng 4 tháng trở lại đây	2.9 (3.4)	0-30	2
Lần quan hệ tình dục gần đây nhất cách thời điểm phỏng vấn bao nhiêu tuần	5.8 (15.1)	1-260	2

SD = độ lệch chuẩn

Bảng 2. Phân bố kết quả xét nghiệm bệnh lây STD ở 966 nam thanh niên

Xét nghiệm	Số (+)/tổng số xét nghiệm
Syphilis	7/930
Gonorrhea	42/940
Chlamydia	66/957
1 trong 3 bệnh trên	109/908

(<1>) Thống kê mô tả nhạy cảm nhất với ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai là:

A. Trung bình (mean)

B. Độ lệch chuẩn (SD)

C. Khoảng giá trị lớn nhất – nhỏ nhất (range)

D. Trung vị (median)

(<2>) Trong 4 biến số của bảng số 1, biến có phân bố chuẩn nhất là:

A. Tuổi lần đầu tiên quan hệ tình dục

B. Số bạn tình từ trước đến thời điểm phỏng vấn

C. Số bạn tình trong vòng 4 tháng trở lại đây

D. Lần quan hệ tình dục gần đây nhất cách thời điểm phỏng vấn bao nhiêu tuần

(<3>) Dựa vào số liệu bảng 2 và giả định rằng lậu và chlamydia có bệnh kỳ là như nhau. Nhận định đúng về tỉ lệ mới mắc trong cộng đồng của hai bệnh này (biết rằng độ chênh của số hiện mắc = bệnh kỳ x số mới mắc) là:

A. Số mới mắc của bệnh lậu thấp hơn số này của nhiễm chlamydia.

B. Số mới mắc của bệnh lậu bằng số mới mắc chlamydia.

C. Số mới mắc của bệnh lậu cao hơn số mới mắc chlamydia

D. Không nhận định được từ số liệu trên

(<4>) Dựa vào số liệu bảng số 2 và giả định rằng lậu và chlamydia có số mới mắc bằng nhau, nhận định về bệnh kỳ 2 bệnh này (biết rằng độ chênh của số hiện mắc = bệnh kỳ x số mới mắc) hợp lý là:

A. Bệnh kỳ trung bình của lậu dài hơn chlamydia

B. Bệnh kỳ trung bình của lậu dài bằng chlamydia

C. Bệnh kỳ trung bình của lậu ngắn hơn chlamydia

D. Không nhận định được từ số liệu trên.

[
]

Case study - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<4>}) Trong một trường học của 1 huyện, 8,000 học sinh trung học bắt đầu năm học mới với tình trạng khỏe mạnh. 400 học sinh đã nghỉ học từ 10 ngày trở lên do bị hen cấp tính "AA-10" trong 9 tuần đầu tiên của quý đầu năm học. Dựa vào một điều tra được thiết kế tin cậy trong khoảng thời gian này cho thấy 15% học sinh trung học hút thuốc lá. Phỏng vấn những học sinh nghỉ học từ 10 ngày trở lên cho thấy 100 trong số đó là học sinh hiện có hút thuốc lá. Giả định rằng tỉ lệ nhập học không thay đổi theo thời gian

(<1>) Hãy trình bày kết quả của nghiên cứu trên vào bảng 2x2

	Hút thuốc	Không hút thuốc	Tổng
Nghỉ $\geq$ 10 ngày	a	b	
Nghỉ < 10 ngày	c	d	
Tổng			

Kết quả được trình bày ở bảng 2*2 đúng là:

A. a/b/c/d: 300/100/1100/6500

B. a/b/c/d: 100/300/6500/1100

C. a/b/c/d: 100/300/1100/6500

D. a/b/c/d: 300/100/6500/1100

(<2>) Tỷ lệ KHÔNG phải tỷ lệ nghỉ học ≥ 10 tích lũy của học sinh do hen cấp tính trong nhóm 8000 học sinh

A. 5%

B. 8.3%

C. 4.4%

D. Không tính được từ số liệu trên

(<3>) Đo lường thích hợp để lượng hóa độ mạnh kết hợp giữa hút thuốc lá và nghỉ học ≥ 10 ngày. Giá trị thể hiện độ mạnh của kết hợp này là:

A. 1.89

B. 2.0

C. 2.1

D. 2.2

(<4>) Giả định rằng hút thuốc lá có liên quan tới nghỉ học ≥ 10 ngày ở học sinh. Số trường hợp nghỉ học ≥ 10 mà do hút thuốc lá gây ra là:

A. 45

B. 46

C. 47

D. 48

[
]

(**Case study** - trả lời các câu hỏi từ {<1>} đến {<3>}) Trong 966 nam thanh niên trưởng thành tập trung tại một trung tâm giáo dục có 900 thanh niên đồng ý tham gia khám sàng lọc định kỳ STD sau khi họ ra khỏi trung tâm. ở mỗi lần sàng lọc, đối tượng được tư vấn về dự phòng STD và những trường hợp được phát hiện mắc STD sẽ được điều trị khỏi.

Bảng 3: Số ca mắc STD ở nam thanh niên sau khi ra khỏi trung tâm theo thời gian theo dõi

	Thời gian theo dõi (tháng)							
	3	6	9	12	15	18	21	24
Syphilis	0	1	0	3	1	2	3	4
Gonorrhea	10	8	15	21	11	12	19	24
Chlamydia	15	23	8	18	17	17	14	11
Bỏ cuộc (cộng dồn)	10	30	50	90	120	140	190	270
Số xét nghiệm	890	870	850	810	780	760	710	630

(Đối tượng có thể bị nhiễm cùng một loại tác nhân nhiều hơn 1 lần và hoặc đồng nhiễm nhiều tác nhân)

(<1>) Tỷ lệ hiện nhiễm chlamydia sau 12 tháng theo dõi là:

A. 2.2%

B. 2.3

C. 2.4

D. 2.5

(<2>) Mật độ mới mắc chlamydia trung bình trên 100 người năm và 100 người tháng trong vòng 2 năm theo dõi (Giả định rằng những trường hợp bỏ cuộc sẽ không có thời gian theo dõi ở lần cuối họ được xét nghiệm; các đối tượng nghiên cứu vẫn có nguy cơ nhiễm STD tiếp tục trong giai đoạn họ đang bị nhiễm) tính được là:

A. 0.65/100 người – tháng = 7.8/100 người - năm

B. 0.50/100 người – tháng = 7.8/100 người - năm

C. 0.60/100 người – tháng = 7.8/100 người - năm

D. 0.40/100 người – tháng = 7.8/100 người - năm

(<3>) Lý do KHÔNG giải thích cho việc sử dụng mật độ mới mắc thay cho số mới mắc trong nghiên cứu trên là:

A. Đối tượng có thể bị nhiều đợt nhiễm

B. Thời gian theo dõi cho mỗi đối tượng là khác nhau

C. Đối tượng có thể bị mắc bệnh ngoài khoảng thời gian quan sát

D. Mỗi ca đợt bệnh không cân nhắc đến khoảng thời gian phơi nhiễm

[
]

(**Case study** - trả lời câu hỏi{<1>}) Một nghiên cứu về nghiện rượu và trầm cảm đã tuyển chọn 100 có lạm dụng rượu tại một bệnh viện dành riêng cho các quân nhân. 100 ca chứng được chọn từ cùng bệnh viện. 76 ca nghiện rượu được chẩn đoán bị trầm cảm nặng và 20 trong nhóm chứng được chẩn đoán trầm cảm nặng.

(<1>) Những sai số không có thể gặp trong thiết kế trên dẫn đến ước lượng sai về kết hợp giữa nghiện rượu và trầm cảm là:

A. Sai số nhớ lại về mức độ sử dụng rượu

B. Tiền sử nghiện rượu ảnh hưởng tới chẩn đoán trầm cảm

C. Sai số chọn xảy ra vì cách chọn nhóm chứng không phù hợp

D. Nhóm nghiện rượu không cung cấp thông tin bằng nhóm chứng

[
]